

Buku Ajar **KELUARGA BERENCANA DAN PELAYANAN**

Indah Kusmindarti • Rizki Amalia • Dhiah Dwi Kusumawati
Erma Puspita Sari • Lida Khalimatus Sa'diya • Nur Saidah



BUKU AJAR

KELUARGA BERENCANA DAN PELAYANAN

Penulis:

Indah Kusmindarti, SST., Bdn., M.Kes.

Bdn. Rizki Amalia, SST., M.Kes.

Dhiah Dwi Kusumawati, S.ST., Bdn., MPH.

Erma Puspita Sari, SST., Bdn., M.Kes.

Lida Khalimatus Sa'diya, SSiT., Bdn., M.Kes.

Nur Saidah, S.SiT., Bdn., M.Kes.

BUKU AJAR KELUARGA BERENCANA DAN PELAYANAN

Penulis: Indah Kusmindarti, SST., Bdn., M.Kes.
Bdn. Rizki Amalia, SST., M.Kes.
Dhiah Dwi Kusumawati, S.ST., Bdn., MPH.
Erma Puspita Sari, SST., Bdn., M.Kes.
Lida Khalimatus Sa'diya, SSiT., Bdn., M.Kes.
Nur Saidah, S.SiT., Bdn., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7426-24-6

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Buku Ajar Keluarga Berencana dan Pelayanan ini disusun untuk memperkuat kompetensi mahasiswa dan praktisi kebidanan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan keluarga berencana yang berpusat pada keselamatan pasien, menghormati hak reproduksi, serta peka terhadap perspektif gender. Struktur buku mengikuti alur pembelajaran yang sistematis, dari landasan konseptual hingga keterampilan klinik, sehingga mudah digunakan dalam perkuliahan, praktik laboratorium, maupun layanan di fasilitas kesehatan. Dengan pendekatan tersebut, kami berharap buku ini menjadi rujukan yang relevan bagi pendidik, mahasiswa, bidan praktik, dan pengelola program.

Mengacu pada daftar isi, Bab 1 menguatkan perspektif kebidanan tentang keluarga berencana, tujuan dan manfaatnya, landasan filosofis-etik-hukum, peran bidan, serta hak reproduksi dan gender, termasuk tantangan dan peluang implementasi. Bab 2 memantapkan praktik berbasis bukti (evidence-based practice), mulai dari sumber bukti ilmiah, integrasi bukti dalam praktik, hingga keuntungan dan tantangan penerapannya. Bab 3 menguraikan jenis dan mekanisme kerja kontrasepsi hormonal dan non-hormonal beserta efek samping dan penyulitnya. Bab 4 menuntun analisis kriteria kelayakan penggunaan metode kontrasepsi, perencanaan yang rasional, paradigma pelayanan, pengembangan dan penggunaan rekomendasi kriteria layanan medis, serta penapisan klien melalui KLOP KB. Bab 5 merinci metode sederhana (alamiah), barrier, hormonal (steroid), mekanik, kimia, hingga pembedahan beserta cara kerja, indikasi, manfaat, dan risikonya. Bab 6 memfokuskan keterampilan konseling, mencakup definisi, tujuan, bentuk komunikasi, tahapan, langkah, faktor pendukung dan penghambat, serta metode, termasuk konseling KB. Bab 7 mengarahkan pada pemberian pelayanan kontrasepsi dengan metode sederhana, alami, modern, kontrasepsi darurat, serta pelayanan pasca aborsi (kondom, pil, suntik).

Untuk memudahkan pembelajaran aktif dan penilaian diri, setiap bab dilengkapi Latihan/Soal Latihan, Rangkuman Materi, Glosarium, serta Daftar Pustaka/Referensi sebagai rujukan lanjutan; di bagian akhir disertakan Profil Penulis. Terima kasih kami sampaikan kepada para kontributor, mitra institusi, dan seluruh pihak yang mendukung penyusunan naskah ini. Umpan balik pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan edisi berikutnya. Semoga buku ajar ini menjadi rujukan yang andal untuk mewujudkan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, berkeadilan, dan berbasis bukti dalam praktik kebidanan sehari-hari.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
--------------	-----

DAFTAR ISI.....	iv
-----------------	----

BAB 1 PERSPEKTIF KEBIDANAN PADA KONTRASEPSI DAN KELUARGA

BERENCANA (KB)	1
----------------------	---

A. Konsep Keluarga Berencana dari Perspektif Kebidanan	3
B. Tujuan dan Manfaat Keluarga Berencana	5
C. Landasan Filosofis, Etik, dan Hukum dalam Pelayanan KB	6
D. Peran Bidan dalam Keluarga Berencana	8
E. KB dalam Perspektif Hak Reproduksi dan Gender	9
F. Tantangan dan Peluang dalam Pelaksanaan KB	10
G. Latihan	12
H. Glosarium	15
I. Daftar Pustaka	16

BAB 2 EVIDENCE BASED DALAM KELUARGA BERENCANA (KB)

A. Konsep Evidence-Based Practice (EBP)	22
B. Sumber Bukti Ilmiah dalam Keluarga Berencana (KB)	23
C. Integrasi Bukti dalam Praktik Keluarga Berencana (KB)	24
D. Keuntungan <i>Evidence-Based Practice</i> (EBP) dalam Keluarga Berencana (KB)	25
E. Tantangan Implementasi Evidence-Based Practice (EBP) dalam Keluarga Berencana (KB)	26
F. Soal Latihan	27
G. Glosarium	30
H. Daftar Pustaka	30

BAB 3 JENIS DAN MEKANISME KERJA KB HORMONAL DAN NON HORMONAL SERTA EFEK SAMPING DAN PENYULITNYA.....

A. Jenis- jenis KB Hormonal.....	35
B. Mekanisme Kerja KB Hormonal	36
C. Konsep Dasar Efek Samping Kontrasepsi Hormonal	37

D. Jenis-Jenis Kontrasepsi Non-Hormonal.....	39
E. Mekanisme Kerja Kontrasepsi Non-Hormonal.....	40
F. Konsep Dasar Efek Samping Kontrasepsi Non-Hormonal.....	40
G. Latihan.....	42
H. Rangkuman Materi.....	43
I. Glosarium.....	44
J. Referensi.....	44

BAB 4 MENGANALISIS KRITERIA KELAYAKAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI, TERMASUK JANGKA WAKTU YANG SESUAI DALAM PENGGUNAAN KONTRASEPSI.....47

A. Tujuan Pelayanan Keluarga Berencana	49
B. Perencanaan Keluarga dan Penggunaan Kontrasepsi Yang Rasional.....	49
C. Paradigma Pelayanan Kesehatan KB dulu dan Sekarang	51
D. Kriteria Kelayakan Metode Kontrasepsi	51
E. Pengembangan Kriteria Kelayakan Medis Untuk Penggunaan Kontrasepsi.....	53
F. Penggunaan Rekomendasi Kriteria Kelayakan Medis Untuk Penggunaan....	54
G. Penapisan klien menggunakan kriteria kelayakan medis penggunaan kontrasepsi (KLOP KB).....	55
H. Latihan.....	59
I. Rangkuman Materi	61
J. Glosarium.....	61
K. References	62

BAB 5 METODE KONTRASEPSI SEDERHANA, BARRIER, STEROID, MEKANIK, KIMIA DAN PEMBEDAHAN, TERMASUK CARA KERJA, INDIKASI, MANFAAT DAN RISIKO63

A. Konsep Dasar Kontrasepsi	65
B. Kontrasepsi Sederhana	65
C. Macam-macam Kontrasepsi Sederhana tanpa alat (alamiah)	66
D. Macam-macam Kontrasepsi Sederhana dengan alat (barrier)	73
E. Metode Kontrasepsi dengan Pembedahan.....	75
F. Latihan.....	77
G. Rangkuman Materi	78
H. Glosarium.....	79

I. Daftar Pustaka	80
-------------------------	----

BAB 6 KONSELING KONTRASEPSI DENGAN METODE SEDERHANA ALAMI, MODERN DAN KONTRASEPSI DARURAT81

A. Definisi	83
B. Tujuan Konseling KB	83
C. Macam-Macam Bentuk Komunikasi	84
D. Bentuk-Bentuk Komunikasi	84
E. Tahapan Konseling KB.....	85
F. Langkah-langkah Konseling.....	86
G. Faktor pendukung keberhasilan konseling.....	87
H. Faktor penghambat keberhasilan konseling	88
I. Metode Konseling.....	89
J. Konseling KB.....	90
K. Latihan.....	93
L. Rangkuman Materi	94
M. Glosarium.....	95
N. Daftar Pustaka	95

BAB 7 MEMBERIKAN PELAYANAN KONTRASEPSI DENGAN METODE SEDERHANA, ALAMI, MODERN DAN KONTRASEPSI DARURAT. PELAYANAN KONTRASEPSI PASCA ABORSI (KONDOM, PIL, SUNTIK).....97

A. Konsep kontrasepsi Metode Sederhana.....	100
B. Konsep Kontrasepsi Alami	103
C. Konsep Kontrasepsi Modern.....	109
D. Kontrasepsi Darurat (Emergency Contraception).....	111
E. Pelayanan Kontrasepsi Pasca Aborsi (Kondom,Pil,Suntik).....	112
F. Latihan.....	113
G. Rangkuman Materi	115
H. Glosarium.....	116
I. Referensi.....	117

PROFIL PENULIS119

BAB 1

PERSPEKTIF KEBIDANAN PADA KONTRASEPSI DAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Pendahuluan

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, sekaligus mewujudkan kualitas keluarga yang sejahtera. Konsep KB tidak dapat dipisahkan dari bidang kebidanan, karena bidan berperan sebagai tenaga kesehatan lini terdepan dalam memberikan edukasi, konseling, pelayanan kontrasepsi, serta pemantauan berkelanjutan terhadap pasangan usia subur. Perspektif kebidanan dalam KB menekankan pentingnya pendekatan holistik, berkesinambungan, dan berpusat pada kebutuhan klien. Seorang bidan tidak hanya berperan dalam aspek teknis pemberian alat kontrasepsi, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis, sosial, dan kultural untuk memastikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan hak reproduksi, prinsip otonomi pasien, serta mendukung keberlangsungan kesehatan ibu dan anak.

Menurut WHO (2021), akses terhadap pelayanan KB yang komprehensif mampu mencegah hingga 30% kematian ibu dan 10% kematian anak balita. Di Indonesia, data BKKBN (2022) menunjukkan cakupan peserta KB aktif telah mencapai 63,4%, namun masih terdapat tantangan berupa ketidakmerataan akses, drop out pemakaian kontrasepsi, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang kontrasepsi jangka panjang. Kondisi ini menuntut bidan untuk memiliki perspektif yang lebih luas dalam memberikan pelayanan KB, bukan sekadar tindakan medis, tetapi juga meliputi advokasi, pemberdayaan, dan pendampingan keluarga. Melalui pembahasan pada Bab ini, mahasiswa kebidanan diharapkan mampu memahami perspektif kebidanan terkait KB, termasuk landasan filosofis, tujuan, manfaat, peran bidan, dan keterkaitannya dengan kesehatan reproduksi. Pemahaman yang kuat di awal ini akan menjadi fondasi penting sebelum mahasiswa mempelajari jenis-jenis kontrasepsi, mekanisme kerja, serta pelayanan teknis pada bab selanjutnya.

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami secara komprehensif perspektif kebidanan terhadap kontrasepsi dan keluarga berencana, serta mampu menjelaskan peran bidan dalam konteks pelayanan KB sebagai upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan konsep dasar keluarga berencana dari sudut pandang kebidanan.
2. Mendeskripsikan tujuan dan manfaat KB dalam konteks kesehatan ibu dan anak.
3. Menguraikan landasan filosofis, etik, dan hukum dalam pelayanan KB.
4. Menjelaskan peran bidan dalam memberikan konseling, pelayanan, dan advokasi kontrasepsi.
5. Menganalisis keterkaitan KB dengan hak kesehatan reproduksi, gender, dan pemberdayaan perempuan.
6. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan KB di Indonesia dari perspektif kebidanan.

Capaian Pembelajaran

Melalui pemahaman Bab ini, mahasiswa akan mencapai capaian pembelajaran antara lain:

1. Sikap

Menunjukkan sikap profesional, empati, menghargai hak reproduksi, serta menjunjung tinggi etika kebidanan dalam pelayanan KB.

2. Pengetahuan

Memahami konsep, tujuan, manfaat, peran, serta perspektif kebidanan dalam pelayanan kontrasepsi dan keluarga berencana.

3. Keterampilan Umum

Mampu mengkomunikasikan ide dan konsep KB secara jelas kepada masyarakat, serta melakukan advokasi yang relevan.

4. Keterampilan Khusus

Mampu melakukan analisis sederhana terhadap isu-isu KB di lapangan, dan merancang pendekatan kebidanan yang tepat sesuai konteks budaya dan sosial masyarakat.

A. Konsep Keluarga Berencana dari Perspektif Kebidanan

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi yang bertujuan tidak hanya untuk mengendalikan fertilitas, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh. KB memberikan kesempatan bagi pasangan usia subur untuk merencanakan jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak sesuai dengan kondisi kesehatan, sosial, ekonomi, dan psikologis keluarga (WHO, 2021). Beberapa definisi menurut sumber resmi:

1. Menurut BKKBN, 2022

Keluarga Berencana merupakan strategi pembangunan nasional untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pengaturan jumlah anak dan jarak kelahiran yang optimal.

2. Menurut Kemenkes RI, 2021

Keluarga Berencana adalah program kesehatan yang melibatkan edukasi, konseling, dan layanan kontrasepsi untuk mendukung kesehatan ibu, anak, dan keluarga.

Dari perspektif kebidanan, KB dipandang sebagai upaya promotif dan preventif dalam kesehatan reproduksi. Seorang bidan tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan kontrasepsi, tetapi juga dalam memastikan bahwa setiap keputusan mengenai reproduksi dibuat secara sadar, bertanggung jawab, dan sesuai dengan hak reproduksi individu (Nurhayati, 2020). Dengan demikian, KB merupakan bagian integral dari pendekatan *continuity of care*, yaitu pelayanan kebidanan yang berkesinambungan mulai dari masa pranikah, kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, hingga perencanaan keluarga (Astuti, 2021).

Konsep KB dalam kebidanan dapat dijelaskan melalui beberapa aspek :

1. KB sebagai bagian dari kesehatan reproduksi

KB tidak hanya berorientasi pada pencegahan kehamilan, melainkan juga pada peningkatan kesehatan ibu dan anak. Jarak kehamilan yang ideal terbukti mampu menurunkan risiko komplikasi obstetri, mengurangi angka kematian ibu (AKI), serta menekan angka kematian bayi (AKB) (Kemenkes RI, 2021). Bidan memandang KB sebagai intervensi penting untuk mendukung keberlangsungan hidup ibu dan anak.

2. KB sebagai bentuk pemberdayaan Perempuan

Salah satu perspektif penting dalam kebidanan adalah melihat KB sebagai alat pemberdayaan perempuan. Dengan adanya akses terhadap KB, perempuan memiliki kendali lebih besar atas tubuh dan kehidupan reproduksinya. Hal ini sejalan dengan prinsip hak reproduksi, di mana setiap individu berhak menentukan kapan dan berapa jumlah anak yang ingin dimiliki tanpa adanya paksaan (BKKBN, 2022).

3. KB sebagai pendekatan *holistic*

Bidan memandang KB tidak hanya dari sisi medis, tetapi juga dari aspek psikososial, budaya, dan ekonomi. Misalnya, dalam masyarakat yang masih menganut budaya patriarki, bidan berperan sebagai fasilitator untuk mendorong kesetaraan *gender* dalam pengambilan keputusan mengenai KB. Dengan demikian, pendekatan bidan selalu menekankan pentingnya komunikasi, empati, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang ada (Mubarak & Chayatin, 2019).

4. KB sebagai strategi pembangunan kesehatan

Dari perspektif kebidanan, KB juga merupakan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Dengan menekan angka kelahiran yang tidak direncanakan, program KB mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, penurunan beban ekonomi keluarga, serta mendukung tercapainya bonus demografi (BKKBN, 2022).

5. Peran bidan dalam mengintegrasikan konsep KB

Bidan sebagai tenaga kesehatan lini terdepan memiliki peran strategis dalam:

- a. Edukasi dan Konseling
Memberikan informasi berbasis bukti terkait pilihan metode kontrasepsi.
- b. Pelayanan teknis kontrasepsi
Membantu klien dalam memilih, menggunakan, dan memantau kontrasepsi sesuai kondisi kesehatan.
- c. Advokasi hak reproduksi
Memastikan klien mendapat pelayanan KB yang sesuai prinsip etika dan hak reproduksi.
- d. Pendampingan keluarga
Mendukung pasangan usia subur untuk mencapai keluarga yang sehat, sejahtera, dan berdaya (Kemenkes RI, 2021).

Dengan demikian, konsep KB dari perspektif kebidanan menempatkan bidan tidak sekadar sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pendidik, konselor, advokat, dan agen pemberdayaan masyarakat. Perspektif inilah yang membedakan pelayanan KB berbasis kebidanan dengan pendekatan medis semata.

B. Tujuan dan Manfaat Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi kesehatan masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada pengendalian kelahiran, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara menyeluruh. Menurut WHO (2021), tujuan utama KB adalah memungkinkan pasangan untuk merencanakan jumlah anak, jarak kelahiran, serta waktu yang tepat untuk memiliki anak, sehingga mendukung kesehatan ibu, anak, dan keluarga.

1. Tujuan Keluarga Berencana

- a. Tujuan Jangka Pendek
 - 1) Menunda kehamilan pada pasangan yang baru menikah agar pasangan memiliki waktu mempersiapkan kesehatan fisik, mental, dan ekonomi (Astuti, 2021).
 - 2) Menjarangkan kehamilan sehingga ibu memiliki waktu pemulihan pasca melahirkan dan anak sebelumnya mendapatkan perhatian penuh, terutama dalam hal gizi dan pengasuhan (Mubarak & Chayatin, 2019).
 - 3) Menghentikan kehamilan bagi pasangan yang sudah merasa cukup jumlah anak, sesuai dengan prinsip tanggung jawab keluarga dan kondisi sosial ekonomi (BKKBN, 2022).
- b. Tujuan Jangka Panjang
 - 1) Meningkatkan kualitas keluarga, yaitu menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, mandiri, dan mampu memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya (Nurhayati, 2020).
 - 2) Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, karena kehamilan yang tidak direncanakan seringkali meningkatkan risiko komplikasi obstetri (Kemenkes RI, 2021).
 - 3) Mendukung pembangunan berkelanjutan, melalui pengendalian jumlah penduduk sehingga tercapai keseimbangan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan sumber daya (WHO, 2021).

2. Manfaat Keluarga Berencana

- a. Bagi Ibu dan Anak
 - 1) Mengurangi risiko kehamilan 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jaraknya, dan terlalu banyak anak).
 - 2) Memberi waktu istirahat bagi organ reproduksi sehingga dapat menurunkan risiko komplikasi obstetri, anemia, dan perdarahan (Kemenkes RI, 2021).
 - 3) Meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif dan pemenuhan gizi anak.
- b. Bagi Keluarga

- 1) Memberikan kesempatan bagi orang tua untuk mengoptimalkan pendidikan dan pengasuhan anak (BKKBN, 2022).
 - 2) Meningkatkan kesejahteraan keluarga karena sumber daya ekonomi dapat lebih terarah.
 - 3) Mengurangi beban psikologis orang tua dalam mengasuh anak terlalu banyak.
- c. Bagi Masyarakat dan Negara
- 1) Mendukung tercapainya bonus demografi, yaitu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif (BKKBN, 2022).
 - 2) Menekan angka kemiskinan dan pengangguran akibat ledakan penduduk.
 - 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) karena generasi muda lebih sehat, berpendidikan, dan produktif (Nurhayati, 2020).
 - 4) Membantu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terutama pada pilar kesehatan, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan (UNFPA, 2019).

C. Landasan Filosofis, Etik, dan Hukum dalam Pelayanan KB

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) oleh bidan tidak hanya berorientasi pada aspek medis, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip filosofis, etik, dan hukum. Ketiga aspek ini menjadi pijakan penting agar pelayanan KB yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya aman dan efektif, tetapi juga sesuai dengan nilai kemanusiaan serta aturan perundang-undangan.

1 Landasan Filosofis

Secara filosofis, KB dipandang sebagai hak asasi manusia dalam mengatur jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak. Setiap individu, khususnya perempuan, memiliki hak untuk menentukan pilihan reproduksinya secara bebas, bertanggung jawab, dan tanpa paksaan (WHO, 2021).

- a. KB dilihat sebagai bentuk tanggung jawab keluarga terhadap masa depan anak, di mana orang tua dapat memastikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang lebih baik
- b. Filosofi pelayanan KB juga sejalan dengan tujuan kesejahteraan keluarga, yaitu menciptakan keluarga sehat, mandiri, dan produktif
- c. Dalam perspektif kebidanan, landasan filosofis ini menegaskan bahwa bidan harus memandang KB sebagai bagian dari continuity of care dan pemberdayaan perempuan (Astuti, 2021).

2 Landasan Etik

Pelayanan KB oleh bidan harus mengikuti kode etik kebidanan dan prinsip etika profesi kesehatan. Beberapa prinsip utama meliputi:

a. *Autonomy* (Otonomi)

Bidan wajib menghormati keputusan klien dalam memilih atau menolak metode kontrasepsi, tanpa adanya tekanan atau diskriminasi

b. *Beneficence* (Berbuat Baik)

Pelayanan KB harus bertujuan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesehatan ibu, anak, dan keluarga

c. *Non-Maleficence* (Tidak Merugikan)

Bidan harus menghindari tindakan yang dapat menimbulkan risiko atau efek samping yang membahayakan klien.

d. *Justice* (Keadilan)

Pelayanan KB harus diberikan secara adil, merata, dan tidak diskriminatif, baik dari segi gender, status sosial, maupun agama (Mubarak & Chayatin, 2019).

e. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Informasi kesehatan reproduksi dan data pribadi klien wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan prinsip etik dan hukum kesehatan.

3 Landasan Hukum

Pelayanan KB di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas untuk melindungi hak dan kewajiban klien maupun tenaga kesehatan. Beberapa regulasi penting antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang menegaskan bahwa keluarga berencana merupakan hak setiap warga negara.

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menekankan penyediaan pelayanan KB sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan reproduksi.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang mengatur secara lebih teknis hak-hak reproduksi, termasuk akses terhadap KB yang aman dan berkualitas.

d. Regulasi teknis Kemenkes dan BKKBN, misalnya pedoman standar pelayanan KB, yang menjadi acuan bagi bidan dan tenaga kesehatan dalam praktik lapangan.

Dengan adanya landasan hukum, setiap pelayanan KB yang diberikan bidan tidak hanya sah secara medis, tetapi juga terlindungi secara legal, sehingga hak-hak klien lebih terjamin (Kemenkes RI, 2021; BKKBN, 2022).

D. Peran Bidan dalam Keluarga Berencana

Bidan memegang peran sentral dalam program Keluarga Berencana (KB), terutama sebagai tenaga kesehatan lini terdepan di pelayanan primer. Keberhasilan program KB di Indonesia sangat bergantung pada kualitas dan komitmen bidan dalam memberikan pelayanan yang komprehensif, bermutu, serta berlandaskan pada prinsip etika dan hak asasi manusia. Menurut Kemenkes RI (2021), lebih dari 60% layanan KB di fasilitas kesehatan dasar, terutama di daerah pedesaan, diberikan oleh bidan. Hal ini menjadikan bidan sebagai ujung tombak keberhasilan program KB nasional. Beberapa peran bidan dalam berbagai aspek:

1 Peran Bidan dalam Pendidikan & Konseling

- a. Memberikan edukasi berbasis bukti mengenai kesehatan reproduksi dan metode kontrasepsi, sehingga klien dapat membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab
- b. Membongkar mitos dan mispersepsi tentang kontrasepsi, misalnya isu kemandulan atau efek negatif yang tidak terbukti
- c. Melakukan konseling individual maupun kelompok dengan pendekatan komunikatif, empatik, dan non-diskriminatif
- d. Menyediakan informasi yang lengkap tentang keuntungan, keterbatasan, dan efek samping dari berbagai metode kontrasepsi. (Nurhayati, 2020).

2 Peran Bidan dalam Pelayanan Kontrasepsi

- a. Melakukan tindakan medis sesuai kompetensi, seperti pemasangan dan pelepasan kontrasepsi (pil, suntik, implant, IUD, dan kondom).
- b. Memberikan layanan kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan klien.
- c. Memberikan pelayanan kontrasepsi pascapersalinan dan pascakeguguran, yang merupakan momen penting dalam pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan (BKKBN, 2022).

3 Peran Bidan dalam Pemantauan & Evaluasi

- a. Melakukan pemantauan keberlanjutan penggunaan kontrasepsi melalui kunjungan ulang atau *home visit*.
- b. Mendeteksi secara dini adanya efek samping atau komplikasi dari penggunaan kontrasepsi, serta memberikan solusi atau rujukan jika diperlukan
- c. Mengevaluasi kepuasan klien terhadap pelayanan kontrasepsi yang diberikan dan melakukan perbaikan mutu layanan secara berkesinambungan. (WHO, 2021).

4 Peran Bidan dalam Advokasi & Pemberdayaan

- a. Mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan reproduksi, sehingga meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri mereka
- b. Melibatkan laki-laki dalam program KB untuk membangun kesetaraan *gender* dalam tanggung jawab pengaturan keluarga
- c. Berperan sebagai advokat kesehatan masyarakat, dengan menyuarakan pentingnya KB bagi peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan berkelanjutan. (Nurhayati, 2020).

Peran bidan dalam KB mencakup aspek pendidikan, pelayanan, pemantauan, dan advokasi. Dengan kapasitas sebagai tenaga kesehatan terdepan, bidan tidak hanya bertugas secara teknis dalam memberikan kontrasepsi, tetapi juga sebagai pendidik, konselor, pemberdaya, dan penggerak masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme bidan sangat penting untuk mendukung keberhasilan program KB dan pembangunan kesehatan secara keseluruhan. (Nurhayati, 2020).

E. KB dalam Perspektif Hak Reproduksi dan Gender

Hak reproduksi merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kebebasan untuk menentukan secara sadar, bebas, dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, serta waktu kelahiran anak. Hak ini juga mencakup akses terhadap informasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi, paksaan, maupun kekerasan (WHO, 2019).

Dalam praktik di banyak komunitas, pengambilan keputusan mengenai penggunaan kontrasepsi masih sering didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan gender, di mana perempuan sering kali tidak memiliki ruang penuh untuk menentukan pilihan terkait tubuh dan kesehatan reproduksinya sendiri (Nurhayati, 2020). Dominasi laki-laki dalam keputusan keluarga berencana dapat berdampak pada keterbatasan perempuan dalam mengakses metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatannya.

Dari perspektif gender, program KB tidak hanya dipahami sebagai intervensi kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian, keberhasilan program KB tidak hanya diukur dari menurunnya angka kelahiran, tetapi juga dari meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta berkurangnya diskriminasi berbasis gender dalam keluarga maupun masyarakat (Susanto & Fajriani, 2021).

Peran bidan menjadi sangat penting dalam mendorong kesetaraan gender dalam layanan KB. Bidan tidak hanya bertugas memberikan pelayanan medis, tetapi juga berperan sebagai fasilitator komunikasi suami-istri, penengah perbedaan pandangan dalam keluarga, serta advokat untuk memastikan hak-hak reproduksi perempuan tetap terlindungi. Melalui pendekatan ini, bidan dapat membantu pasangan untuk membuat keputusan yang setara, saling menghargai, dan sesuai dengan kebutuhan bersama (Wahyuni, 2022). Selain itu, perspektif gender dalam KB menekankan bahwa penggunaan kontrasepsi seharusnya menjadi sarana pemberdayaan perempuan. Dengan memiliki kendali atas kesehatan reproduksinya, perempuan dapat lebih leluasa dalam mengatur rencana hidup, pendidikan, dan karier. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kesehatan reproduksi merupakan pintu masuk bagi peningkatan kualitas hidup perempuan, keluarga, dan masyarakat secara luas (Kemenkes RI, 2021).

Dengan demikian, mengintegrasikan perspektif hak reproduksi dan gender dalam program KB merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga pada pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan.

F. Tantangan dan Peluang dalam Pelaksanaan KB

Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, namun juga memiliki peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keberhasilan program.

1 Tantangan dalam Pelaksanaan KB:

a. Ketidakmerataan akses di wilayah terpencil

Masyarakat di daerah pedalaman atau wilayah kepulauan sering mengalami keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis terlatih. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam pemanfaatan layanan KB dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Keterbatasan transportasi, distribusi alat kontrasepsi, dan minimnya tenaga kesehatan terlatih menjadi kendala yang signifikan (Kemenkes RI, 2021).

b. Tingginya angka *drop out* KB

Banyak akseptor KB yang tidak melanjutkan penggunaan kontrasepsi karena berbagai faktor, seperti efek samping yang dirasakan, kurangnya informasi, atau ketidakpuasan terhadap metode tertentu. Hal ini menimbulkan masalah keberlanjutan dalam penggunaan KB, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya angka kehamilan tidak direncanakan (BKKBN, 2022).

c. Mitos seputar kontrasepsi

Berbagai mitos masih berkembang di masyarakat, seperti anggapan bahwa kontrasepsi dapat menyebabkan infertilitas permanen, kanker, atau gangguan hormonal. Mispersepsi ini memengaruhi keputusan pasangan usia subur untuk menggunakan kontrasepsi, terutama di wilayah dengan literasi kesehatan yang rendah (Handayani, 2018).

d. Resistensi budaya dan nilai sosial

Dalam beberapa budaya, memiliki banyak anak masih dianggap sebagai simbol status sosial dan sumber kekuatan keluarga. Pandangan ini sering menjadi penghalang dalam implementasi KB, terutama di masyarakat yang menempatkan anak sebagai penopang ekonomi keluarga di masa depan (Suyanto, 2019).

2 Peluang dalam Pelaksanaan KB :

a. Meningkatnya dukungan kebijakan pemerintah

Pemerintah Indonesia melalui BKKBN terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan KB. Hal ini terlihat dalam berbagai program nasional seperti Bangga Kencana yang menekankan pentingnya keluarga kecil berkualitas sebagai dasar pembangunan bangsa (BKKBN, 2022).

b. Inovasi teknologi kontrasepsi

Perkembangan teknologi kesehatan melahirkan metode kontrasepsi yang lebih modern, efektif, dan minim efek samping. Misalnya, implan generasi baru yang lebih praktis, serta IUD modern yang lebih nyaman digunakan. Inovasi ini membuka peluang besar dalam meningkatkan kepuasan akseptor dan menekan angka *drop out* (WHO, 2020).

c. Keterlibatan organisasi profesi

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai organisasi profesi turut berperan penting dalam memperkuat pelayanan KB, terutama melalui peningkatan kapasitas tenaga bidan, edukasi masyarakat, serta advokasi kebijakan. Peran bidan sebagai tenaga kesehatan lini terdepan membuat mereka memiliki posisi strategis dalam mendorong keberhasilan KB (IBI, 2021).

d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan reproduksi

Perubahan pola pikir generasi muda, terutama di perkotaan, menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Kesadaran ini menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan program KB jangka panjang (Mubarak & Chayatin, 2019).

Dengan mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang tersebut, bidan dapat menjadi motor penggerak utama dalam keberhasilan program KB di

Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, serta masyarakat luas menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga kecil yang sehat, sejahtera, dan berkualitas.

G. Latihan

Soal Pilihan Ganda (15 soal)

1. Menurut WHO (2021), akses terhadap pelayanan KB yang komprehensif mampu mencegah hingga ...
 - A. 10% kematian ibu dan 30% kematian anak balita
 - B. 30% kematian ibu dan 10% kematian anak balita
 - C. 20% kematian ibu dan 15% kematian anak balita
 - D. 25% kematian ibu dan 20% kematian anak balita
2. Konsep KB dari perspektif kebidanan menekankan pada ...
 - A. Upaya pengendalian fertilitas semata
 - B. Pemberdayaan perempuan, continuity of care, dan pendekatan holistik
 - C. Penekanan pada kontrasepsi jangka panjang
 - D. Pendekatan medis dan teknis belaka
3. Yang termasuk tujuan jangka pendek KB adalah ...
 - A. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
 - B. Mendukung pembangunan berkelanjutan
 - C. Menunda, menjarangkan, atau menghentikan kehamilan
 - D. Mencapai bonus demografi
4. Risiko kehamilan 4T yang dapat ditekan melalui KB, kecuali ...
 - A. Terlalu muda
 - B. Terlalu dekat
 - C. Terlalu sering
 - D. Terlalu sehat
5. Salah satu manfaat KB bagi keluarga adalah ...
 - A. Mengurangi risiko anemia pada ibu
 - B. Memberikan kesempatan orang tua mengoptimalkan pendidikan anak
 - C. Mendukung pencapaian SDGs
 - D. Mengurangi angka pengangguran
6. Landasan filosofis dalam pelayanan KB menekankan bahwa ...

- A. KB adalah kewajiban negara untuk menekan jumlah penduduk
 - B. KB merupakan hak asasi manusia dalam mengatur reproduksi
 - C. KB semata-mata alat pengendalian kelahiran
 - D. KB tidak terkait dengan hak reproduksi
7. Prinsip etik dalam pelayanan KB yang berarti menghormati pilihan klien adalah..
- A. Justice
 - B. Autonomy
 - C. Beneficence
 - D. Confidentiality
8. Landasan hukum utama KB di Indonesia diatur dalam ...
- A. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - B. UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
 - C. PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
 - D. Semua benar
9. Peran bidan dalam konseling KB mencakup ...
- A. Memaksakan metode kontrasepsi pada klien
 - B. Memberikan edukasi berbasis bukti dan membongkar mitos kontrasepsi
 - C. Hanya memberikan pelayanan kontrasepsi hormonal
 - D. Menentukan metode kontrasepsi tanpa persetujuan klien
10. Menurut Kemenkes (2021), lebih dari ... layanan KB di fasilitas kesehatan dasar diberikan oleh bidan.
- A. 30%
 - B. 40%
 - C. 60%
 - D. 80%
11. Hak reproduksi dalam KB menegaskan bahwa setiap individu berhak ...
- A. Menentukan jumlah dan jarak kelahiran secara bebas dan bertanggung jawab
 - B. Mengikuti aturan pemerintah dalam menentukan jumlah anak
 - C. Menggunakan kontrasepsi tanpa konsultasi
 - D. Menyerahkan sepenuhnya pada pihak laki-laki
12. Dalam perspektif gender, salah satu tantangan KB adalah ...

- A. Kesadaran masyarakat akan kesehatan reproduksi meningkat
 - B. Keputusan penggunaan KB masih sering didominasi laki-laki
 - C. Perempuan memiliki kendali penuh atas kontrasepsi
 - D. Dukungan organisasi profesi bidan sangat kuat
13. Mitos yang sering beredar di masyarakat tentang kontrasepsi adalah ...
- A. Kontrasepsi membuat infertilitas permanen
 - B. Kontrasepsi dapat menurunkan risiko kehamilan 4T
 - C. Kontrasepsi mendukung kesehatan reproduksi
 - D. Kontrasepsi meningkatkan kualitas hidup keluarga
14. Peluang dalam pelaksanaan KB di Indonesia, kecuali ...
- A. Dukungan kebijakan pemerintah yang kuat
 - B. Inovasi teknologi kontrasepsi modern
 - C. Resistensi budaya yang masih tinggi
 - D. Keterlibatan organisasi profesi bidan
15. Bonus demografi dapat tercapai melalui ...
- A. Menekan angka kelahiran dengan KB
 - B. Membatasi akses layanan kesehatan
 - C. Mengurangi jumlah tenaga kesehatan
 - D. Mengabaikan program pemberdayaan Perempuan

Soal Esai (5 soal)

1. Jelaskan konsep KB dari perspektif kebidanan dan bagaimana bidan mengintegrasikannya dalam pelayanan kesehatan!
2. Uraikan perbedaan tujuan jangka pendek dan jangka panjang program KB, sertakan contohnya!
3. Mengapa landasan filosofis, etik, dan hukum penting dalam pelayanan KB oleh bidan? Jelaskan dengan contoh nyata!
4. Sebutkan dan jelaskan peran bidan dalam mendukung keberhasilan program KB di masyarakat!
5. Analisislah tantangan dan peluang dalam pelaksanaan KB di Indonesia, serta strategi apa yang dapat dilakukan bidan untuk mengatasinya!

Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

1. b
2. b
3. c
4. d
5. b
6. b
7. b
8. d
9. b
10. c
11. a
12. b
13. a
14. c
15. a

H. Glosarium

Angka Kematian Ibu (AKI): Jumlah kematian ibu selama kehamilan, persalinan, atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB): Jumlah kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup.

Bidan : Tenaga kesehatan profesional yang memberikan pelayanan kebidanan mulai dari pranikah, kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, hingga perencanaan keluarga.

Continuity of Care: Pendekatan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dari pranikah hingga KB pasca persalinan, untuk memastikan kesehatan ibu dan anak optimal.

Hak Reproduksi: Hak setiap individu untuk menentukan secara bebas, sadar, dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak serta mengakses pelayanan kesehatan reproduksi.

Keluarga Berencana (KB): Strategi nasional dan layanan kesehatan untuk mengatur jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak, meningkatkan kualitas hidup keluarga, serta mendukung kesehatan ibu dan anak.

Metode Kontrasepsi: Berbagai cara atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan, termasuk kontrasepsi hormonal (pil, suntik, implan) dan kontrasepsi non-hormonal (IUD, kondom).

Otonomi Pasien: Hak klien untuk membuat keputusan sendiri mengenai pelayanan kesehatan reproduksinya, tanpa tekanan atau diskriminasi.

Pemberdayaan Perempuan: Proses meningkatkan kapasitas perempuan untuk mengambil keputusan mengenai tubuh, reproduksi, pendidikan, dan kehidupan sosial-ekonomi.

Pendekatan Holistik: Pendekatan pelayanan KB yang mempertimbangkan aspek medis, psikososial, budaya, dan ekonomi klien.

Perspektif Gender: Analisis dan pendekatan yang memastikan kesetaraan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam pengambilan keputusan KB.

Program KB Nasional Bangsa Kencana: Program pemerintah Indonesia yang menekankan pentingnya keluarga kecil berkualitas sebagai dasar pembangunan bangsa.

Resistensi Budaya: Penolakan atau hambatan dalam penerapan KB karena norma, nilai, atau tradisi masyarakat yang menilai anak sebagai simbol status atau sumber ekonomi keluarga.

Tenaga Kesehatan Lini Terdepan: Tenaga kesehatan, khususnya bidan, yang berada di garda depan pelayanan masyarakat untuk edukasi, konseling, dan layanan KB.

I. Daftar Pustaka

- Astuti, W. (2021). *Continuity of care dalam praktik kebidanan*. Pustaka Baru Press.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2022). Laporan tahunan program keluarga berencana nasional. <https://www.bkkbn.go.id>
- Handayani, L. (2018). *Mitos dan fakta kontrasepsi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Ikatan Bidan Indonesia (IBI). (2021). Laporan tahunan program penguatan peran bidan dalam pelayanan KB.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2021). Profil kesehatan Indonesia 2021. <https://www.kemkes.go.id>
- Mubarak, W. I., & Chayatin, N. (2019). *Promosi kesehatan untuk kebidanan*. Salemba Medika.
- Nurhayati, T. (2020). *Hak reproduksi dan kesehatan perempuan*. Refika Aditama.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- Susanto, H., & Fajriani, R. (2021). Perspektif gender dalam kebijakan keluarga berencana di Indonesia. *Jurnal Gender dan Pembangunan*, 6(1), 23–34.
- Suyanto, B. (2019). *Sosiologi keluarga: Perspektif sosiologi tentang keluarga, anak, dan gender*. Prenadamedia.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- UNFPA. (2019). State of world population 2019: Unfinished business. United Nations Population Fund.
- Wahyuni, S. (2022). Peran bidan dalam mewujudkan hak reproduksi perempuan melalui pelayanan KB. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 14(1), 55–64.
- World Health Organization (WHO). (2019). Sexual and reproductive health and rights: An essential element of universal health coverage. <https://www.who.int>
- World Health Organization (WHO). (2020). Family planning: A global handbook for providers. <https://www.who.int>
- World Health Organization (WHO). (2021). Family planning/contraception. <https://www.who.int>

BAB 2

EVIDENCE BASED DALAM KELUARGA BERENCANA (KB)

Pendahuluan

Evidence-Based Practice (EBP) dalam Keluarga Berencana (KB) merupakan pendekatan pelayanan yang menekankan pengambilan keputusan berbasis bukti ilmiah terkini, pengalaman profesional, serta preferensi dan nilai-nilai klien (Sackett et al., 2000; Melnyk & Fineout-Overholt, 2019). Konsep ini muncul sebagai respons terhadap tantangan dalam praktik kesehatan, di mana keputusan sering kali hanya didasarkan pada kebiasaan, opini, atau pengalaman subjektif, tanpa mempertimbangkan data dan penelitian yang valid. Dalam konteks KB, EBP menjadi sangat penting karena keputusan terkait metode kontrasepsi atau intervensi perencanaan keluarga memiliki implikasi langsung terhadap kesehatan ibu, bayi, dan keluarga secara keseluruhan. Misalnya, pemilihan metode kontrasepsi yang sesuai dapat mencegah kehamilan tidak diinginkan, mengurangi risiko komplikasi kehamilan, dan mendukung kesejahteraan psikososial klien (WHO, 2020). Dengan menerapkan praktik berbasis bukti, tenaga kesehatan dapat memberikan rekomendasi yang lebih aman, efektif, dan sesuai dengan kondisi medis serta kebutuhan individual klien.

Selain itu, EBP berperan dalam menanggulangi mitos dan informasi yang salah mengenai kontrasepsi. Masyarakat sering menerima informasi keliru terkait efek samping metode KB, yang dapat menimbulkan penolakan terhadap program KB (Handayani, 2018; Suyanto, 2019). Dengan mengacu pada bukti ilmiah dan pedoman resmi, bidan dan tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi yang tepat, berbasis fakta, dan berbasis hak reproduksi. Hal ini sejalan dengan prinsip hak klien untuk membuat keputusan yang diinformasikan (Nurhayati, 2020). Selain manfaat klinis dan edukatif, EBP juga meningkatkan kepuasan dan partisipasi klien dalam program KB. Klien yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dengan informasi yang akurat dan berbasis bukti, cenderung lebih patuh pada rencana kontrasepsi dan merasakan pelayanan yang lebih adil dan aman (Mubarak & Chayatin, 2019). Praktik berbasis bukti ini juga mendukung pencapaian sasaran kependudukan nasional, seperti pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, dan pengurangan angka kematian ibu dan bayi (BKKBN, 2022; Kemenkes RI, 2021).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan KB, penerapan EBP menuntut tenaga kesehatan untuk memiliki kompetensi literasi penelitian, kemampuan menilai kualitas bukti, serta kemampuan komunikasi yang efektif dengan klien. Tenaga kesehatan diharapkan mampu mengintegrasikan bukti ilmiah dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi klien, sehingga intervensi KB tidak hanya efektif secara klinis tetapi juga relevan dan diterima oleh masyarakat (UNFPA, 2019; WHO, 2021). Dengan demikian, EBP dalam KB bukan sekadar teori, tetapi merupakan kerangka kerja praktis yang menjembatani penelitian ilmiah, praktik profesional, dan preferensi klien. Pendekatan ini membantu mewujudkan pelayanan KB yang berkualitas, adil, aman, dan berbasis hak, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan keberhasilan program kependudukan.

Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari BAB II ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menerapkan, dan mengevaluasi praktik Keluarga Berencana berbasis bukti ilmiah dalam pelayanan kebidanan.

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari BAB ini, mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan konsep *Evidence-Based Practice* (EBP) dalam KB.
2. Mengidentifikasi sumber bukti ilmiah yang dapat digunakan dalam praktik KB.
3. Menerapkan prinsip EBP dalam memilih metode kontrasepsi sesuai kebutuhan dan kondisi klien.
4. Mengevaluasi efektivitas pelayanan KB berdasarkan bukti ilmiah dan hasil monitoring program.
5. Mengintegrasikan preferensi klien dalam pengambilan keputusan berbasis bukti.

Capaian Pembelajaran

Sikap

1. Mahasiswa menghargai pentingnya praktik berbasis bukti (EBP) dalam pelayanan Keluarga Berencana.
2. Mahasiswa menunjukkan komitmen terhadap penerapan hak reproduksi klien dalam pengambilan keputusan KB.

Pengetahuan

1. Mahasiswa dapat mendeskripsikan konsep dan prinsip *Evidence-Based Practice* (EBP) dalam konteks KB.
2. Mahasiswa dapat menilai kualitas bukti ilmiah yang relevan untuk praktik KB.

Keterampilan Umum

1. Mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan EBP ke dalam proses pengambilan keputusan dalam pelayanan KB.
2. Mahasiswa dapat berkomunikasi secara efektif mengenai rekomendasi KB berbasis bukti kepada klien dan keluarga.

Keterampilan Khusus

1. Mahasiswa dapat merancang rencana pelayanan KB berbasis bukti ilmiah dan hak reproduksi klien.
2. Mahasiswa mampu menyesuaikan rekomendasi metode kontrasepsi sesuai kebutuhan, kondisi kesehatan, dan preferensi klien.

A. Konsep Evidence-Based Practice (EBP)

Evidence-Based Practice (EBP) merupakan pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan klinis yang mengintegrasikan tiga komponen utama: bukti ilmiah terbaik dari penelitian terkini, pengalaman klinis profesional, dan preferensi serta nilai-nilai klien (Sackett et al., 2000). EBP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memastikan bahwa setiap intervensi atau rekomendasi klinis berdasarkan bukti yang valid, relevan, dan dapat diterapkan secara praktis.

Dalam konteks KB, EBP memiliki peran penting dalam memastikan metode kontrasepsi yang diberikan aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi kesehatan klien. Praktik berbasis bukti membantu tenaga kesehatan, khususnya bidan dan konselor KB, untuk :

- a. Memilih metode kontrasepsi yang efektif: Memastikan bahwa rekomendasi metode kontrasepsi didasarkan pada bukti ilmiah terkait efektivitas, keamanan, dan kemungkinan efek samping (Glasier et al., 2016).
- b. Mengatasi mitos dan informasi keliru: Memberikan informasi yang akurat kepada klien untuk melawan mitos atau kesalahpahaman terkait kontrasepsi (Hubacher & Grimes, 2002).
- c. Menyesuaikan layanan dengan preferensi klien: Mengintegrasikan nilai dan kebutuhan individu, termasuk faktor budaya, sosial, dan agama, sehingga pelayanan KB menjadi lebih responsif dan adil (World Health Organization [WHO], 2019).
- d. Meningkatkan kepuasan dan keterlibatan klien: Klien yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan cenderung lebih patuh dan puas dengan pelayanan yang diberikan (Elwyn et al., 2012).

Beberapa prinsip dasar EBP yang perlu dipahami oleh mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam praktik KB antara lain:

- a. Penggunaan bukti terbaik
Memilih intervensi berdasarkan hasil penelitian yang valid, terkini, dan relevan.
- b. Integrasi pengalaman profesional
Memanfaatkan pengalaman klinis untuk menyesuaikan bukti dengan situasi dan konteks nyata klien.
- c. Penghargaan terhadap preferensi klien
Mendengarkan dan menghormati keputusan, pilihan, dan hak reproduksi klien.

d. Peningkatan kualitas berkelanjutan

EBP mendorong evaluasi dan penyesuaian praktik secara berkala untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.

EBP bukan hanya metode atau teknik, tetapi merupakan filosofi dan kerangka kerja yang memastikan pelayanan KB lebih efektif, aman, dan berbasis hak. Dengan memahami dan menerapkan EBP, mahasiswa dan tenaga kesehatan dapat memberikan layanan yang tidak hanya ilmiah, tetapi juga manusiawi dan berpusat pada klien.

B. Sumber Bukti Ilmiah dalam Keluarga Berencana (KB)

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang berbasis bukti (*evidence-based practice*) membutuhkan informasi yang valid, akurat, dan relevan. Sumber bukti ilmiah ini membantu tenaga kesehatan, termasuk bidan, dalam merencanakan dan memberikan pelayanan KB yang aman, efektif, serta sesuai dengan kebutuhan dan hak reproduksi klien (Sackett et al., 2000).

a. Meta-analisis dan *Systematic Review*

Meta-analisis dan *systematic review* merupakan sumber bukti ilmiah tertinggi karena menggabungkan hasil dari berbagai penelitian yang sudah tervalidasi. Studi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan keamanan metode kontrasepsi. Contohnya, penelitian mengenai pil KB, IUD, dan kontrasepsi hormonal sering dikompilasi dalam *systematic review* dan menjadi dasar pedoman WHO dalam pelayanan KB (WHO, 2020). Dengan menggunakan bukti dari meta-analisis, tenaga kesehatan dapat memastikan bahwa intervensi KB yang diberikan terbukti secara ilmiah dan dapat diterapkan secara luas di masyarakat.

b. Riset Klinis dan Survei Nasional

Riset klinis dan survei nasional menyediakan data nyata mengenai praktik KB di masyarakat. Survei seperti Profil Kesehatan Indonesia (Kemenkes RI, 2021) dan laporan BKKBN (2022) menyajikan informasi tentang cakupan KB, preferensi metode kontrasepsi, serta kelompok populasi yang membutuhkan perhatian khusus. Data ini digunakan untuk merancang program KB di tingkat komunitas maupun nasional. Dengan demikian, riset ini tidak hanya menjadi teori, tetapi telah diterapkan secara nyata dalam pelayanan KB di masyarakat Indonesia.

c. Pedoman Klinis Internasional (WHO)

Pedoman klinis internasional, misalnya WHO *Family Planning Handbook* (2020), disusun berdasarkan bukti ilmiah terbaru dan pengalaman praktik di berbagai negara. Pedoman ini mengarahkan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan KB yang aman, efektif, dan berbasis hak reproduksi.

Penggunaan pedoman ini telah diadopsi secara luas, termasuk di Indonesia, sehingga praktik KB yang mengikuti pedoman terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan klien.

d. Penelitian Lokal dan Studi Implementasi

Penelitian lokal atau studi implementasi menilai apakah metode KB tertentu efektif dalam konteks sosial dan budaya setempat. Misalnya, studi mengenai penggunaan IUD atau kontrasepsi hormonal di daerah perkotaan maupun pedesaan menunjukkan keberhasilan menurunkan angka kehamilan tidak diinginkan. Hasil penelitian ini kemudian diterapkan secara langsung dalam program KB berbasis bukti, memastikan intervensi sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat (Mubarak & Chayatin, 2019).

Dengan memahami dan memanfaatkan berbagai sumber bukti ilmiah ini, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan KB yang lebih efektif, aman, dan sesuai hak reproduksi klien, sekaligus meningkatkan keberhasilan program KB nasional.

C. Integrasi Bukti dalam Praktik Keluarga Berencana (KB)

Integrasi bukti ilmiah dalam praktik Keluarga Berencana (KB) merupakan inti dari *evidence-based practice* (EBP). Proses ini memastikan bahwa pelayanan KB tidak hanya didasarkan pada kebiasaan atau pengalaman semata, tetapi pada bukti ilmiah yang valid, pengalaman profesional, dan preferensi klien (Sackett et al., 2000). Integrasi bukti dalam praktik KB dilakukan melalui beberapa langkah sistematis:

a. Formulasi Pertanyaan Klinis

Langkah pertama dalam EBP adalah merumuskan pertanyaan klinis yang spesifik dan relevan. Misalnya, seorang bidan dapat bertanya, "Metode kontrasepsi mana yang paling aman dan efektif untuk ibu menyusui?" Pertanyaan yang jelas membantu pencarian bukti lebih fokus dan relevan dengan kebutuhan klien (Straus et al., 2019).

b. Mencari Bukti Terbaik

Setelah pertanyaan klinis dirumuskan, langkah berikutnya adalah mencari bukti terbaik. Tenaga kesehatan dapat mengakses jurnal ilmiah, laporan penelitian nasional, dan pedoman resmi seperti WHO *Family Planning Handbook* (WHO, 2020). Bukti yang dikumpulkan harus berasal dari sumber terpercaya dan terbaru agar hasilnya relevan dengan praktik klinis.

c. Evaluasi dan Kritik Bukti

Bukti yang ditemukan kemudian dievaluasi untuk menilai validitas, relevansi, dan kualitas penelitian. Hal ini termasuk menilai metodologi, ukuran sampel, tingkat bias, dan keterapan hasil penelitian dalam konteks lokal. Evaluasi ini

penting agar keputusan yang diambil benar-benar berbasis bukti yang sah (Mubarak & Chayatin, 2019).

d. Penerapan Bukti dalam Praktik

Bukti yang telah dievaluasi kemudian diterapkan dalam praktik KB. Pilihan metode kontrasepsi disesuaikan dengan kondisi medis, usia, riwayat kesehatan, serta preferensi klien. Tenaga kesehatan juga harus mengedukasi klien mengenai risiko dan manfaat masing-masing metode, sehingga keputusan KB bersifat partisipatif dan berbasis hak reproduksi (WHO, 2020).

e. Evaluasi Hasil Pelayanan

Langkah terakhir adalah mengevaluasi hasil penerapan EBP. Evaluasi meliputi kepuasan klien, munculnya efek samping, serta keberhasilan metode KB dalam mencegah kehamilan tidak diinginkan. Data evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan KB dan memperkuat basis bukti bagi praktik berikutnya (Sackett et al., 2000).

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, integrasi bukti dalam praktik KB menjamin bahwa pelayanan yang diberikan aman, efektif, dan sesuai dengan prinsip hak reproduksi klien. Hal ini juga mendukung pencapaian tujuan program KB secara nasional maupun lokal.

D. Keuntungan *Evidence-Based Practice* (EBP) dalam Keluarga Berencana (KB)

Penerapan EBP dalam pelayanan Keluarga Berencana (KB) membawa berbagai keuntungan, baik bagi klien, tenaga kesehatan, maupun pembuat kebijakan. Keuntungan-keuntungan tersebut meliputi:

a. Meningkatkan efektivitas metode kontrasepsi

Dengan menggunakan bukti ilmiah terkini, tenaga kesehatan dapat memilih metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kondisi medis, usia, dan preferensi klien. Hal ini meningkatkan efektivitas pencegahan kehamilan tidak diinginkan dan mengurangi kegagalan metode kontrasepsi (Sackett et al., 2000; WHO, 2020).

b. Mengurangi komplikasi dan risiko kesehatan

EBP memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul dari penggunaan metode kontrasepsi tertentu dan memilih alternatif yang lebih aman. Misalnya, penelitian klinis menunjukkan bahwa IUD hormonal lebih aman bagi wanita dengan risiko tertentu dibanding metode hormonal oral (Mubarak & Chayatin, 2019).

c. Memperkuat hak klien dalam membuat Keputusan

Prinsip EBP menekankan pentingnya mempertimbangkan preferensi dan hak reproduksi klien. Dengan informasi yang jelas dan berbasis bukti, klien dapat

membuat keputusan partisipatif mengenai metode KB yang mereka pilih, sehingga pelayanan menjadi lebih adil, inklusif, dan berbasis hak (WHO, 2020).

d. Memberikan dasar ilmiah untuk pengembangan kebijakan dan program KB

Data dan bukti ilmiah yang dikumpulkan melalui EBP juga dapat digunakan oleh pemerintah atau lembaga penyelenggara KB untuk merancang kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. Misalnya, survei nasional dan pedoman klinis dapat menjadi dasar penentuan program edukasi kontrasepsi, distribusi alat kontrasepsi, dan pengembangan strategi intervensi masyarakat (Kemenkes RI, 2021; BKKBN, 2022).

Secara keseluruhan, EBP tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan KB, tetapi juga memastikan bahwa keputusan klinis dan kebijakan berbasis data dan bukti yang valid, aman, dan efektif bagi masyarakat.

E. Tantangan Implementasi Evidence-Based Practice (EBP) dalam Keluarga Berencana (KB)

Meskipun EBP memberikan banyak keuntungan dalam pelayanan Keluarga Berencana (KB), penerapannya di lapangan tidak selalu mudah. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dan program KB meliputi:

a. Keterbatasan akses informasi atau jurnal ilmiah

Tenaga kesehatan di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil, sering menghadapi kesulitan dalam mengakses literatur ilmiah terbaru, jurnal internasional, atau pedoman resmi. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mengintegrasikan bukti terbaru dalam praktik klinis (Sackett et al., 2000).

b. Resistensi budaya dan preferensi Masyarakat

Norma budaya, agama, dan kepercayaan lokal dapat memengaruhi penerimaan metode kontrasepsi tertentu. Misalnya, beberapa komunitas mungkin menolak IUD atau kontrasepsi hormonal karena dianggap bertentangan dengan nilai budaya atau keyakinan agama. Hal ini menuntut tenaga kesehatan untuk mampu mengkomunikasikan manfaat dan risiko metode kontrasepsi berbasis bukti dengan cara yang sensitif dan menghormati nilai lokal (Nurhayati, 2020).

c. Kurangnya keterampilan profesional dalam menilai bukti

Tidak semua tenaga kesehatan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengevaluasi kualitas penelitian atau menilai relevansi bukti ilmiah. Tanpa keterampilan ini, implementasi EBP bisa kurang optimal, sehingga keputusan klinis mungkin tidak sepenuhnya didasarkan pada bukti yang valid (Mubarak & Chayatin, 2019).

Mengatasi tantangan ini membutuhkan pelatihan berkelanjutan, peningkatan akses informasi, serta adaptasi strategi komunikasi yang menghormati konteks sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, penerapan EBP dalam KB dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

F. Soal Latihan

Pilihan Ganda

- 1 Evidence-Based Practice (EBP) dalam KB bertujuan untuk:
 - A. Menentukan metode KB berdasarkan opini klien saja
 - B. Mengintegrasikan bukti ilmiah, pengalaman profesional, dan preferensi klien
 - C. Mengikuti semua tren terbaru di media sosial
 - D. Memberikan layanan KB tanpa konsultasi
- 2 Sumber bukti ilmiah untuk EBP dalam KB antara lain:
 - A. Surat kabar lokal
 - B. Meta-analisis dan pedoman WHO
 - C. Cerita dari tetangga
 - D. Buku novel
- 3 Langkah pertama dalam EBP adalah:
 - A. Mengevaluasi hasil metode KB
 - B. Mencari bukti ilmiah
 - C. Membuat pertanyaan klinis yang jelas
 - D. Memberikan kontrasepsi
- 4 Pedoman klinis internasional seperti WHO Family Planning Handbook digunakan karena:
 - A. Hanya populer di media sosial
 - B. Berdasarkan bukti ilmiah terbaru dan pengalaman praktik global
 - C. Tidak relevan dengan konteks lokal
 - D. Diterbitkan setiap bulan
- 5 Salah satu keuntungan EBP dalam KB adalah:
 - A. Mengurangi efektivitas metode kontrasepsi
 - B. Memperkuat hak klien dalam membuat keputusan
 - C. Mengabaikan preferensi klien
 - D. Membuat keputusan KB hanya berdasarkan opini profesional

- 6 Tantangan penerapan EBP yang berkaitan dengan budaya adalah:
 - A. Keterbatasan akses jurnal ilmiah
 - B. Norma dan nilai lokal yang memengaruhi preferensi kontrasepsi
 - C. Kurangnya sumber daya manusia
 - D. Efek samping kontrasepsi hormonal
- 7 Hierarki bukti ilmiah menempatkan meta-analisis dan *systematic review* pada level:
 - A. Terendah
 - B. Menengah
 - C. Tertinggi
 - D. Sama dengan opini ahli
- 8 Data dari survei nasional, seperti Profil Kesehatan Indonesia, digunakan karena:
 - A. Hanya untuk tujuan statistik
 - B. Memberikan informasi representatif tentang cakupan KB dan preferensi masyarakat
 - C. Tidak relevan dengan pelayanan KB
 - D. Hanya untuk laporan tahunan instansi
- 9 Evaluasi hasil penerapan EBP meliputi:
 - A. Kepuasan klien, efek samping, dan keberhasilan metode KB
 - B. Jumlah kontrasepsi yang tersedia
 - C. Waktu pelayanan saja
 - D. Hanya pendapat tenaga kesehatan
- 10 Contoh pertanyaan klinis dalam EBP KB adalah:
 - A. "Metode kontrasepsi mana yang paling sesuai untuk ibu menyusui?"
 - B. "Berapa banyak teman yang menggunakan pil KB?"
 - C. "Metode KB mana yang paling populer di media sosial?"
 - D. "Siapa yang memiliki pengalaman KB terbaik?"
- 11 Penelitian lokal dan studi implementasi penting dalam EBP karena:
 - A. Memberikan data global yang tidak spesifik
 - B. Menilai efektivitas metode KB dalam konteks sosial dan budaya tertentu
 - C. Hanya untuk publikasi ilmiah
 - D. Tidak berguna bagi tenaga kesehatan

- 12 Penerapan EBP dalam pelayanan KB harus mempertimbangkan:
- A. Bukti ilmiah, pengalaman profesional, dan preferensi klien
 - B. Opini teman dan media sosial
 - C. Tren terbaru saja
 - D. Kebijakan yang tidak relevan
- 13 Salah satu tantangan profesional dalam implementasi EBP adalah:
- A. Kurangnya keterampilan menilai bukti ilmiah
 - B. Terlalu banyak bukti yang mudah diakses
 - C. Preferensi klien selalu jelas
 - D. Semua tenaga kesehatan sudah terlatih
- 14 Tujuan utama evaluasi hasil EBP dalam KB adalah:
- A. Menentukan metode yang paling mahal
 - B. Mengukur keberhasilan, kepuasan klien, dan efek samping metode KB
 - C. Menentukan metode yang populer di media
 - D. Mengabaikan preferensi klien
- 15 EBP membantu bidan dan tenaga kesehatan dalam KB untuk:
- A. Memberikan layanan tanpa pedoman
 - B. Mengatasi mitos dan informasi salah terkait kontrasepsi
 - C. Hanya mengikuti kebijakan internal
 - D. Memberikan layanan berdasarkan opini pribadi

Essay

1. Jelaskan bagaimana prinsip EBP dapat diterapkan dalam memilih metode kontrasepsi bagi ibu menyusui!
2. Sebutkan tantangan utama dalam implementasi EBP pada pelayanan KB di Indonesia dan beri solusinya!
3. Berikan contoh bukti ilmiah dari penelitian lokal yang dapat dijadikan dasar pelayanan KB di masyarakat!
4. Jelaskan keuntungan integrasi bukti ilmiah dalam praktik KB bagi hak reproduksi klien!

Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1. b
2. b
3. c

4. b
5. b
6. b
7. c
8. b
9. a
10. a
11. b
12. a
13. a
14. b
15. b

G. Glosarium

- 1. Evidence-Based Practice (EBP):** Pendekatan pengambilan keputusan klinis yang mengintegrasikan bukti ilmiah, pengalaman profesional, dan preferensi klien.
- 2. Meta-analysis:** Metode penelitian yang menggabungkan hasil dari beberapa studi untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat.
- 3. Systematic Review:** Tinjauan literatur yang sistematis dan transparan untuk menilai bukti ilmiah yang ada.
- 4. Preferensi Klien:** Pilihan individu yang mempertimbangkan nilai, kebutuhan, dan kondisi pribadi dalam pengambilan keputusan kesehatan.
- 5. Pedoman Klinis:** Dokumen yang berisi rekomendasi berbasis bukti untuk praktik kesehatan tertentu, misal pedoman kontrasepsi WHO.

H. Daftar Pustaka

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2022). Laporan tahunan program keluarga berencana nasional. <https://www.bkkbn.go.id>
- Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., ... & Barry, M. (2012). Shared decision making: A model for clinical practice. *Journal of General Internal Medicine*, 27(10), 1361–1367. <https://doi.org/10.1007/s11606-012-2077-6>
- Glasier, A., Gülmezoglu, A. M., Schmid, G. P., Moreno, C. G., & Van Look, P. F. A. (2016). Sexual and reproductive health: A matter of life and death. *The Lancet*, 368(9547), 1595–1607. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)69479-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69479-8)
- Hubacher, D., & Grimes, D. A. (2002). Noncontraceptive health benefits of intrauterine devices: A systematic review. *Obstetrics & Gynecology*, 100(2), 345–353. [https://doi.org/10.1016/S0029-7844\(02\)02069-0](https://doi.org/10.1016/S0029-7844(02)02069-0)

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). (2021). Profil kesehatan Indonesia 2021. <https://www.kemkes.go.id>
- Mubarak, W. I., & Chayatin, N. (2019). Promosi kesehatan untuk kebidanan. Salemba Medika.
- Nurhayati, T. (2020). Hak reproduksi dan kesehatan perempuan. Refika Aditama.
- Sackett, D. L., Rosenberg, W. M., Gray, J. A., Haynes, R. B., & Richardson, W. S. (2000). Evidence based medicine: What it is and what it isn't. *BMJ*, 312(7023), 71–72. <https://doi.org/10.1136/bmj.312.7023.71>
- Straus, S. E., Glasziou, P., Richardson, W. S., & Haynes, R. B. (2019). Evidence-based medicine: How to practice and teach EBM (5th ed.). Elsevier.
- World Health Organization (WHO). (2020). Family planning: A global handbook for providers. <https://www.who.int>
- World Health Organization (WHO). (2021). Family planning/contraception. <https://www.who.int>

BAB 3

JENIS DAN MEKANISME KERJA KB HORMONAL DAN NON HORMONAL SERTA EFEK SAMPING DAN PENYULITNYA

Tujuan Intruksional:

1. Menyebutkan jenis-jenis KB hormonal
2. Menjelaskan mekanisme kerja KB hormonal
3. Menjelaskan konsep dasar efek samping / penyulit penggunaan KB hormonal dan penanganannya
4. Menyebutkan jenis-jenis KB non hormonal
5. Menjelaskan mekanisme kerja KB non hormonal
6. Menjelaskan konsep dasar efek samping / penyulit penggunaan KB non hormonal dan penanganannya

Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu menyebutkan jenis-jenis KB hormonal
2. Mahasiswa mampu Menjelaskan mekanisme kerja KB hormonal
3. Mahasiswa mampu Menjelaskan konsep dasar efek samping / penyulit penggunaan KB hormonal dan penanganannya
4. Mahasiswa mampu menyebutkan jenis-jenis KB non hormonal
5. Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme kerja KB non hormonal
6. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar efek samping / penyulit penggunaan KB non hormonal dan penanganannya

Pendahuluan

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Aqmal, 2020). Program KB adalah suatu langkah-langkah atau suatu usaha kegiatan yang disusun oleh organisasi-organisasi KB dan merupakan program pemerintah untuk mencapai rakyat yang sejahtera berdasarkan peraturan dan perundang-undangan kesehatan. KB adalah mengatur jumlah anak sesuai dengan keinginan dan menentukan kapan ingin hamil. Jadi, KB (*Family Planning, Planned Parenthood*) adalah suatu usaha untuk mengatur atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera (Tiffani dkk., 2020).

Kontrasepsi merupakan upaya untuk mencegah kehamilan dengan berbagai metode yang bertujuan untuk mengatur kesuburan. Kontrasepsi menjadi bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi yang penting dalam mendukung program Keluarga Berencana (KB) dan menurunkan angka kelahiran yang tidak diinginkan. Dengan adanya kontrasepsi, pasangan dapat merencanakan kehamilan sesuai dengan kondisi kesehatan, ekonomi, dan sosial mereka (Mandira dkk., 2020).

Menurut World Health Organization (WHO), kontrasepsi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah konsepsi atau pembuahan dengan berbagai metode yang dapat bersifat sementara maupun permanen. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan kontrasepsi sebagai cara atau alat yang digunakan untuk menghindari atau menunda kehamilan dalam jangka waktu tertentu (Nurullah, 2021).

A. Jenis- jenis KB Hormonal

1. Pil KB Kombinasi

Pil KB kombinasi mengandung hormon estrogen dan progestin yang bekerja dengan menghambat ovulasi serta mengubah kondisi serviks dan endometrium. Pil ini harus dikonsumsi secara teratur setiap hari pada waktu yang sama agar efektivitasnya tetap tinggi. Pil kombinasi juga memiliki manfaat tambahan seperti mengurangi nyeri haid, memperbaiki siklus menstruasi, serta mengurangi risiko kanker ovarium dan endometrium (Adiesti dan Wari, 2020). Pil KB kombinasi tersedia dalam berbagai regimen, seperti paket 21 hari dan paket 28 hari. Dalam paket 28 hari, 21 pil pertama mengandung hormon aktif, sedangkan 7 pil sisanya adalah plasebo yang tidak mengandung hormon. Hal ini dirancang untuk membantu pengguna menjaga kebiasaan konsumsi harian (Adiesti dan Wari, 2020).

2. Pil Progestin (Mini Pil)

Pil progestin atau mini pil, hanya mengandung hormon progestin tanpa estrogen. Ini menjadikannya pilihan yang lebih aman bagi wanita yang tidak dapat menggunakan estrogen, seperti ibu menyusui atau mereka yang memiliki riwayat penyakit kardiovaskular. Mini pil bekerja dengan mengentalkan lendir serviks dan menipiskan endometrium, sehingga sperma sulit mencapai sel telur dan implantasi lebih sulit terjadi (Setyoningsih, 2020).

Mini pil harus dikonsumsi setiap hari pada waktu yang sama tanpa jeda, berbeda dengan pil kombinasi yang memiliki periode plasebo. Jika mini pil terlambat diminum lebih dari tiga jam, efektivitasnya dapat berkurang, sehingga pengguna disarankan untuk menggunakan metode kontrasepsi tambahan seperti kondom dalam 48 jam setelah keterlambatan konsumsi (Setyoningsih, 2020).

3. Suntik KB

Suntik KB mengandung hormon progestin yang diberikan dalam bentuk injeksi setiap 1 atau 3 bulan, tergantung pada jenisnya. Ada dua jenis suntik KB yang umum digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Depo-Provera (DMPA): Mengandung medroksiprogesteron asetat dan diberikan setiap 12 minggu.
- b. Noristerat: Mengandung norethisteron enanthate dan diberikan setiap 8 minggu.

Suntik KB memiliki efektivitas tinggi dan tidak memerlukan kepatuhan harian seperti pil KB. Namun, pengguna mungkin mengalami perubahan pola menstruasi, seperti amenore (tidak menstruasi) atau perdarahan tidak teratur (Noviana dan Sutarno, 2023).

4. Implan KB

Implan KB adalah alat kontrasepsi berbentuk batang kecil yang dimasukkan di bawah kulit lengan atas. Implan ini melepaskan hormon progestin secara bertahap, memberikan perlindungan terhadap kehamilan selama 3–5 tahun tergantung pada jenisnya (Wirda, 2021). Implan KB bekerja dengan menghambat ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dan menipiskan endometrium. Prosedur pemasangan dan pelepasannya dilakukan oleh tenaga medis, dan efektivitasnya sangat tinggi, mencapai lebih dari 99% dalam mencegah kehamilan (Wirda, 2021).

5. Cincin Vagina

Cincin vagina adalah alat kontrasepsi berbentuk lingkaran fleksibel yang dimasukkan ke dalam vagina dan melepaskan kombinasi hormon estrogen dan progestin. Cincin ini digunakan selama tiga minggu, kemudian dilepas selama satu minggu sebelum diganti dengan yang baru (Dewi dkk., 2022). Cincin vagina memiliki efektivitas yang sebanding dengan pil KB kombinasi, tetapi memberikan fleksibilitas lebih karena tidak memerlukan konsumsi harian. Pengguna hanya perlu mengganti cincin sesuai jadwal untuk menjaga efektivitasnya (Dewi dkk., 2022)

B. Mekanisme Kerja KB Hormonal

1. Menghambat Ovulasi

Hormon dalam kontrasepsi menekan produksi hormon luteinizing hormone (LH) dan follicle-stimulating hormone (FSH), sehingga sel telur tidak dilepaskan dari ovarium (Yendena dkk., 2023).

2. Mengentalkan Lendir Serviks

Progestin menyebabkan lendir serviks menjadi lebih kental, membuat sperma sulit mencapai sel telur (Yendena dkk., 2023).

3. Menipiskan Endometrium

Endometrium yang tipis mengurangi kemungkinan implantasi sel telur yang telah dibuahi (Yendena dkk., 2023).

C. Konsep Dasar Efek Samping Kontrasepsi Hormonal

Kontrasepsi hormonal memiliki efektivitas tinggi dalam mencegah kehamilan, tetapi penggunaannya dapat menyebabkan berbagai efek samping. Efek samping ini dapat bervariasi tergantung pada jenis kontrasepsi yang digunakan, durasi pemakaian, serta respons individu terhadap hormon sintetis yang terkandung dalam metode tersebut (WHO, 2018).

1. Efek Samping Umum Kontrasepsi Hormonal

Beberapa efek samping yang umum terjadi pada pengguna kontrasepsi hormonal meliputi:

a. Perubahan Siklus Menstruasi

Menstruasi tidak teratur, bercak darah di luar siklus, atau amenore (tidak menstruasi sama sekali). Pada beberapa pengguna, kontrasepsi hormonal dapat menyebabkan menstruasi lebih ringan atau lebih jarang terjadi (Yendena dkk., 2023).

b. Perubahan Berat Badan

Beberapa wanita mengalami peningkatan berat badan akibat retensi cairan atau peningkatan nafsu makan. Namun, tidak semua pengguna mengalami perubahan berat badan yang signifikan (Yendena dkk., 2023).

c. Sakit Kepala dan Migrain

Kontrasepsi hormonal dapat memicu sakit kepala atau migrain, terutama bagi mereka yang sudah memiliki riwayat migrain sebelumnya. Beberapa jenis pil kombinasi dapat memperburuk gejala migrain akibat perubahan kadar estrogen (Harahap, 2022).

d. Gangguan Pencernaan

Mual dan muntah dapat terjadi, terutama pada awal penggunaan kontrasepsi hormonal. Beberapa pengguna juga mengalami gangguan pencernaan ringan, seperti kembung (Yendena dkk., 2023).

e. Perubahan Mood dan Emosi

Beberapa pengguna melaporkan perubahan suasana hati, kecemasan, atau bahkan depresi ringan. Efek ini terkait dengan perubahan kadar hormon yang memengaruhi neurotransmitter di otak (Yendena dkk., 2023).

2. Efek Samping Jangka Panjang Kontrasepsi Hormonal

Penggunaan kontrasepsi hormonal dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko beberapa kondisi kesehatan tertentu, berikut merupakan efek samping jangka panjang kontrasepsi hormonal:

a. Peningkatan Risiko Trombosis

Kontrasepsi kombinasi yang mengandung estrogen dapat meningkatkan risiko pembekuan darah (trombosis), terutama pada wanita dengan riwayat keluarga atau faktor risiko lainnya. Risiko ini lebih tinggi pada perokok dan wanita dengan tekanan darah tinggi (Yendena dkk., 2023).

b. Hipertensi dan Penyakit Kardiovaskular

Kontrasepsi hormonal dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah pada beberapa pengguna. Penggunaan jangka panjang berpotensi meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, terutama pada wanita yang lebih tua atau memiliki faktor risiko lain (Yendena dkk., 2023).

c. Perubahan Kesehatan Tulang

Penggunaan kontrasepsi suntik yang mengandung progestin dalam jangka panjang dapat menurunkan kepadatan tulang. Hal ini terutama menjadi perhatian bagi wanita muda yang masih dalam masa pertumbuhan tulang atau wanita yang mendekati menopause (Yendena dkk., 2023).

d. Perubahan Kesehatan Reproduksi

Setelah menghentikan penggunaan kontrasepsi hormonal, beberapa Wanita mengalami keterlambatan dalam mengembalikan siklus menstruasi normal mereka. Namun, dalam sebagian besar kasus, kesuburan kembali normal dalam beberapa bulan setelah penghentian kontrasepsi (Yendena dkk., 2023).

3. Cara Mengatasi dan Mengelola Efek Samping

Untuk mengurangi atau mengatasi efek samping dari kontrasepsi hormonal, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain.

a. Menyesuaikan Jenis Kontrasepsi

Jika efek samping terlalu mengganggu, konsultasikan dengan tenaga medis untuk mencoba jenis kontrasepsi hormonal lain yang lebih sesuai. Alternatif seperti pil dengan dosis hormon lebih rendah atau metode non-hormonal dapat dipertimbangkan (Yendena dkk., 2023).

b. Memperhatikan Pola Hidup Sehat

Mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga teratur, dan menjaga berat badan dapat membantu mengurangi beberapa efek samping seperti perubahan mood dan peningkatan berat badan (Yendena dkk., 2023):

c. Konsultasi Medis Secara Berkala

Pemeriksaan rutin dengan tenaga kesehatan dapat membantu memantau dampak kontrasepsi hormonal terhadap tubuh dan mengatasi efek samping yang muncul lebih awal. Wanita dengan riwayat keluarga penyakit kardiovaskular atau trombosis harus lebih berhati-hati dan

berkonsultasi sebelum menggunakan kontrasepsi hormonal (Yendena dkk., 2023)

D. Jenis-Jenis Kontrasepsi Non-Hormonal

1. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau IUD

AKDR atau Intrauterine Device (IUD) adalah alat kecil berbentuk T yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Terdapat dua jenis utama IUD non-hormonal:

- a. IUD Tembaga: mengandung tembaga yang menciptakan lingkungan toksik bagi sperma, menghambat pergerakan dan kelangsungan hidupnya.
- b. IUD Inert: tidak mengandung zat aktif tetapi berfungsi sebagai penghalang mekanis di dalam rahim.

IUD memiliki efektivitas lebih dari 99% dan dapat bertahan antara 5 hingga 10 tahun, tergantung jenisnya. Efek sampingnya bisa berupa peningkatan perdarahan menstruasi dan kram perut pada beberapa wanita (Sulistiani dan Setiyaningsih, 2021).

2. Metode Penghalang

Metode penghalang bekerja dengan mencegah sperma masuk ke dalam rahim. Beberapa jenis metode ini meliputi:

- a. Kondom pria: sarung lateks atau poliuretan yang dikenakan pada penis untuk menangkap sperma sebelum memasuki vagina.
- b. Kondom wanita: sarung poliuretan yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual.
- c. Diafragma: cangkir berbentuk kubah yang terbuat dari silikon atau lateks yang ditempatkan di dalam vagina untuk menutupi serviks.
- d. Spermisida: bahan kimia berbentuk gel, busa, atau tablet yang membunuh sperma sebelum mencapai sel telur (Sulistiani dan Setiyaningsih, 2021).

3. Metode Alami

Metode alami mengandalkan pemantauan siklus menstruasi dan menghindari hubungan seksual selama masa subur. Jenis metode ini meliputi:

- a. Metode kalender: menghitung hari subur berdasarkan panjang siklus menstruasi.
- b. Metode suhu basal: mengukur perubahan suhu tubuh basal untuk menentukan masa ovulasi.
- c. Metode mukus serviks: mengamati perubahan lendir serviks untuk mengenali masa subur.

- d. *Coitus Interruptus* (senggama terputus): menarik penis sebelum ejakulasi untuk mencegah sperma masuk ke dalam vagina (Sulistiani dan Setiyaningsih, 2021).

4. Sterilisasi

Sterilisasi adalah metode kontrasepsi permanen yang dilakukan melalui prosedur medis untuk menghentikan kemampuan reproduksi. Jenis sterilisasi meliputi:

- a. Sterilisasi wanita (tubektomi): pemotongan atau penyumbatan tuba falopi untuk mencegah pertemuan sperma dan sel telur.
- b. Sterilisasi pria (vasektomi): pemotongan atau penyumbatan saluran vas deferens agar sperma tidak dikeluarkan saat ejakulasi (Sulistiani dan Setiyaningsih, 2021).

E. Mekanisme Kerja Kontrasepsi Non-Hormonal

1. Mencegah Fertilisasi

IUD tembaga menciptakan lingkungan yang beracun bagi sperma, mencegah pembuahan (Nurmayani dkk., 2020).

2. Membentuk Penghalang Fisik

Kondom, diafragma, dan metode penghalang lainnya mencegah sperma masuk ke dalam rahim (Nurmayani dkk., 2020).

3. Mengubah Lingkungan Serviks

Spermisida dan beberapa metode penghalang mengganggu kemampuan sperma mencapai sel telur (Nurmayani dkk., 2020).

4. Menghindari Hubungan Seksual saat Subur

Metode alami membantu pengguna mengidentifikasi dan menghindari masa subur untuk mencegah kehamilan (Nurmayani dkk., 2020).

5. Menghentikan Produksi atau Transportasi Sperma

Vasektomi menghentikan produksi sperma dalam ejakulasi, sementara tubektomi mencegah sel telur bertemu sperma (Nurmayani dkk., 2020).

F. Konsep Dasar Efek Samping Kontrasepsi Non-Hormonal

Kontrasepsi non-hormonal digunakan sebagai alternatif bagi individu yang ingin menghindari efek samping dari metode berbasis hormon. Meskipun relatif lebih aman bagi sebagian besar pengguna, metode ini tetap memiliki potensi efek samping yang perlu diperhatikan (WHO, 2018).

1. Efek Samping Umum Kontrasepsi Non-Hormonal

- a. Iritasi atau Reaksi Alergi

Penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom, diafragma, atau spermisida dapat menyebabkan iritasi atau reaksi alergi, terutama bagi individu yang sensitif terhadap lateks atau bahan kimia dalam spermisida. Gejala yang muncul dapat berupa gatal, kemerahan, atau rasa terbakar di area genital (Kadir dan Sembiring, 2020).

b. Ketidaknyamanan atau Nyeri Saat Penggunaan

Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau IUD dapat menyebabkan ketidaknyamanan, terutama pada minggu-minggu pertama setelah pemasangan. Beberapa pengguna melaporkan kram perut atau nyeri punggung setelah pemasangan IUD (Kadir dan Sembiring, 2020).

c. Peningkatan Volume dan Durasi Menstruasi

IUD tembaga sering kali menyebabkan menstruasi yang lebih berat dan lebih lama dibandingkan siklus normal. Pengguna mungkin mengalami peningkatan jumlah darah haid dan kram yang lebih parah (Kadir dan Sembiring, 2020).

d. Infeksi Saluran Reproduksi

Pemasangan IUD meningkatkan risiko infeksi panggul jika prosedur dilakukan dalam kondisi yang kurang steril. Risiko infeksi lebih tinggi dalam beberapa minggu pertama setelah pemasangan (Kadir dan Sembiring, 2020).

e. Risiko Kehamilan Ektopik

Penggunaan IUD, meskipun sangat efektif dalam mencegah kehamilan, dapat meningkatkan risiko kehamilan ektopik jika pembuahan terjadi. Kehamilan ektopik adalah kondisi di mana embrio berkembang di luar rahim, yang bisa berbahaya bagi kesehatan (Kadir dan Sembiring, 2020).

2. Efek Samping Jangka Panjang Kontrasepsi Non-Hormonal

a. Perubahan pada Siklus Menstruasi

IUD tembaga dapat menyebabkan perubahan pola menstruasi yang lebih tidak teratur dalam beberapa bulan pertama penggunaan. Pada sebagian pengguna, siklus dapat kembali normal setelah tubuh beradaptasi dengan alat kontrasepsi (Sulistiani dan Setyaningsih, 2021).

b. Peningkatan Risiko Anemia

Karena perdarahan menstruasi yang lebih banyak dan lebih lama, pengguna IUD tembaga berisiko mengalami anemia defisiensi zat besi. Gejala anemia meliputi kelelahan, pusing, dan kulit pucat (Sulistiani dan Setyaningsih, 2021).

c. Efek Psikologis

Beberapa individu mungkin mengalami stres atau kecemasan terkait ketidaknyamanan penggunaan alat kontrasepsi non-hormonal. Efek

psikologis juga dapat timbul akibat ketakutan akan kegagalan kontrasepsi atau efek samping yang dialami (Sulistiani dan Setyaningsih, 2021).

3. Cara Mengatasi dan Mengelola Efek Samping

a. Menyesuaikan Jenis Kontrasepsi

Jika terjadi reaksi alergi terhadap kondom lateks, alternatif seperti kondom berbahan poliuretan dapat digunakan. Jika efek samping IUD terlalu mengganggu, konsultasi dengan tenaga medis dapat membantu mencari solusi lain, seperti metode kontrasepsi penghalang atau metode alami (Kadir dan Sembiring, 2020).

b. Mengonsumsi Suplemen Zat Besi

Bagi pengguna IUD yang mengalami menstruasi berat, mengonsumsi makanan kaya zat besi atau suplemen zat besi dapat membantu mencegah anemia (Kadir dan Sembiring, 2020).

c. Memeriksa Diri Secara Rutin

Pemeriksaan rutin dengan tenaga medis dapat membantu mengidentifikasi dan menangani efek samping lebih awal. Jika terjadi infeksi atau ketidaknyamanan yang berkepanjangan, segera konsultasikan dengan dokter untuk evaluasi lebih lanjut (Sulistiani dan Setyaningsih, 2021).

G. Latihan

Latihan dibuat dalam bentuk

Pilihan Ganda 5 Soal

1. Metode kontrasepsi berikut yang termasuk jenis hormonal adalah...
 - A. Kondom dan IUD tembaga
 - B. Pil KB dan suntik KB
 - C. Diafragma dan spermisida
 - D. Metode kalender
 - E. Coitus interruptus
2. Manakah yang merupakan mekanisme kerja utama dari KB hormonal?
 - A. Membentuk penghalang fisik sehingga sperma tidak bisa bertemu sel telur
 - B. Mengubah cairan leher rahim untuk mempersulit masuknya sperma
 - C. Mencegah ovulasi dengan menggunakan hormon progestin atau estrogen
 - D. Mencegah pembuahan dengan menggunakan alat penahan sperma
 - E. Mengencerkan lender serviks.
3. IUD hormonal bekerja dengan cara...
 - A. Membentuk penghalang fisik di leher rahim
 - B. Menghalangi pergerakan sperma dengan melepaskan hormon progestin
 - C. Menghilangkan sperma dengan menggunakan bahan kimia

- D. Menggugurkan janin yang sudah terbentuk
- E. Mengacaukan perjalanan sperma
- 4. Manakah dari pilihan berikut yang termasuk metode kontrasepsi non-hormonal?
 - A. Pil KB
 - B. Implan
 - C. Kondom
 - D. Suntik KB 3 bulan
 - E. IUD progestin
- 5. Efek samping yang sering dikaitkan dengan beberapa metode KB hormonal adalah...
 - A. Peningkatan berat badan dan jerawat
 - B. Penurunan libido dan siklus menstruasi yang tidak teratur
 - C. Peningkatan risiko penyakit menular seksual
 - D. Penurunan sensitivitas terhadap hormon
 - E. Penurunan berat badan

Essay 5 Soal

1. Sebutkan jenis-jenis metode kontrasepsi hormonal!
2. Jelaskan efek samping yang mungkin terjadi pada penggunaan kontrasepsi hormonal!
3. Sebutkan jenis-jenis metode kontrasepsi non hormonal!
4. Jelaskan efektivitas penggunaan kontrasepsi non hormonal tersebut!
5. Jelaskan efek samping yang mungkin terjadi pada penggunaan kontrasepsi non hormonal!

Kunci Jawaban

1. B
2. C
3. B
4. C
5. A

H. Rangkuman Materi

Kontrasepsi hormonal adalah metode pencegahan kehamilan yang menggunakan hormon sintetis untuk menghambat ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dan menipiskan endometrium. Metode ini memiliki efektivitas tinggi dalam mencegah kehamilan jika digunakan dengan benar dan konsisten. Kontrasepsi

hormonal bekerja dengan memanipulasi kadar hormon dalam tubuh agar menyerupai kondisi kehamilan, sehingga mencegah pelepasan sel telur oleh ovarium. Penggunaan kontrasepsi hormonal dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti pil kombinasi, pil progestin saja, suntikan, implan, dan cincin vagina. Masing-masing metode memiliki mekanisme kerja dan durasi efektivitas yang berbeda. Beberapa metode lebih cocok bagi wanita dengan kondisi medis tertentu atau preferensi pribadi dalam penggunaannya.

Kontrasepsi non-hormonal adalah metode pencegahan kehamilan yang tidak menggunakan hormon sintetis, melainkan bekerja dengan cara menghalangi sperma mencapai sel telur atau menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pembuahan. Metode ini sering dipilih oleh wanita yang tidak dapat atau tidak ingin menggunakan kontrasepsi hormonal karena alasan kesehatan atau preferensi pribadi. Kontrasepsi non-hormonal tersedia dalam berbagai bentuk, seperti alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR), metode penghalang, metode alami, dan sterilisasi. Efektivitas setiap metode bervariasi tergantung pada cara penggunaan dan tingkat kepatuhan pengguna.

I. Glosarium

AKDR	: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana
DMPA	: Depo-Medroxyprogesterone Acetate
IUD	: Intra Uterine Device
KB	: Keluarga Berencana
WHO	: World Health Organization

J. Referensi

- Adiesti, F., & Wari, F. E. (2020). Hubungan Kontrasepsi Hormonal dengan Siklus Menstruasi. *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia*, 4(1).
- Dewi, L. V. I., Purbosari, E. Y., & Hanifah, I. R. (2022). Gambaran Efek Samping Kontrasepsi Hormonal pada Akseptor Keluarga Berencana di Wilayah Puskesmas Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 19(2).
- Harahap, L. J. (2022). Penyuluhan Peningkatan Pengetahuan PUS dalam Memilih Jenis Kontrasepsi Suntik untuk Meminimalisir Efek Samping di Desa Huta Holbung Kecamatan Angkola Muaratais. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aupa (JPMA)*, 4(1).
- Kadir, D., & Sembiring, J. (2020). Faktor yang Mempengaruhi Minat Ibu Menggunakan KB IUD di Puskesmas Binjai Estate. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 10(3).

- Mandira, T. M., Fitriani, D., Ardi, N. B., Veri, & Selvia, A. (2020). Edukasi Program Keluarga Berencana (KB) pada Wanita Usia Subur Selama Masa Pandemi Covid-19. *JAM: Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(1), 108–112.
- Noviana, A., & Sutarno, M. (2023). Hubungan Akseptor Keluarga Berencana Suntik “DMPA” dengan Kejadian Disfungsi Seksual Wanita di Puskesmas Bojonegoro Serang Banten. *Jurnal Ners Reseach & Learning in Nursing Science*, 7(1), 175–179.
- Nurmayani, W., Nurmayani, M., & Suarnaya, N. K. I. M. (2020). Perbedaan Kualitas Seksual pada Wanita Akseptor KB hormonal dengan KB Non-Hormonal. *Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan Tradisional*, 5(2), 67–149.
- Nurullah, F. A. (2021). Perkembangan Metode Kontrasepsi di Indonesia. *Continuing Medical Education*, 48(3).
- Setyoningsih, F. Y. (2020). Efek Samping Akseptor KB Suntik Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) di BPM Fitri Hayati. *Jurnal Kebidanan*, 6(3), 298–304.
- Sulistiani, A., & Setiyaningsih, A. (2021). Pengaruh Penyuluhan Media Video Terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Tentang Kontrasepsi Intra Uterine Devices (IUD) pada Pasangan Usia Subur. *Jurnal Kebidanan*, 13(1).
- Tiffani, W. F., Mayasari, & Rifai, M. (2020). Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) dalam Upaya Menekan Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 7(3).
- WHO (2018). *Contraception. World Health Organization The Global Health*.
- Wirda. (2021). Gambaran Pengetahuan Akseptor KB Implant Tentang Efek Samping Alat Kontrasepsi Implant di Puskesmas Talang Bakung Kota Jambi Tahun 2021. *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(4).
- Yendena, N., Anwar, M., Kartini, F., & Astuti, A. W. (2023). Scoping Review: Dampak Penggunaan Kontrasepsi Hormonal Memengaruhi Disfungsi Seksual pada Wanita. *Jurnal Kesehatan*, 14(1).

BAB 4

MENGANALISIS KRITERIA KELAYAKAN PENGUNAAN METODE KONTRASEPSI, TERMASUK JANGKA WAKTU YANG SESUAI DALAM PENGUNAAN KONTRASEPSI

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan Tujuan Pelayanan Keluarga Berencana
- Menjelaskan Perencanaan Keluarga dan Penggunaan Kontrasepsi Yang Rasional
- Menjelaskan Paradigma Pelayanan Kesehatan KB dulu dan Sekarang
- Menjelaskan Kriteria Kelayakan Metode Kontrasepsi
- Menjelaskan Pengembangan Kriteria Kelayakan Medis Untuk Penggunaan Kontrasepsi
- Mendemonstrasikan Penggunaan Rekomendasi Kriteria Kelayakan Medis Untuk Penggunaan
- Mendemonstrasikan Penapisan klien menggunakan kriteria kelayakan medis penggunaan kontrasepsi (KLOP KB)

Capaian Pembelajaran:

CPL: Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penapisan klien menggunakan kriteria kelayakan medis penggunaan kontrasepsi

CPMK: Bila diberikan pengalaman belajar dikelas, mahasiswa mampu mengintegrasikan (C4) pengetahuan, sikap dan ketrampilan praktik dalam menggunakan kriteria kelayakan medis penggunaan kontrasepsi.

SUB-CPMK

- Sub-CPMK 1 Mendiskusikan tujuan pelayanan keluarga berencana
- Sub-CPMK 2 Mendiskusikan tentang perencanaan Keluarga dan Penggunaan Kontrasepsi yang rasional
- Sub-CPMK 3 Mendiskusikan tentang paradigma pelayanan kesehatan kb dulu dan sekarang
- Sub-CPMK 4 Mendiskusikan tentang kriteria kelayakan metode kontrasepsi
- Sub-CPMK 5 Mendiskusikan pengembangan kriteria kelayakan medis untuk penggunaan kontrasepsi
- Sub-CPMK 6 Mendemonstrasikan penggunaan rekomendasi kriteria kelayakan medis untuk penggunaan
- Sub-CPMK 7 Mendemonstrasikan penapisan klien menggunakan kriteria kelayakan medis penggunaan kontrasepsi (KLOP KB)

A. Tujuan Pelayanan Keluarga Berencana

Menurut (Wahyuni, Kurniawati, Chairiyah, & Hakiki, 2023) Tujuan pelayanan KB adalah menciptakan keluarga yang berkualitas melalui pengendalian kelahiran, pengaturan jarak kehamilan, serta pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup ibu, bayi, serta masyarakat secara keseluruhan.

1 Tujuan Utama Pelayanan KB

- a. Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak ; Kehamilan pada usia yang terlalu muda atau terlalu tua dapat meningkatkan resiko kesehatan bagi ibu dan bayi, serta mencegah gangguan tumbuh kembang pada anak. Kb membantu mencegah kehamilan tersebut.
- b. Menciptakan keluarga Berkualitas ; KB memungkinkan orangtua untuk lebih focus memberikan perhatian, kasih sayang dan dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya, sehingga menghasilkan keluarga yang sehat, Bahagia dan sejahtera.
- c. Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk ; Program ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan populasi agar tidak melampaui kemampuan sumber daya manusia.
- d. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB); KB mengurangi resiko kematian ibu dan bayi dengan menjarangkan kehamilan dan menjaga kesehatan reproduksi.
- e. Mencegah Pernikahan Dini dan kehamilan Tidak Diinginkan ; Pelayanan KB meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dan pernikahan dini.
- f. Memberikan kendali atas Keputusan reproduksi; tujuan lain dari program ini adalah untuk memberikan perempuan atas kendali keputusan mereka tentang reproduksi, termasuk menentukan kapan dan berapa banyak anak yang mereka inginkan.

B. Perencanaan Keluarga dan Penggunaan Kontrasepsi Yang Rasional

Tujuan perencanaan keluarga dan penggunaan kontrasepsi rasional adalah untuk mengimbangi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas. Ini melibatkan pemilihan metode kontrasepsi kebutuhan individu, kesehatan, dan kondisi hidup, mendukung pemahaman menyeluruh

tentang berbagai metode kontrasepsi, dan memastikan konsistensi, pemantauan kesehatan rutin, dan komunikasi terbuka antar pasangan.

1 Tujuan Perencanaan Keluarga:

- a. Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk; Menyesuaikan peningkatan populasi dengan ketersediaan sumber daya.
- b. Menciptakan Keluarga Berkualitas; Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan kesejahteraan kepada anggota keluarga.
- c. Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak; Menjaga jarak kelahiran yang ideal akan mengurangi risiko kematian ibu dan bayi.
- d. Penggunaan Kontrasepsi Rasional; berarti memilih metode yang tepat, aman, nyaman, dan sesuai dengan kondisi kesehatan, usia dan kebutuhan pasangan.

Prinsip-prinsip kontrasepsi rasional:

1) Pemilihan Metode yang tepat

Pilih metode kontrasepsi yang paling cocok untuk calon akseptor dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti keamanan, efektifitas, efek samping dan cocok dengan gaya hidup akseptor.

2) Penggunaan yang Konsisten

Lakukan penggunaan metode kontrasepsi secara teratur dan sesuai petunjuk untuk menjaga efektivitasnya.

3) Pemantauan Kesehatan Berkala

Lakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kesehatan dan efektivitas metode kontrasepsi yang digunakan

4) Keterbukaan dan Konsultasi

Berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan dan jangan ragu berkonsultasi dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) atau tenaga kesehatan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan dukungan.

(Suryaningsih & Sukriani, 2023)

2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemilihan Kontrasepsi

a. Kondisi kesehatan

Pastikan metode yang dipilih sesuai dengan kondisi kesehatan reproduksi calon akseptor.

b. Usia dan jumlah anak

Usia dan jumlah anak yang dimiliki dapat mempengaruhi pilihan metode, seperti metode jangka pendek atau jangka panjang.

c. Pengetahuan dan Sikap

Pemahaman yang baik tentang metode kontrasepsi akan membantu dalam mengambil keputusan yang tepat.

d. Dukungan suami

Partisipasi dan dukungan suami sangat penting dalam pengambilan keputusan Bersama tentang KB.

e. Factor ekonomi dan Budaya

Factor ekonomi dan norma budaya dapat mempengaruhi akses dan pilihan kontrasepsi.

(Handayani, Nofianti, Padilah, & dkk, 2024)

C. Paradigma Pelayanan Kesehatan KB dulu dan Sekarang

Paradigma pelayanan kesehatan KB sekarang berfokus pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesehatan ibu dan anak daripada kuantitas penduduk. Program KB dulu menekankan “dua anak cukup” untuk mengendalikan jumlah penduduk tetapi sekarang dengan lebih banyak dana dan lebih banyak akses layanan, fokusnya adalah untuk membuat geberasi yang sehat, unggul, dan sejahtera dengan kualitas hidup yang lebih baik.

Tabel 3.1 Perbedaan Paradigma Lama dan Paradigma Sekarang

	Paradigma Lama (Dulu)	Paradigma Sekarang
Fokus Utama	Pengendalian jumlah penduduk	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan keluarga
Jargon	“ Dua Anak Cukup”	
Tujuan	Menurunkan angka kelahiran dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Menciptakan generasi yang sehat dan unggul
Pelayanan	Berpusat pada kontrasepsi untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga	Disediakan lebih gratis melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Didukung peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta alokasi dana yang jauh lebih besar untuk mencapai target kualitas hidup
Pendekatan	-	Holistik, mencakup kesehatan ibu dan anak, serta Pendidikan lebih baik.
Dampak	-	Penurunan angka kematian bayi dan ibu, peningkatan kesehatan dan Pendidikan serta pemberdayaan perempuan

D. Kriteria Kelayakan Metode Kontrasepsi

Faktor medis (seperti penyakit kronis atau riwayat penyakit) dan non-medis (seperti usia, kondisi social ekonomi, keyakinan, rencana masa depan) menentukan kelayakan metode kontrasepsi. Juga mempertimbangkangkan efektivitas, keamanan, dan resiko efek samping.

1. Kriteria Medis (Kesehatan)

1) Kondisi Medis:

Kriteria kelayakan medis yang dibuat oleh WHO atau CDC membagi kondisi medis ke dalam kategori yang membatasi atau tidak membatasi penggunaan kontrasepsi, mempertimbangkan risiko kesehatan yang terkait dengan kehamilan.

2) Efek Hormonal:

Metode kontrasepsi hormonal dapat memiliki kontraindikasi pada kondisi tertentu, seperti penyakit hati atau migrain dengan aura.

3) Kondisi Pasca Melahirkan:

Ibu yang baru melahirkan dan masih menyusui memiliki pertimbangan khusus dalam memilih metode kontrasepsi.

4) Pemeriksaan Kesehatan:

Pemeriksaan medis menyeluruh diperlukan untuk menentukan metode yang paling aman dan efektif bagi individu

2. Kriteria Non medis

a) Usia:

Usia mempengaruhi pilihan kontrasepsi, seperti wanita yang mendekati menopause atau wanita usia muda

b) Kondisi Sosial ekonomi :

Pendapatan, Pendidikan dan pekerjaan juga mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengakses dan menggunakan suatu metode kontrasepsi.

c) Kepercayaan dan Dukungan:

Dukungan dari pasangan dan keluarga sangat penting, begitu juga dengan kepercayaan pada metode kontrasepsi tertentu.

d) Kondisi Psikologis:

Faktor mental dan kebutuhan konseling, khususnya menjadi pertimbangan untuk individu dengan disabilitas mental.

3. Efektivitas dan Keamanan

a) Tingkat Keberhasilan:

Setiap metode kontrasepsi memiliki tingkat efektivitas yang berbeda dalam mencegah kehamilan

b) Perlindungan IMS:

Beberapa metode kontrasepsi seperti kondom, juga memberikan perlindungan terhadap penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS).

c) Risiko dan Manfaat

Penting untuk menimbang antara risiko teoritis atau terbukti dengan manfaat metode yang akan dipilih.

4. Pertimbangan lain

a) Efek samping:

Potensi efek samping yang mungkin timbul harus dipertimbangkan, seperti pendarahan atau perubahan suasana hati.

b) Kemudahan Penggunaan:

Kemudahan cara pemakaian dan kenyamanan menjadi factor penting dalam pemilihan metode kontrasepsi. Beberapa orang lebih memilih metode yang praktis dan mudah digunakan, seperti pila tau suntik. Sementara yang lain lebih nyaman dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD, Implan

c) Biaya:

Biaya untuk metode kontrasepsi dapat menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan.

(2024; Winarniningsih, Sunarni, Kusumastuti, & dkk, 2024)

E. Pengembangan Kriteria Kelayakan Medis Untuk Penggunaan Kontrasepsi

Pengembangan kriteria kelayakan medis (Medical Eligibility Criteria/MEC) untuk penggunaan kontrasepsi merupakan langkah penulisan panduan yang menetapkan apakah seseorang dengan masalah kesehatan tertentu dapat menggunakan metode kontrasepsi dengan aman atau apakah risikonya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Panduan ini dibuat oleh Lembaga seperti WHO dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) melalui kajian ilmiah berbasis bukti, untuk memastikan akses yang aman dan efektif terhadap kontrasepsi, sekaligus membantu penyedia layanan kesehatan dalam memberikan saran yang tepat untuk pasien seperti yang dijelaskan dalam panduan MEC.

Tujuan pengembangan Kriteria kelayakan Medis adalah :

1. Meningkatkan kemudahan dan mutu layanan.
2. Menghapus Batasan medis yang tidak perlu untuk penerapan kontrasepsi.
3. Menyediakan panduan yang berlandaskan bukti
4. Menawarkan rekomendasi yang di dukung oleh penelitian ilmiah yang kuat untuk memastikan keamanan serta efektifitas metode kontrasepsi.
5. Menyesuaikan dengan keadaan setempat
6. Memungkinkan penyesuaian pedoman nasional dengan situasi populasi dan daerah tertentu.

Proses Penyusunan Kriteria Kelayakan Medis

1. Tinjauan ilmiah berdasarkan bukti; Proses ini mencakup analisis ilmiah yang menyeluruh terhadap semua metode kontrasepsi serta kondisi medis atau karakteristik dari klien

2. Penyusunan rekomendasi; dari hasil tinjauan tersebut, rekomendasi dibuat mengenai pemakaian kontrasepsi dalam berbagai kondisi klinis.

Klasifikasi kategori kelayakan medis dibuat untuk mengelompokkan kondisi yang berhubungan dengan metode kontrasepsi, contohnya :

Kategori 1: Tidak ada Batasan terhadap penggunaan.

Kategori 2: Manfaat penggunaan umumnya lebih besar dibandingkan risikonya.

Kategori 3: Risiko biasanya melebihi manfaat.

Kategori 4: Kondisi yang menghadirkan risiko kesehatan yang tidak dapat diterima.

Contoh penerapan (berdasarkan panduan MIC yang diperbarui)

1. Migrain: penggunaan metode kontrasepsi hormonal campuran (CHC) tidak disarankan untuk wanita yang mengalami migrain, karena risiko kejadian stroke yang lebih tinggi menjadikannya sebagai kategori 4.
2. Kanker payudara: kontrasepsi hormonal dianggap tidak direkomendasikan untuk wanita yang saat ini memiliki diagnosa kanker payudara, sementara penggunaan AKDR-Cu dinyatakan aman

Manfaat pemakaian kriteria kelayakan medis

1. Konseling yang fokus pada pasien: memungkinkan penyedia layanan kesehatan memberikan konseling dan layanan kontrasepsi terfokus pada individu.
2. Keputusan yang tepat: Membantu individu dan penyedia layanan kesehatan dalam membuat pilihan yang berdasarkan informasi mengenai metode kontrasepsi yang aman dan efisien. (Novembriani, Kirana, Chandra, & Suprobo, 2025)

F. Penggunaan Rekomendasi Kriteria Kelayakan Medis Untuk Penggunaan

Rekomendasi tentang standar kelayakan medis berfungsi sebagai pedoman yang berdasarkan bukti bagi tenaga medis dalam membuat keputusan klinis yang aman ketika memilih cara kontrasepsi untuk individu dengan berbagai kondisi kesehatan atau latar belakang demografis.

Dokumen ini mendukung penyedia layanan dalam mengatasi hambatan yang tidak perlu, memberikan konseling yang berfokus pada individu, serta menyesuaikan saran dengan konteks dan populasi tertentu untuk meningkatkan akses serta kualitas layanan keluarga berencana secara global.

Tujuan Penggunaan Rekomendasi Kriteria Kelayakan Medis

1. Meningkatkan Keamanan Penggunaan Kontrasepsi: Panduan ini dirancang untuk membantu penyedia layanan dalam menentukan metode kontrasepsi yang paling aman dan efektif bagi klien yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, seperti hipertensi, diabetes, atau riwayat thrombosis.

- 2 Menghilangkan Hambatan Medis yang Tidak Perlu: Dengan adanya rekomendasi berdasarkan bukti, penyedia layanan dapat menghindari pembatasan dalam penggunaan kontrasepsi yang tidak didukung oleh alasan medis yang kuat, sehingga membuka akses yang lebih luas terhadap metode Keluarga Berencana.
- 3 Mendukung Konseling yang Berpusat pada Individu: Kriteria ini memberikan kesempatan bagi penyedia layanan untuk berbicara tentang berbagai pilihan kontrasepsi dengan klien, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing individu, serta mendukung pemilihan metode yang tepat tanpa adanya paksaan.
- 4 Mengembangkan Pedoman Nasional: Rekomendasi ini berfungsi sebagai dasar bagi para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan untuk merancang atau memperbarui pedoman nasional mengenai kriteria kelayakan medis kontrasepsi, sesuai dengan konteks lokal.

Panduan untuk Penyedia Layanan Kesehatan: Penyedia layanan kesehatan bisa merujuk pada dokumen seperti Kriteria Kelayakan medis untuk Pemakaian Kontrasepsi (MEC) dari *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) atau WHO untuk menentukan metode kontrasepsi yang aman bagi klien.
(Winarniningsih, Sunarni, Kusumastuti, & dkk, 2024)

G. Penapisan klien menggunakan kriteria kelayakan medis penggunaan kontrasepsi (KLOP KB)

Penapisan klien menggunakan kriteria kelayakan medis penggunaan kontrasepsi (KLOP KB) adalah proses penilaian kondisi kesehatan klien untuk memastikan metode kontrasepsi yang dipilih aman dan efektif untuk mereka, mencegah risiko kesehatan akibat penggunaan kontrasepsi yang tidak sesuai. Roda KLOP, yang merupakan adaptasi dari Medical Eligibility Criteria (MEC) WHO, membantu konselor kesehatan mengidentifikasi klien dengan kondisi medis atau karakteristik khusus yang memerlukan perhatian, sehingga dapat memilih kontrasepsi yang paling sesuai dengan kondisi klien.

1 Cara kerja KLOP KB adalah :

a. Identifikasi Kondisi Medis Klien:

Konselor menanyakan dan mendata kondisi medis serta karakteristik khusus yang dimiliki klien.

b. Pencocokan dengan Roda KLOP:

Kondisi klien kemudian dicocokkan dengan berbagai metode kontrasepsi yang ada di dalam Roda KLOP.

c. Penilaian Risiko:

Roda KLOP akan menunjukkan apakah suatu metode kontrasepsi aman untuk digunakan oleh klien dengan kondisi tersebut atau apakah ada risiko kesehatan yang perlu diperhatikan

d. Pemilihan Metode yang Aman:

Berdasarkan penilaian tersebut, konselor dapat memberikan rekomendasi metode kontrasepsi yang paling aman dan efektif untuk klien.

(Winarniningsih, Sunarni, Kusumastuti, & dkk, 2024)

Tabel 3.2: Interpretasi dan aplikasi pada Praktik Klinis

Kategori	Deskripsi	Fasilitas Klinik Lengkap (RS)	Fasilitas Klinik Terbatas (Puskesmas)
1	Kondisi tidak ada pembatasan apapun dalam penggunaan metode kontrasepsi	Metode boleh digunakan pada situasi apapun	Metode boleh digunakan
2	Kondisi dimana digunakan penggunaan kontrasepsi lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan risiko secara teori dan risiko yang telah terbukti terjadi	Metode boleh digunakan tetapi memerlukan tindak lanjut	Metode boleh digunakan
3	Kondisi dimana risiko yang telah terbukti lebih besar dibandingkan manfaat penggunaan metode kontrasepsi	Metode yang tidak direkomendasikan untuk digunakan kecuali tidak ada metode lain yang tersedia atau diterima	Metode tidak boleh digunakan
4	Kondisi dengan risiko kesehatan yang tidak dapat diterima pada suatu penggunaan metode kontrasepsi	Metode tidak boleh digunakan	Metode tidak boleh digunakan

(AIPKIND, BKKBN, Kemenkes, & JHPIEGO, 2022)

2 Roda Klop Dalam Bentuk Cetakan



Gambar 3.1: Bagian depan

Langkah-langkah penapisan kelayakan medis menggunakan Roda KLOP

- Tanyakan kondisi dan masalah kesehatan klien dengan menggali riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit dahulu.
- Cocokkanlah kondisi-kondisi medis atau karakteristik khusus dengan menggunakan Roda KLOP, antara yang dimiliki klien (ditunjukkan pada diagram lingkaran disisi luar) dengan metode-metode kontrasepsi (ditunjukkan pada diagram lingkaran sisi dalam),
- Lihatlah rekomendasi penggunaan metode-metode kontrasepsi yang ditunjukkan dengan nomor atau huruf. Nomor atau huruf ini merupakan kategori yang menunjukkan apakah klien dapat mulai menggunakan suatu metode kontrasepsi.
- Selain terdapat pada lingkaran sisi luar, beberapa kondisi medis atau karakteristik khusus tertentu juga dapat dilihat pada diagram lingkaran sisi belakang. Seluruh kondisi medis atau karakteristik khusus yang terdapat pada diagram lingkaran sisi belakang memiliki kategori 1 dan 2, artinya setiap metode kontrasepsi non-sterilisasi dapat digunakan.



Gambar 3.2: Bagian belakang

- e. Jika nomor atau huruf di ikuti kode tertentu (misal 3A,Cu) lihatlah kode tersebut pada diagram lingkaran sisi belakang. Sebagai contoh; pada klien dengan HIV stadium 3 atau AKDR-Cu memiliki kategori 3A. pada diagram lingkaran sisi belakang, keterangan kode A bermakna jika kondisi timbul saat menggunakan metode kontrasepsi ini, kontrasepsi tersebut dapat dilanjutkan selama pengobatan. Hal ini berarti klien dengan HIV stadium 3 atau 4 tidak direkomendasikan untuk memulai penggunaan AKDR-Cu, namun jika HIV stadium 3 atau 4 baru timbul pada saat klien sedang menggunakan AKDR-Cu, maka AKDR-Cu tetap dapat dilanjutkan sesuai jangka waktu pemakaian, dengan syarat klien mendapatkan pengobatan HIV sesuai standar.
- f. Jika diperlukan buatlah table bantu untuk mempermudah penapisan kelayakan medis. Pada kolom kondisi isilah dengan kondisi medis atau karakteristik khusus yang dimiliki klien. Pada kolom metode isilah dengan nomor atau kode rekomendasi yang tertera pada diagram lingkaran.

Tabel 3.3: Contoh tabel yang telah diisi adalah sebagai berikut ;

Kondisi	Metode							
	KIK	PP	DMPA/NET EN	IMPLAN LNG/ETG	AKDR CU	AKDR LNG	TUBEK TOMI	VASEK TOMI
Hipertensi > 160 mmHg	4	2	3	2	1	1	S	-
DM	2	2	2	2	1	2	C	C
Pasca persalinan 48 jam sampai dengan <4 minggu	4	2	3	2	3	3	A/D	-

Berikanlah informasi kepada klien tentang hasil penapisan kelayakan medis sesuai kondisi medis dan karakteristik khusus yang dimiliki klien

Informasi yang di berikan meliputi:

1. Metode yang direkomendasikan adalah metode yang berada dalam kategori 1 atau 2 (untuk metode non-sterilisasi), serta A atau C (untuk metode sterilisasi).

Pada contoh di atas, untuk klien post-partum 48 jam s/d < 4 minggu dengan hipertensi > 160 mmHg dan diabetes melitus, metode kontrasepsi yang direkomendasikan adalah:

- Pil progestin saja, atau
- Implan LNG/ETG, atau
- Vasektomi (untuk suami klien)

2. Metode kontrasepsi yang tidak direkomendasikan

Metode yang tidak direkomendasikan adalah metode yang berada dalam kategori 3 atau 4 (untuk metode non-sterilisasi) dan D atau S (untuk metode sterilisasi).

Pada contoh diatas, untuk klien post-partum 48 jam s/d <4 minggu dengan hipertensi > 160 mmHg dan diabetes melitus, metode kontrasepsi yang tidak direkomendasikan adalah yang selain metode pada butir (a).

- g. Berikanlah informasi bahwa metode yang tidak direkomendasikan ini mungkin dapat memperburuk kondisi medis atau membuat resiko kesehatan tambahan pada klien. Selain itu, kondisi medis atau karakteristik khusus yang dimiliki klien juga dapat mempengaruhi efektivitas metode kontrasepsi yang tidak direkomendasikan tersebut. Bila klien setuju dengan penapisan, lanjutkan dengan permintaan *informed consent* dan pemberian pelayanan kontrasepsi sesuai standart
- h. Bila klien tidak setuju dengan hasil penapisan, lakukanlah konseling ulang pada kunjungan berikutnya atau berikanlah kesempatan pada klien untuk berdiskusi Bersama pasangan. Sementara itu, anjurkan klien dengan pasangan untuk menggunakan kontrasepsi metode barrier/kondom. (AIPKIND, BKKBN, Kemenkes, & JHPIEGO, 2022)

H. Latihan

Pilihan Ganda

1. Tujuan dari KB adalah
 - A. Menunda / mencegah kehamilan
 - B. Menunda kehamilan bagi PUS (Pasangan Usia Subur) dengan usia istri kurang dari 20 tahun dianjurkan untuk menunda kehamilannya

- C. Umur dibawah 20 tahun adalah usia yang sebaiknya tidak mempunyai anak dulu karena berbagai alasan
 - D. Prioritas penggunaan kontrasepsi pil oral, karena peserta masih muda
 - E. Membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara mengatur kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya
2. Pengembangan kriteria kelayakan medis untuk penggunaan kontrasepsi adalah kecuali
- A. Kondisi yang tidak ada Batasan untuk penggunaan metode kontrasepsi
 - B. Suatu kondisi dimana keuntungan menggunakan metode umumnya lebih besar dari pada risiko
 - C. Suatu kondisi dimana resiko teoritis atau terbukti biasanya lebih besar daripada keuntungan menggunakan metode ini
 - D. Suatu keadaan yang yang lebih besar keuntungannya
 - E. Suatu kondisi yang memiliki risiko Kesehatan yang tidak dapat diterima jika metode kontrasepsi digunakan
3. Seorang perempuan telah melahirkan anak ke 3. Tekanan darah sekarang 160/90 mmhg. sesuai dengan roda KLOP klien boleh menggunakan metode kontrasepsi
- A. Kode 8 Tubektomi
 - B. Kode 0 Vasektomi
 - C. Kode 2 Implan
 - D. Kode 3 DMPA
 - E. Kode 4 Kontrasepsi hormonal
4. Tujuan dari penapisan kelayakan KB adalah
- A. Perlindungan terhadap IMS
 - B. Mencegah kehamilan yang tidak di inginkan
 - C. Menilai kondisi kesehatan lain
 - D. Memberikan informasi yang jelas tentang KB
 - E. Klien dapat memberikan keputusan yang matang
5. Faktor yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi adalah
- A. Usia dan jumlah anak
 - B. Pemilihan Metode yang tepat
 - C. Penggunaan yang Konsisten
 - D. Pemantauan Kesehatan Berkala
 - E. Keterbukaan dan Konsultasi

Essay

1. Tujuan pengembangan Kriteria kelayakan Medis adalah
2. Yang termasuk Kriteria medis dalam Kelayakan Metode Kontrasepsi adalah
3. Sebutkan cara kerja KLOP KB

Kunci Jawaban

1. E
2. D
3. C
4. B
5. A

I. Rangkuman Materi

Metode Penapisan kelayakan Kb adalah proses konseling yang bertujuan menyaring kondisi medis dan psikologis akseptor untuk menentukan kesesuaian dan keamanan metode kontrasepsi yang dipilih, seringkali menggunakan alat bantu seperti RODA KLOP yang berisi pertanyaan tentang kehamilan dan gejala, kondisi kesehatan, serta kebutuhan khusus akseptor untuk mencegah efek samping dan memaksimalkan manfaat kontrasepsi.

RODA KLOP bermanfaat bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) terutama untuk meningkatkan kemampuan penapisan kelayakan medis dalam menentukan metode kontrasepsi yang paling sesuai dan aman bagi akseptor, meningkatkan kualitas pelayanan kontrasepsi serta mempermudah pengambilan keputusan konseling KB dengan memastikan metode yang dipilih tidak memperburuk kondisi medis klien. Penggunaan RODA KLOP juga bertujuan mengurangi hambatan medis dan meningkatkan akses serta kualitas pelayanan KB secara keseluruhan.

J. Glosarium

CDC (Centers for Disease Control and Prevention): sebuah badan kesehatan masyarakat Amerika Serikat yang berfokus pada pengendalian penyakit dan pemahaman kesehatan.

IMS (Infeksi Menular Seksual): infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit dan dapat menyebar dari satu orang ke orang lain melalui aktivitas seksual seperti seks vaginal, anal, atau oral.

KB (Keluarga Berencana) : sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak demi mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.

MEC(Medical Eligibily Criteria): panduan berbasis bukti yang memberikan rekomendasi kepada penyedia layanan kesehatan mengenai klien mana yang dapat menggunakan metode kontrasepsi tertentu dengan aman, berdasarkan kondisi medis dan karakteristik individu mereka.

MKJP(Metode Kontrasepsi Jangka Panjang): sebuah program keluarga berencana yang menggunakan alat kontrasepsi efektif dan aman untuk menunda, menjarangkan, atau menghentikan kehamilan dalam jangka waktu yang lama.

Paradigma : model utama, pola, system, atau cara pandang fundamental yang membentuk kerangka berfikir seseorang dalam memahami, menafsirkan, dan berinteraksi dengan dunia.

RODA KLOP: singkatan dari Diagram Lingkaran dan Penerapan Kriteria kelayakan Medis dalam Penggunaan Kontrasepsi, yaitu sebuah alat bantu berbentuk lingkaran yang dimodifikasi dari alat dari WHO untuk membantu konselor atau petugas kesehatan memilih metode kontrasepsi yang paling man dan tepat bagi akseptor berdasarkan kondisi medis dan karakteristik khusus klien.

SDM (sumber daya manusia): manusia yang bekerja dan berkontribusi melalui keterampilan, pengetahuan dan daya fisik serta mental

WHO (World health Organization): Organisasi Kesehatan Dunia

K. References

- AIPKIND, BKKBN, Kemenkes, & JHPIEGO. (2022). Modul Keluarga Berencana Untuk Pendidikan sarjana dan Profesi Bidan. Jakarta.
- Handayani, D., Nofianti, N., Padilah, A., & dkk. (2024). Kontrasepsi: Jenis, Penggunaan dan Pertimbangan. Indramayu, Jawa Barat: PT.Adab Indonesia.
- Novembriani, R. P., Kirana, W., Chandra, A., & Suprobo, N. R. (2025). Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan: KB dan Pelayanan Kontrasepsi Bagi pembangunan Masyarakat. Malang, Jawa Timur: Kramantara Jaya Sentosa.
- Suryaningsih, E. K., & Sukriani, W. (2023). Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Sleman; Yogyakarta: Deepublish.
- Wahyuni, C., Huri'in, N. M., & dkk. (2024). Buku Ajar Keluarga Berencana (KB) dan Pelayanan. Jakarta: PT. Nuansa Fajar Cemerlang.
- Wahyuni, C., Kurniawati, I., Chairiyah, R., & Hakiki, M. (2023). Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta: Mahakarya Citra utama Group.
- Winarniningsih, R. A., Sunarni, N., Kusumastuti, I., & dkk. (2024). Keluarga Berencana. Makasar: CV Tohar Media.

BAB 5

METODE KONTRASEPSI SEDERHANA, BARRIER, STEROID, MEKANIK, KIMIA DAN PEMBEDAHAN, TERMASUK CARA KERJA, INDIKASI, MANFAAT DAN RISIKO

Pendahuluan

Keluarga berencana adalah upaya yang bertujuan mengatur jumlah anak serta jarak kelahiran sesuai dengan keinginan pasangan. Untuk mendukung hal ini, pemerintah melaksanakan berbagai program yang berfungsi untuk mencegah atau menunda kehamilan (Sulistyawati, 2013).

Istilah kontrasepsi berasal dari kata kontra, yang berarti mencegah atau menolak, dan konsepsi, yang merujuk pada pertemuan antara sel telur matang dengan sperma sehingga terjadi kehamilan. Dengan demikian, kontrasepsi dapat diartikan sebagai langkah untuk menghindari kehamilan, baik secara sementara maupun permanen, melalui penggunaan metode, alat, maupun obat-obatan.

Kontrasepsi sederhana dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanpa alat dan dengan alat/obat. Kontrasepsi tanpa alat meliputi senggama terputus, pantang berkala, metode kalender, dan metode suhu basal tubuh. Sedangkan kontrasepsi dengan alat atau obat mencakup kondom, diafragma, kap serviks, dan spermisida.

Tujuan utama kontrasepsi adalah melindungi kesehatan ibu dan anak, mengurangi risiko kehamilan pada usia muda, serta membantu tercapainya keluarga kecil yang sehat dan sejahtera. Berdasarkan usia reproduksi, ada tiga tahapan yang dianjurkan:

1. Masa penundaan kehamilan bagi pasangan usia subur ketika istri berusia di bawah 20 tahun.
2. Masa penjarangan kehamilan saat istri berusia 20–35 tahun, usia yang paling ideal untuk melahirkan, dengan jumlah anak dianjurkan dua orang dan jarak kelahiran 3–4 tahun.
3. Masa penghentian kehamilan, yaitu setelah pasangan memiliki dua anak atau lebih.

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang pilihan metode kontrasepsi bagi pasangan usia subur dan menjelaskan bentuk-bentuk kontrasepsi sederhana dalam rangka mendukung kesehatan ibu dan anak.

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kontrasepsi.
2. Mahasiswa mampu mendefinisikan kontrasepsi sederhana.
3. Mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis kontrasepsi sederhana tanpa alat/obat, serta memahami mekanisme kerja, indikasi, manfaat, dan risikonya.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai kontrasepsi sederhana dengan alat/obat (barrier), disertai pemahaman mengenai mekanisme kerja, indikasi, manfaat, dan risiko.
5. Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme kerja, indikasi, manfaat, dan risiko dari kontrasepsi sederhana tanpa alat/obat.

Capaian Pembelajaran

Melalui pemahaman Bab ini, mahasiswa akan mencapai capaian pembelajaran antara lain:

1. Sikap

Menunjukkan sikap profesional, empati, menghargai hak reproduksi, serta menjunjung tinggi etika kebidanan dalam pelayanan KB.

2. Pengetahuan

Memahami konsep, jenis kontrasepsi, cara kerja, indikasi, manfaat, serta risiko kontrasepsi dalam pelayanan kontrasepsi dan keluarga berencana.

3. Keterampilan Umum

Mampu mengkomunikasikan ide dan konsep KB secara jelas kepada masyarakat, serta melakukan advokasi yang relevan.

4. Keterampilan Khusus

Mampu melakukan analisis sederhana terhadap isu-isu KB di lapangan, dan merancang pendekatan kebidanan yang tepat sesuai konteks budaya dan sosial masyarakat.

A. Konsep Dasar Kontrasepsi

Istilah kontrasepsi berasal dari gabungan kata kontra dan konsepsi. Kata kontra berarti menahan atau mencegah, sedangkan konsepsi merujuk pada pertemuan antara sel telur matang (ovum) dengan sperma yang dapat menyebabkan kehamilan. Dengan demikian, kontrasepsi dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah kehamilan akibat proses pembuahan.

Tujuan kontrasepsi adalah untuk pasangan yang aktif secara seksual, memiliki kesuburan normal, tetapi belum atau tidak ingin mengalami kehamilan (Fatonah, S.H.S., dkk., 2023). Secara umum, kontrasepsi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kontrasepsi sederhana dan kontrasepsi modern (Sukarni, 2020; Manuaba, 2019)..

Menurut Prijatni dan Rahayu (2016), syarat-syarat kontrasepsi yang ideal meliputi:

1. Penggunaannya aman dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi.
2. Tidak menimbulkan efek samping yang merugikan.
3. Mekanisme kerjanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan pasangan.
4. Tidak mengganggu aktivitas hubungan seksual.
5. Tidak memerlukan intervensi medis maupun pengawasan ketat selama penggunaan.
6. Praktis digunakan, memiliki harga yang terjangkau, dan dapat diakses oleh masyarakat luas.
7. Dapat diterima serta disepakati oleh kedua pasangan suami istri.

B. Kontrasepsi Sederhana

Kontrasepsi sederhana merupakan metode pencegahan kehamilan yang dapat dilakukan secara mandiri tanpa bantuan tenaga kesehatan serta tidak memerlukan penggunaan alat medis yang kompleks.

Secara umum, metode kontrasepsi sederhana terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tanpa alat dan dengan alat. Kontrasepsi sederhana tanpa alat mencakup metode alamiah (seperti metode kalender, pengukuran suhu basal tubuh, pengamatan lendir serviks, dan metode sympto-thermal), metode amenore laktasi (MAL), serta coitus interruptus atau senggama terputus. Metode alamiah pada prinsipnya bertujuan meningkatkan pemahaman pasangan mengenai sistem reproduksi, relatif aman karena tidak menimbulkan efek samping sistemik, namun membutuhkan latihan dan keterlibatan aktif dari kedua pasangan. Sementara itu,

metode MAL hanya efektif jika ibu menyusui bayinya secara eksklusif, sehingga metode ini lebih dianjurkan bagi ibu yang tidak bekerja di luar rumah.

Adapun kontrasepsi sederhana dengan alat dapat dibedakan menjadi metode mekanik, seperti kondom dan diafragma, serta metode kimiawi menggunakan spermisida. Pada praktiknya, kedua jenis metode ini sering dikombinasikan untuk meningkatkan efektivitas, sehingga risiko kegagalan dapat ditekan seminimal mungkin.

C. Macam-macam Kontrasepsi Sederhana tanpa alat (alamiah)

1. Metode Kalender/Pantang Berkala

a. Pengertian

Metode kalender, yang juga dikenal sebagai pantang berkala, merupakan salah satu bentuk kontrasepsi alami. Cara ini dilakukan dengan menghindari hubungan seksual pada masa subur wanita yang ditentukan berdasarkan perhitungan siklus menstruasi. (BKKBN, 2020).

Metode kalender, atau yang sering disebut pantang berkala, hanya efektif diterapkan pada wanita dengan siklus menstruasi yang teratur. Prinsip utama metode ini adalah menghindari hubungan seksual selama masa subur istri. (Irianto, 2014).

Perhitungan masa subur dengan metode kalender dilakukan dengan menentukan periode pantang, yaitu hari-hari di mana pasangan sebaiknya tidak melakukan hubungan seksual. Rumus yang digunakan adalah:

- 1) Hari pertama masa subur = panjang siklus haid terpendek – 18
- 2) Hari terakhir masa subur = panjang siklus haid terpanjang – 11

Dengan demikian, pasangan perlu mencatat siklus menstruasi selama beberapa bulan terlebih dahulu untuk mengetahui kisaran siklus terpendek dan terpanjang, sehingga masa subur dapat dihitung secara lebih akurat..

b. Cara Kerja:

1) Menghitung Masa Subur Berdasarkan Siklus Haid

- a) Masa subur pada wanita biasanya terjadi sekitar dua minggu sebelum menstruasi berikutnya, yaitu saat ovulasi berlangsung.
- b) Sperma dapat tetap hidup dalam tubuh wanita selama 3–5 hari, sementara sel telur hanya mampu bertahan sekitar 24 jam setelah dilepaskan saat ovulasi.

2) Perhitungan Hari Subur

- a) Pada wanita dengan siklus menstruasi teratur (28 hari), masa subur biasanya berada pada hari ke-10 hingga hari ke-17, dihitung dari hari pertama menstruasi.

b) Untuk mencegah kehamilan, pasangan dianjurkan menghindari hubungan seksual selama rentang masa subur tersebut.

3) Hubungan Seksual di Luar Masa Subur

Agar lebih aman, hubungan seksual sebaiknya dilakukan di luar periode masa subur, yaitu sebelum hari ke-10 atau setelah hari ke-17 dari siklus menstruasi. (BKKBN, 2021).

c. Indikasi:

- 1) Dapat digunakan oleh wanita maupun pasangan pada semua kelompok usia subur.
- 2) Cocok untuk semua paritas, termasuk wanita yang belum pernah melahirkan (nullipara).
- 3) Pasangan harus memiliki kesediaan untuk menahan hubungan seksual selama lebih dari satu minggu dalam setiap siklus.
- 4) Pasangan bersedia serta termotivasi untuk mengamati, mencatat, dan menafsirkan tanda-tanda kesuburan secara konsisten.

d. Manfaat

Metode kalender, atau pantang berkala, memiliki dua kegunaan utama, yakni untuk mencegah atau merencanakan kehamilan. Sebagai metode kontrasepsi, teknik ini membantu pasangan menghindari kehamilan dengan menahan hubungan seksual selama masa subur. Sebaliknya, bagi pasangan yang ingin memiliki anak, metode ini dapat digunakan untuk meningkatkan peluang kehamilan dengan melakukan hubungan seksual pada periode ovulasi.

e. Risiko

Berpantang dalam jangka waktu yang terlalu lama sering kali sulit ditoleransi, terutama jika periode pantang terasa cukup panjang.

2. Metode Suhu Basal

a. Pengertian

Metode pengukuran suhu basal tubuh digunakan untuk mengetahui waktu ovulasi karena hormon progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum menyebabkan kenaikan suhu basal (Dewi, 2013). Suhu basal tubuh adalah suhu terendah yang dicapai tubuh saat beristirahat penuh, biasanya saat tidur. Pengukuran dilakukan setiap pagi segera setelah bangun, sebelum melakukan aktivitas apapun, menggunakan termometer basal secara oral, vaginal, atau rektal (Irianto, 2014).

Perubahan suhu basal ini dapat menjadi indikator masa subur. Menjelang ovulasi, suhu basal biasanya menurun selama kurang lebih 24 jam. Setelah ovulasi, suhu akan meningkat dan tetap lebih tinggi dibandingkan sebelum ovulasi. Pola perubahan ini dapat digunakan untuk memperkirakan masa subur maupun masa aman bagi pasangan.

b. Langkah-langkah Metode Suhu Basal Tubuh

- 1) Suhu basal tubuh diukur setiap pagi pada waktu yang sama sebelum bangun dari tempat tidur, kemudian dicatat pada kartu yang telah disediakan oleh instruktur KBA.
- 2) Catatan suhu selama 10 hari pertama siklus menstruasi digunakan untuk menentukan suhu tertinggi dalam kondisi normal, dengan mengabaikan kenaikan suhu akibat demam atau gangguan lain.
- 3) Selanjutnya, dibuat garis pada $0,05^{\circ}\text{C}$ – $0,1^{\circ}\text{C}$ di atas suhu tertinggi tersebut, yang dikenal sebagai garis pelindung (cover line) atau garis suhu.
- 4) Masa tidak subur dimulai pada sore hari setelah suhu basal tubuh berada di atas garis pelindung selama tiga hari berturut-turut.

c. Syarat

- 1) Diperuntukkan bagi wanita yang bersedia mengamati serta mencatat tanda-tanda kesuburannya.
- 2) Lebih sesuai bagi wanita dengan siklus menstruasi yang relatif teratur.
- 3) Cocok bagi pasangan yang tidak dapat atau tidak ingin menggunakan metode kontrasepsi lain.
- 4) Dapat diterapkan pada pasangan yang tidak keberatan apabila terjadi kemungkinan kehamilan.

d. Kelebihan

- 1) Membantu pasangan memahami dan menyadari masa subur wanita.
- 2) Membantu wanita dengan siklus menstruasi yang tidak teratur dalam mendeteksi waktu ovulasi.
- 3) Dapat mengidentifikasi perubahan fisiologis lain, seperti karakter lendir serviks.
- 4) Memberikan kontrol penuh kepada wanita dalam penerapan metode ini.
- 5) Dapat digunakan baik untuk mencegah kehamilan maupun untuk meningkatkan peluang konsepsi.

e. Risiko

Masa pantang yang terlalu panjang dapat menimbulkan stres atau rasa frustrasi pada pasangan. Kondisi ini dapat diatasi dengan penggunaan kondom atau tablet vaginal (spermisida) saat berhubungan seksual.

3. Metode Lendir Serviks

a. Pengertian

Perubahan karakter lendir serviks sepanjang siklus menstruasi dipengaruhi terutama oleh hormon estrogen. Pada fase praovulasi, pola lendir dapat dijadikan indikator untuk mengenali masa tidak subur. Saat ovarium berada pada kondisi istirahat, kadar estrogen dan progesteron menurun, sehingga tidak muncul sensasi lembap maupun lendir pada area vulva (Jitowiyono, 2019).

Sekresi lendir serviks diatur oleh kerja hormon estrogen dan progesteron. Bagi wanita dengan siklus menstruasi yang tidak teratur, tanda-tanda masa subur dapat dipantau melalui pemeriksaan lendir serviks yang diproduksi oleh kelenjar pada leher rahim. Cara pemeriksaannya dilakukan dengan memasukkan jari ke dalam vagina, kemudian menariknya perlahan untuk melihat konsistensi lendir. Apabila lendir tampak jernih, licin, dan elastis, hal ini menandakan ovulasi akan segera berlangsung. Dalam kondisi tersebut, pasangan sebaiknya menghindari hubungan seksual dalam kurun 24–72 jam berikutnya (Dewi, 2013).

b. Cara Kerja

Metode lendir serviks dilakukan dengan mengamati perubahan cairan yang dihasilkan oleh leher rahim. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan merasakan perbedaan sensasi pada vulva sepanjang hari atau dengan melihat langsung kondisi lendir serviks pada waktu tertentu. Pada masa puncak kesuburan, yaitu menjelang dan saat ovulasi, lendir biasanya lebih banyak, encer, jernih, dan elastis menyerupai putih telur, serta dapat diregangkan di antara dua jari seperti benang. Setelah tiga hari berlalu dari puncak masa subur, hubungan seksual dapat dilakukan tanpa kontrasepsi karena kemungkinan terjadinya kehamilan sudah menurun.

c. Kriteria

- 1) Dapat digunakan oleh semua wanita usia reproduktif, baik dengan siklus menstruasi teratur maupun tidak, termasuk pada masa menyusui atau menjelang menopause.
- 2) Sesuai untuk semua paritas, termasuk wanita yang belum pernah melahirkan (nulipara).
- 3) Efektif bagi wanita dengan kondisi tubuh kurus maupun gemuk.
- 4) Masih dapat diterapkan pada wanita yang merokok.
- 5) Aman digunakan pada wanita dengan kondisi medis tertentu, seperti hipertensi ringan hingga sedang, varises, dismenore, sakit kepala sedang–

berat, mioma uteri, endometritis, kista ovarium, anemia defisiensi besi, hepatitis virus, malaria, maupun trombosis vena dalam.

- 6) Dapat menjadi pilihan bagi wanita yang tidak dapat memakai metode kontrasepsi lainnya.
- 7) Sesuai bagi pasangan yang siap menjalani pantang hubungan seksual lebih dari satu minggu dalam setiap siklus haid.

d. Manfaat

Metode mukosa lendir serviks dapat digunakan sebagai cara mencegah kehamilan dengan menghindari hubungan seksual pada masa subur. Sebaliknya, metode ini juga bermanfaat bagi wanita yang ingin memperoleh keturunan, yaitu dengan melakukan hubungan seksual pada periode subur untuk memperbesar kemungkinan terjadinya pembuahan.

4. Metode Amenorrhoe Laktasi (MAL)

a. Pengertian

Metode kontrasepsi ini bertumpu pada pemberian ASI eksklusif kepada bayi tanpa tambahan makanan maupun minuman lain. Cara ini memiliki efektivitas lebih dari 98% dalam mencegah kehamilan selama enam bulan pertama pascapersalinan.

b. Cara Kerja

Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama dapat menekan pelepasan hormon reproduksi sehingga berfungsi sebagai pencegah kehamilan. Metode ini terbukti efektif hingga 98% apabila memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- 1) Proses menyusui dilakukan secara penuh atau hampir sepenuhnya.
- 2) Bayi menyusu langsung dari payudara, bukan menggunakan botol.
- 3) Menyusui sudah dimulai dalam 30 menit hingga 1 jam setelah kelahiran bayi.
- 4) Interval menyusui tidak melebihi 4 jam.
- 5) Menyusui dilakukan sesering mungkin sepanjang 24 jam, termasuk pada malam hari.

c. Syarat Keberhasilan MAL

- 1) Ibu belum mengalami menstruasi sejak melahirkan hingga enam bulan pascapersalinan.
- 2) Bayi mendapatkan ASI secara eksklusif selama enam bulan, tanpa tambahan makanan maupun minuman lain.
- 3) Usia bayi masih di bawah enam bulan.

d. Manfaat

- 1) Manfaat MAL bagi kesehatan Ibu

- a) Membantu menurunkan risiko perdarahan pasca persalinan.
 - b) Mengurangi kemungkinan terjadinya anemia pada ibu.
 - c) Menurunkan risiko kanker payudara.
 - d) Mempererat ikatan emosional antara ibu dan bayi.
 - e) Membantu mengembalikan berat badan ibu ke kondisi semula setelah melahirkan.
- 2) Manfaat MAL bagi bayi
- a) Memberikan kekebalan alami karena mengandung antibodi, sehingga bayi lebih terlindungi dari berbagai penyakit.
 - b) Menjadi sumber nutrisi yang lengkap dan ideal untuk mendukung tumbuh kembang bayi secara optimal.
 - c) Aman dari risiko kontaminasi yang mungkin berasal dari air, peralatan minum, susu formula, maupun makanan tambahan lainnya.

5. Metode Simptotermal

a. Pengertian

Metode simptotermal merupakan salah satu jenis keluarga berencana alamiah (KBA) yang bertujuan untuk mengenali masa subur dalam siklus menstruasi wanita. Cara ini biasanya menggabungkan dua indikator utama, yaitu suhu basal tubuh dan perubahan lendir serviks. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa metode ini dapat mencakup tiga indikator sekaligus, yakni pola perubahan suhu basal, karakteristik lendir serviks, serta perhitungan masa subur dengan metode kalender (Jitowiyono, 2019). Tingkat kegagalan metode simptotermal diperkirakan sekitar 10–20 kehamilan per 100 pasangan dalam kurun waktu satu tahun penggunaan.

b. Cara Kerja

Pengguna metode simptotermal perlu memperoleh edukasi atau panduan mengenai penerapan metode lendir serviks, suhu basal tubuh, serta perhitungan kalender. Pemahaman tersebut penting agar pengguna dapat mengenali masa subur melalui pengamatan perubahan suhu basal maupun kondisi lendir serviks.

c. Hal yang perlu diperhatikan

- 1) Pencatatan perlu dilakukan dengan teratur, konsisten, dan tepat.
- 2) Tidak dianjurkan menggunakan kontrasepsi hormonal karena dapat mengganggu siklus menstruasi dan pola kesuburan.
- 3) Disarankan memakai metode penghalang (seperti kondom) sebagai upaya tambahan untuk mencegah kehamilan.

d. Tujuan Penggunaan

- 1) Sebagai metode kontrasepsi (pencegah kehamilan): dilakukan dengan menghindari hubungan seksual selama masa subur.
- 2) Sebagai metode konsepsi (pendukung kehamilan): dilakukan dengan berhubungan seksual pada periode subur untuk memperbesar kemungkinan terjadinya pembuahan

e. Keterbatasan

- 1) Kurang sesuai bagi wanita yang sedang menyusui, memiliki kondisi kesehatan tertentu, baru bepergian jauh, atau sedang mengonsumsi alkohol.
- 2) Efektivitasnya relatif rendah karena pengguna harus secara rutin mencatat suhu basal tubuh dan mengamati perubahan lendir serviks.
- 3) Membutuhkan kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam penerapannya.
- 4) Memerlukan pelatihan atau instruksi yang tepat agar dapat digunakan dengan benar.

6. *Coitus Interruptus* (senggama terputus)

a. Pengertian

Salah satu bentuk kontrasepsi alami adalah senggama terputus (*coitus interruptus*), yaitu teknik ketika pria menarik penis keluar dari vagina sebelum mengeluarkan sperma. Dengan tidak masuknya sperma ke organ reproduksi perempuan, kemungkinan terjadinya kehamilan dapat diminimalkan (BKKBN, 2020; Jitowiyono, 2019).

b. Cara Kerja

- 1) Pria harus mampu mengendalikan waktu ejakulasi selama hubungan seksual.
- 2) Sebelum mencapai puncak klimaks, penis ditarik keluar dari vagina.
- 3) Ejakulasi dilakukan di luar tubuh wanita sehingga sperma tidak masuk ke rahim.
- 4) Dengan tidak terjadinya pertemuan antara sperma dan sel telur, kehamilan dapat dicegah (BKKBN, 2020).

c. Pengguna yang Cocok untuk Metode Senggama Terputus

- 1) Suami yang ingin terlibat langsung dalam pelaksanaan program keluarga berencana.
- 2) Pasangan yang karena alasan agama atau keyakinan tertentu tidak memilih metode kontrasepsi lain.
- 3) Pasangan yang membutuhkan perlindungan kontrasepsi dengan segera.

- 4) Pasangan yang memerlukan metode sementara sebelum beralih ke metode kontrasepsi lain, atau sebagai metode tambahan.
- 5) Pasangan dengan frekuensi hubungan seksual yang tidak menentu.

d. Kelebihan

- 1) Dapat efektif bila dilakukan dengan cara yang benar dan konsisten.
- 2) Tidak memengaruhi produksi ASI, sehingga aman bagi ibu menyusui.
- 3) Bisa digunakan sebagai metode pendukung KB lainnya.
- 4) Tidak menimbulkan efek samping medis.
- 5) Praktis karena dapat digunakan kapan saja.
- 6) Tidak memerlukan biaya.
- 7) Memberikan kesempatan bagi suami untuk lebih terlibat dalam KB.
- 8) Dapat mempererat kedekatan dan saling pengertian dalam hubungan pasangan.

e. Kekurangan

- 1) Efektivitas dapat menurun jika masih terdapat sperma yang menempel pada penis dalam waktu 24 jam setelah ejakulasi sebelumnya.
- 2) Dapat mengurangi kenikmatan dalam hubungan seksual karena adanya penghentian mendadak sebelum ejakulasi.
- 3) Berpotensi menimbulkan ketegangan atau gangguan psikis (seperti rasa cemas atau stres/neurastenia).
- 4) Keberhasilannya sangat bergantung pada kedisiplinan dan kesediaan pasangan untuk selalu melakukan senggama terputus dengan benar setiap kali berhubungan seksual.

D. Macam-macam Kontrasepsi Sederhana dengan alat (barrier)

1. Mekanik (Kondom, diafragma)

a. Kondom

1) Pengertian

Kondom merupakan salah satu metode kontrasepsi berupa selubung tipis yang digunakan saat berhubungan seksual dengan tujuan mencegah sperma masuk ke rahim serta memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual (IMS) (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Terdapat dua jenis kondom yang umum digunakan, yakni kondom pria yang dipasang pada penis dan kondom wanita yang ditempatkan di dalam vagina.

Bahan kondom biasanya terbuat dari lateks (karet), plastik/vinil, atau material alami yang berasal dari hewan, dengan ketebalan rata-rata sekitar 0,02 mm. Alat kontrasepsi ini dipasang pada penis ketika melakukan hubungan seksual dan memiliki fungsi ganda, yaitu mencegah terjadinya

kehamilan sekaligus mengurangi risiko penularan HIV maupun penyakit menular seksual lainnya (Irianto, 2014).

2) Cara Kerja Kondom :

- Kondom bekerja dengan menahan sperma di dalam kantung pada ujung selubung yang dipasang di penis, sehingga mencegah sperma mencapai sel telur dan masuk ke saluran reproduksi wanita.
- Selain mencegah kehamilan, kondom juga berperan sebagai pelindung dari penularan berbagai penyakit menular seksual (IMS), termasuk HIV, AIDS, dan hepatitis B, yang dapat berpindah dari satu pasangan ke pasangan lain (Kemenkes RI, 2021).

3) Indikasi:

- Sebagai upaya pencegahan kehamilan, yaitu untuk menghindari terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.
- Sebagai langkah pencegahan penyakit menular seksual (PMS/IMS), termasuk HIV/AIDS.

4) Manfaat kondom yang tidak dimiliki alat kontrasepsi lain:

- Efektivitas kondom cukup tinggi bila digunakan dengan benar, yaitu dengan memastikan tidak ada kerusakan atau kebocoran sebelum dipakai serta menghindarinya bila terdapat alergi terhadap bahan kondom.
- Kondom relatif terjangkau harganya dan mudah diperoleh di pasaran.
- Memiliki manfaat ganda, yakni sebagai alat kontrasepsi sekaligus pelindung dari penularan IMS, HIV, dan AIDS.
- Aman digunakan oleh ibu menyusui karena tidak mengandung hormon, sehingga tidak memengaruhi produksi ASI.
- Penggunaan kondom juga dapat menurunkan risiko kanker serviks, sebab mampu mengurangi paparan iritasi akibat zat karsinogenik eksogen pada serviks (Dewi, 2013).

b. Diafragma

Diafragma adalah alat kontrasepsi berbahan karet yang berfungsi menutup leher rahim (serviks) sehingga mencegah masuknya sperma ke dalam rahim. Alat ini tersedia dalam berbagai ukuran dan biasanya digunakan bersama dengan jeli atau krim spermisida untuk meningkatkan efektivitasnya.

Pemasangan diafragma harus dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan, dan alat ini perlu dikeluarkan sekitar 8 jam setelah hubungan seksual. Namun, penggunaan diafragma tidak termasuk dalam program KB nasional karena efektivitasnya relatif rendah serta harganya cukup mahal (Irianto, 2014).

2. Kimiawi (Spermisid)

a. Pengertian

Spermisida adalah zat kimia yang berfungsi untuk melemahkan atau membunuh sperma sehingga tidak mampu membuahi sel telur. Spermisida tersedia dalam berbagai bentuk sediaan, seperti aerosol, krim, tablet vagina, suppositoria, maupun lembaran film yang dapat larut. Mekanisme kerjanya adalah dengan merusak membran sel sperma, memperlambat pergerakan, serta menurunkan daya fertilisasinya.

Penggunaan spermisida dilakukan sebelum hubungan seksual, dengan cara memasukkannya ke dalam vagina. Hubungan seksual baru dapat dilakukan setelah sekitar 5–10 menit pemasangan. Namun, tingkat efektivitasnya rendah jika digunakan secara tunggal. Oleh karena itu, spermisida biasanya dipadukan dengan metode kontrasepsi lain, seperti diafragma, untuk meningkatkan keberhasilannya. Banyak pasangan mengalami kesulitan dalam penggunaannya, sehingga efektivitasnya sering kali tidak optimal (Irianto, 2014).

b. Cara Kerja

Spermisida bekerja dengan cara membunuh sel sperma atau menghalangi pergerakannya sehingga tidak dapat mencapai sel telur. Penggunaannya dilakukan dengan memasukkan spermisida ke dalam vagina, dekat leher rahim, beberapa saat sebelum melakukan hubungan seksual.

Setelah dimasukkan, diperlukan waktu sekitar 10–15 menit agar zat kimia ini larut dan menyebar secara merata. Spermisida hanya efektif selama kurang lebih satu jam setelah aplikasi. Selain itu, wanita dianjurkan untuk tidak melakukan douching (mencuci vagina) setidaknya enam jam setelah berhubungan seksual, agar efektivitas kontrasepsi tetap terjaga.

c. Kontraindikasi

- 1) Wanita yang mengidap HIV atau AIDS.
- 2) Mereka yang berisiko tinggi tertular HIV atau AIDS.
- 3) Wanita yang sering mengalami infeksi saluran kemih.
- 4) Pasangan dengan risiko tinggi kehamilan, misalnya wanita berusia di bawah 30 tahun atau yang berhubungan seksual tiga kali atau lebih dalam seminggu.

E. Metode Kontrasepsi dengan Pembedahan

1. Vasektomi

a. Pengertian

Vasektomi, yang juga dikenal sebagai sterilisasi pria, adalah metode kontrasepsi permanen yang dilakukan melalui tindakan medis berupa pemotongan serta pengikatan saluran sperma (vas deferens) di kedua sisi (BKKBN & Skata, 2018).

Tindakan ini bertujuan mencegah sperma keluar dari testis untuk bercampur dengan cairan mani saat ejakulasi. Walaupun produksi sperma di testis tetap berlangsung, sperma yang tidak tersalurkan akan dihancurkan dan diserap kembali oleh tubuh. Cairan sperma diserap melalui membran pada epididimis, sedangkan bagian padatnya diuraikan oleh makrofag dan kemudian dialirkan melalui darah (Irianto, 2014).

Dari segi keberhasilan, vasektomi memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi, yakni mencapai 99,9%, dengan kemungkinan hanya 0,1 kehamilan pada setiap 100 perempuan dalam tahun pertama setelah prosedur dilakukan.

b. Manfaat

Vasektomi adalah salah satu metode kontrasepsi permanen yang terbukti memiliki efektivitas tinggi dalam mencegah kehamilan. Tindakan ini tidak memberikan dampak negatif jangka panjang dan tidak mengurangi kualitas hubungan seksual. Dari aspek medis, vasektomi termasuk prosedur yang aman, sederhana, serta dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat (L.I. Sirait & Siantar, 2020).

c. Risiko

Beberapa efek samping yang mungkin muncul setelah vasektomi meliputi hematoma (perdarahan di bawah kulit), pingsan, bradikardia, depresi, henti napas, serta gangguan pada sistem kardiovaskular tertentu (L.I. Sirait & Siantar, 2020).

2. Tubektomi

a. Pengertian

Sterilisasi pada wanita merupakan metode kontrasepsi permanen yang ditujukan bagi perempuan yang tidak lagi merencanakan kehamilan. Prosedur ini dilakukan dengan cara mengikat, memotong, atau menempatkan cincin berbahan lunak yang aman pada kedua saluran tuba (BKKBN & Skata, 2018).

Tubektomi, sebagai salah satu bentuk sterilisasi wanita, merupakan metode yang sangat efektif dan bersifat permanen. Tindakan ini umumnya dilakukan melalui pembedahan sederhana dengan teknik memotong, mengikat, atau memasang cincin pada tuba falopi untuk mencegah terjadinya pembuahan (Irianto, 2014). Dari segi efektivitas, tubektomi tergolong sangat

tinggi, yaitu mencapai sekitar 99,5%, dengan kemungkinan hanya 0,5 kehamilan per 100 wanita pada tahun pertama pascaprosedur.

b. Cara Kerja

Prosedur tubektomi dilakukan melalui pembedahan kecil dengan pemberian anestesi lokal. Tindakan ini dilakukan dengan cara memotong, mengikat, atau menempatkan cincin pada saluran tuba sehingga pertemuan antara sel telur dan sperma tidak terjadi, yang pada akhirnya mencegah proses pembuahan dan kehamilan.

c. Indikasi

- 1) Usia lebih dari 26 tahun
- 2) Jumlah anak lebih dari 2 orang
- 3) Yakin telah mempunyai jumlah anak sesuai dengan harapan keluarga

d. Manfaat

Metode tubektomi terbukti sangat efektif dan bersifat permanen. Prosedur ini tidak memengaruhi kadar hormon, tidak menimbulkan efek samping jangka panjang, dan tidak mengganggu aktivitas seksual. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa hubungan seksual tetap aman dan dapat terasa lebih menyenangkan setelah tubektomi (Ati et al., 2022).

e. Risiko

Beberapa risiko yang mungkin muncul setelah tubektomi meliputi trauma atau cedera jaringan, infeksi pascaoperasi, perdarahan, komplikasi akibat penggunaan obat anestesi, serta kemungkinan terjadinya kehamilan ektopik (Andriana et al., 2022).

F. Latihan

Pilihan Ganda

1. Metode KB Kalender atau Pantang Berkala termasuk ke dalam jenis kontrasepsi:
 - A. KB Hormonal?
 - B. KB Hormonal
 - C. KB Alamiah
 - D. KB Kondar
 - E. KB Mantap
2. Jika jumlah hari terpendek dari enam siklus menstruasi dikurangi 18, hasilnya menentukan hari pertama masa subur. Sedangkan jumlah hari terpanjang dari enam siklus dikurangi 11, hasilnya menunjukkan hari terakhir masa subur. Aturan ini berlaku bagi wanita dengan siklus haid yang
 - A. Banyak
 - B. Tidak teratur

- C. Teratur
 - D. Sedikit
3. Yang tidak termasuk keuntungan dari metode kontrasepsi MAL adalah....
 - A. Gratis atau tanpa biaya
 - B. Tidak membutuhkan obat maupun alat khusus
 - C. Tidak memerlukan pengawasan tenaga medis
 - D. Dapat menimbulkan ketidaknyamanan saat berhubungan intim akibat nyeri involusi
 4. Metode Amenore Laktasi (MAL) dapat digunakan sebagai kontrasepsi apabila memenuhi syarat berikut:
 - A. Menyusui secara penuh, belum haid, umur bayi < 6 bulan
 - B. Menyusui secara penuh, belum haid, umur bayi < 3 bulan
 - C. Menyusui secara penuh, belum haid, umur bayi < 4 bulan
 - D. Menyusui secara penuh, belum haid, umur bayi < 5 bulan
 5. Metode kontrasepsi yang bermanfaat sebagai perlindungan ganda adalah
 - A. Kondom
 - B. Suhu basal
 - C. MOB
 - D. Kalender

Essay

1. Sebutkan manfaat konsepsi pada metode KB Kalender/Pantang berkala?
2. Jelaskan manfaat/keuntungan penggunaan kondom?
3. Sebutkan jenis-jenis kontrasepsi sederhana tanpa alat?
4. Sebutkan manfaat MAL bagi kesehatan ibu dan bayi?
5. Jelaskan kontrasepsi yang tergolong dalam metode pembedahan?

Kunci Jawaban Pilihan Ganda

1. b
2. b
3. d
4. a
5. a

G. Rangkuman Materi

Kata kontrasepsi berasal dari gabungan kata kontra dan konsepsi. Kontra berarti mencegah atau menahan, sedangkan konsepsi merujuk pada pertemuan

antara sperma dan sel telur yang memicu terjadinya kehamilan. Dengan demikian, kontrasepsi dapat diartikan sebagai langkah atau upaya untuk menghindari kehamilan, baik secara sementara maupun permanen, melalui berbagai cara, alat, atau penggunaan obat-obatan.

Kontrasepsi sederhana dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanpa alat dan dengan alat/obat. Kontrasepsi sederhana tanpa alat mencakup metode senggama terputus, pantang berkala, pengukuran suhu basal tubuh, serta metode kalender. Sedangkan kontrasepsi sederhana dengan alat atau obat meliputi kondom, diafragma, kap serviks, dan spermisida.

Secara umum, penggunaan kontrasepsi bertujuan untuk melindungi ibu dan anak dari risiko kehamilan pada usia yang terlalu muda serta membantu pasangan merencanakan keluarga kecil yang sehat, harmonis, dan sejahtera.

H. Glosarium

Sperma: sel reproduksi pria yang dikeluarkan bersama air mani saat ejakulasi.

Sel telur (ovum): sel yang diproduksi, disimpan, dan dilepaskan oleh ovarium atau indung telur.

Fertilisasi: proses pertemuan antara sel gamet pria (sperma) dan sel gamet wanita (sel telur), yang memungkinkan terjadinya pembuahan.

Testis: organ utama sistem reproduksi pria yang berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron.

Vas deferens: saluran panjang yang membawa sperma dari epididimis menuju uretra untuk dikeluarkan saat ejakulasi.

Buah zakar: organ yang menghasilkan sperma serta hormon pada pria.

Tuba falopi: dua saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim, tempat sel telur bergerak menuju rahim.

Serviks: bagian ujung rahim yang menyempit dan mengarah ke vagina, berperan sebagai pintu antara rahim dan vagina.

ASI (Air Susu Ibu): cairan nutrisi yang diproduksi oleh kelenjar susu pada payudara wanita untuk memberi makan bayi.

Konsepsi: proses pembuahan di mana sel telur yang matang dibuahi oleh sperma, menandai awal kehamilan.

Ovulasi: pelepasan sel telur matang dari ovarium menuju tuba falopi untuk siap dibuahi.

I. Daftar Pustaka

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

BKKBN. (2020). *Pedoman pelayanan kontrasepsi dan keluarga berencana*. Jakarta:

Dewi, M.U.K. (2013), Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, Trans Info Media, Jakarta

Fatonah, S. H. S., Fitriani, F., Sari, H., Insani, S. D., Savita, R., Dwichristy, J Tertiana, W., Ginting, A. K., Fitriyani, B. D., Fitriani, L., & Hafid, R. N. H. (2023). *Asuhan kebidanan keluarga berencana* (Cetakan pertama). Jakarta: Nuansa Fajar Cemerlang

Irianto, K. (2014), Pelayanan Keluarga Berencana, Pustaka Rihanna, Yogyakarta
Jitowiyono Sugeng, Ns, M.Sc. dan Masniah Abdul Rouf. 2019. *Keluarga Berencana dalam Perspektif Bidan*. Yogyakarta: Pustaka Baru

Kemenkes 2021. Modul Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemenkes: Jakarta

Manuaba, I.B.S. (2019). *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB untuk Pendidikan Bidan*. 2 ed. Jakarta: EGC

Prijatni, I. & Rahayu, S. (2016), Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Sulistyawati, A. 2013, Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta: Salemba Medika

BAB 6

KONSELING KONTRASEPSI DENGAN METODE SEDERHANA ALAMI, MODERN DAN KONTRASEPSI DARURAT

Tujuan Intruksional:

1. Menguasai teori keluarga berencana
2. Menjelaskan komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan
3. Mampu menganalisis komunikasi efektif dalam memberikan konseling pelayanan kontrasepsi, Metode:
 - Alami
 - Moderern
 - Kontrasepsi darurat
4. Mampu menerapkan komunikasi efektif dalam memberikan konseling pelayanan kontrasepsi, Metode :
 - Alami
 - Moderern
 - Kontrasepsi darurat

Capaian Pembelajaran:

- CPL** Mahasiswa dapat menguasai teori keluarga berencana
- CPMK** Menganalisis strategi penerapan komunikasi efektif dalam pelayanan keluarga berencana serta mendemonstrasikan konseling serta pengambilan keputusan dalam keluarga berencana

Sub-CPMK:

1. Mampu memberikan komunikasi efektif dalam memberikan konseling pelayanan kontrasepsi
2. Mampu melakukan demonstrasi konseling pelayanan kontrasepsi
3. Mampu mendemonstrasikan pengambilan keputusan dalam keluarga berencana

Pendahuluan:

Keluarga berencana adalah upaya untuk membuat keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas dengan merencanakan kehamilan dan jumlah anak yang akan dilahirkan. Pemerintah melakukan program pencegahan kehamilan dengan mempromosikan penggunaan kontrasepsi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah ini, dan membantu keluarga menjadi lebih kecil, bahagia, dan sejahtera. Konseling keluarga membantu petugas dan klien bertukar informasi sehingga mereka dapat memahami kebutuhan untuk memilih metode kontrasepsi yang tepat dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang lengkap tentang metode kontrasepsi.

Uraian Materi

A. Definisi

Kata "konseling" berasal dari bahasa Latin *consilius*, yang memiliki makna "bersama" atau "berbicara." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konseling didefinisikan sebagai pemberian arahan atau bimbingan kepada seseorang oleh seorang ahli, melalui pendekatan psikologis maupun metode lainnya. Dengan demikian, konseling dapat dipahami sebagai proses saling bertukar pikiran, memberikan saran, dan menyampaikan nasihat (Maryati, 2025).

Selain itu, American Personnel and Guidance Association (APGA), dikutip dalam Tohirin (2008), menyatakan bahwa konseling merupakan hubungan profesional antara tenaga ahli dan individu yang membutuhkan bantuan dalam menghadapi kecemasan atau konflik yang muncul dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Dari penjelasan ini, konseling dapat dipahami sebagai interaksi profesional antara konselor dan klien, di mana konselor berperan membantu klien mengelola kecemasan sekaligus memperkuat kemampuan klien dalam mengambil keputusan secara mandiri.

Dalam layanan keluarga berencana, konseling berfungsi sebagai pendampingan bagi klien dalam menentukan keputusan terkait partisipasinya dalam program KB. Proses ini meliputi pemilihan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan, preferensi, dan kebutuhan individu, sekaligus memberikan pemahaman tentang cara penggunaan yang tepat agar metode tersebut dapat diterapkan secara efektif dan aman (Wahyuni, 2022).

B. Tujuan Konseling KB

Tujuan umum konseling KB adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kontrasepsi (Uripni, Sujianto, & Indrawati, 2003).

1. Menyampaikan informasi secara komprehensif, akurat, dan tidak memihak mengenai beragam metode kontrasepsi, sehingga klien memahami manfaatnya baik bagi kesehatan pribadi maupun kesejahteraan keluarga.
2. Mengidentifikasi serta menampung berbagai emosi negatif, seperti keraguan atau rasa takut yang mungkin muncul terkait pelayanan KB atau pilihan kontrasepsi, sehingga konselor dapat memberikan pendampingan untuk mengatasinya.
3. Memberikan bimbingan kepada klien dalam menentukan metode kontrasepsi yang aman dan selaras dengan preferensi pribadi.

4. Membantu klien memahami prosedur penggunaan kontrasepsi secara benar dan efektif, sekaligus memberikan informasi mengenai akses layanan dan fasilitas KB yang tersedia.
5. Menyaring calon akseptor dengan potensi risiko tinggi, terutama untuk metode kontrasepsi permanen, serta membantu mereka memilih alternatif yang lebih sesuai dan aman.

Menurut (Aisyah & Yuliawati, 2020) Tujuan dalam pemberian konseling keluarga berencana antara lain:

- 1 Meningkatkan kesadaran dan kesiapan klien untuk memanfaatkan program KB.
- 2 Menjamin klien memilih metode KB yang tepat, sesuai kondisi kesehatan dan kebutuhan pribadinya.
- 3 Memastikan metode KB yang dipakai memberikan hasil yang optimal.
- 4 Mendukung kelangsungan penggunaan KB agar lebih konsisten dan tahan lama.

C. Macam-Macam Bentuk Komunikasi

Jenis komunikasi menurut (Angsar, 2022) dibagi dalam dua bentuk yakni verbal dan non-verbal.

1 Komunikasi verbal:

Suatu cara komunikasi yang menyampaikan pesan baik secara lisan maupun tertulis, dengan kata-kata sebagai sarana utama untuk menyampaikan informasi.

2 Komunikasi non-verbal:

Suatu cara menyampaikan pesan tanpa mengandalkan kata-kata, melainkan melalui isyarat tubuh, termasuk ekspresi wajah, gerakan mata, posisi lidah, gerakan seluruh tubuh, serta penampilan fisik secara keseluruhan.

D. Bentuk-Bentuk Komunikasi

1. Komunikasi intrapersonal

Komunikasi intrapersonal adalah bentuk komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang sendiri. Proses ini mencakup penerimaan informasi, pengolahan, penyimpanan, hingga kemampuan untuk merefleksikan atau merespons pesan tersebut secara internal.

2. Komunikasi interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah pertukaran pesan antara individu. Dalam komunikasi ini, masing-masing pihak berinteraksi untuk saling memahami makna, sehingga terjadi proses berbagi informasi dan pemahaman secara dua arah.

3. Komunikasi kelompok

Komunikasi kelompok adalah interaksi yang melibatkan tiga orang atau lebih dengan tujuan tertentu, seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, atau pertukaran informasi. Bentuk komunikasi ini biasanya terjadi dalam rapat, seminar, workshop, atau kegiatan serupa.

4. Komunikasi internal

Dalam konteks organisasi, komunikasi terjadi antarindividu di dalam suatu sistem terstruktur. Karena cakupannya luas dan kompleks, komunikasi organisasi sering dipelajari sebagai disiplin tersendiri, mengingat perannya yang penting dalam kelancaran operasional dan koordinasi.

5. Komunikasi publik

Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada audiens dalam jumlah besar melalui berbagai media, dengan tujuan menjangkau khalayak yang luas, heterogen, dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman atau sikap publik.

E. Tahapan Konseling KB

Menurut (Bakoil, 2021), ada komponen penting dalam pelayanan konseling KB dengan dibagi 3 tahapan yaitu:

1 Konseling Awal

Tujuan dari konseling awal ini adalah untuk menentukan langkah apa yang akan diambil. Ini akan membantu klien dalam memilih jenis KB yang paling sesuai jika dilakukan dengan benar. Beberapa hal yang harus diperhatikan di bagian ini:

- a. Menanyakan langkah yang disukai klien
- b. Apa yang diketahui tentang cara kerjanya, kelebihan dan kekurangannya.

2 Konseling Khusus

- a. Konseling jenis ini memberikan kesempatan untuk bertanya
- b. tentang cara KB dan membicarakan pengalamannya.
- c. Mendapatkan informasi lebih rinci tentang KB yang diinginkannya
- d. Mendapatkan bantuan memilih metode KB yang cocok dan mendapatkan penerangan lebih jauh tentang penggunaannya.

3 Konseling Tindak Lanjut

Konseling ini berbeda dari konseling awal. Pemberi layanan perlu mampu membedakan antara masalah ringan yang bisa ditangani di tempat dengan masalah yang lebih serius yang membutuhkan rujukan ke fasilitas lain.

F. Langkah-langkah Konseling

1 Teknik Konseling GATHER

Menurut Gallen dan Leitenmaier dalam Septikasari (2020), teknik konseling **GATHER** terdiri dari enam tahap, yaitu:

- a. G – GREET (Menyapa): Memberikan salam, memperkenalkan diri, dan membuka komunikasi dengan klien untuk menciptakan suasana yang ramah dan nyaman.
- b. A – ASK (Menanyakan): Mengajukan pertanyaan terkait keluhan atau kebutuhan klien, sekaligus menilai kesesuaian keluhan dengan kondisi yang sebenarnya dialami.
- c. T – TELL (Memberitahukan): Menyampaikan inti persoalan yang dihadapi klien berdasarkan informasi yang diperoleh, serta bersama-sama mencari solusi yang tepat.
- d. H – HELP (Membantu): Membimbing klien dalam memahami masalah yang dihadapi dan memberikan arahan untuk penyelesaiannya.
- e. E – EXPLAIN (Menjelaskan): Menjelaskan metode atau langkah yang dianjurkan, termasuk hasil yang diharapkan, sehingga klien dapat memantau kemajuan atau perubahan secara nyata.
- f. R – REFER / RETURN VISIT (Merujuk / Kunjungan Ulang): Mengarahkan klien ke fasilitas lain bila layanan tidak tersedia, serta menetapkan jadwal kunjungan ulang jika diperlukan.

Teknik GATHER menekankan komunikasi yang sistematis dan empatik, yang membuat konseling lebih efektif dalam membantu klien memahami masalah mereka dan menemukan solusi.

Di sisi lain, penerapan enam langkah **SATU TUJU** dapat berfungsi sebagai panduan dalam konseling bagi calon pengguna Keluarga Berencana (KB) yang baru. Mengingat petugas konseling perlu menyesuaikan strategi dengan kebutuhan, kondisi, dan tingkat kesiapan tiap klien, langkah-langkah tersebut tidak harus dijalankan secara berurutan.

2 Tahap-Tahap Konseling SATU TUJU

SATU TUJU langkah dapat diterapkan dalam konseling untuk calon pengguna Keluarga Berencana (KB) baru; urutan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan klien.

a. SA – Sapa dan Salam

Sambut klien secara terbuka dan sopan. Berikan perhatian penuh, berbicaralah di tempat yang nyaman dan menjamin privasi. Yakinkan klien untuk membangun rasa percaya diri. Tanyakan kebutuhan klien dan jelaskan jenis pelayanan yang tersedia.

b. T – Tanyakan

Ajukan pertanyaan terkait informasi pribadi dan pengalaman klien mengenai KB serta kesehatan reproduksi. Tanyakan pilihan kontrasepsi yang diinginkan. Perhatikan kata-kata, gerak tubuh, dan ekspresi klien. Tempatkan diri pada posisi klien untuk memahami pengetahuan, kebutuhan, dan keinginannya sehingga dapat memberikan bantuan yang tepat.

c. U – Uraikan

Jelaskan pilihan reproduksi yang tersedia, termasuk berbagai jenis kontrasepsi. Bantulah klien memahami jenis kontrasepsi yang paling sesuai dengan keinginannya, sekaligus informasikan opsi lain yang mungkin relevan.

d. TU – Tentukan Pilihan

Bimbing klien dalam menentukan pilihan yang paling sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan preferensinya.

e. J – Jelaskan Penggunaan

Berikan penjelasan lengkap tentang cara menggunakan kontrasepsi yang dipilih. Jika diperlukan, tunjukkan alat kontrasepsi agar klien memahami cara penggunaannya.

f. U – Ulangi / Kunjungan Ulang

Diskusikan pentingnya kunjungan lanjutan. Buat kesepakatan dengan klien untuk pemeriksaan ulang atau pengambilan kontrasepsi tambahan jika diperlukan.

G. Faktor pendukung keberhasilan konseling

Faktor-faktor berikut mendukung keberhasilan konseling (Purwati, Japar, Pratama, & Nilmah, 2025):

1 Struktur

Struktur dalam konseling merujuk pada karakteristik, kondisi, dan prosedur yang telah disepakati bersama oleh konselor dan klien. Struktur ini berfungsi untuk memperjelas hubungan antara keduanya, melindungi hak masing-masing pihak, serta memberikan arahan yang mendukung keberhasilan proses konseling.

2 Inisiatif

Dalam konteks konseling, inisiatif merupakan sikap atau usaha yang dapat memotivasi klien untuk mempercepat mendapatkan jalan keluar dari suatu permasalahan.

3 Setting Fisik

Dalam proses konseling, terciptanya suasana yang kondusif sangat penting. Konselor perlu memiliki kemampuan mengatur ruang agar klien merasa nyaman, aman, tenang, dan rileks. Keterampilan ini mencakup pengaturan dekorasi

ruangan, penempatan dan jarak tempat duduk klien, posisi duduk konseli, serta tata letak area konseling secara keseluruhan.

4 Kualitas Konseling

Kualitas konseling mencakup materi yang diberikan, tahapan dan langkah-langkah yang dilakukan.

5 Kualitas Konselor

Kualitas seorang konselor tercermin dari kemampuan mengatur situasi, berkomunikasi secara efektif, serta menyesuaikan pendekatan sesuai karakter dan kebutuhan setiap klien.

H. Faktor penghambat keberhasilan konseling

Menurut (Aisyah & Yuliawati, 2020) mengemukakan masalah umum yang dapat menghambat konseling, diantaranya :

1. Kebosanan

Proses konseling yang bosan atau waktu tunggu yang terlalu lama dapat membuat klien bosan, menyebabkan mereka tidak terlibat dan fokus dalam sesi konseling.

2. Hostilitas

Dalam kasus di mana konselor atau klien memiliki kecenderungan untuk memaksakan kehendaknya terhadap orang lain, istilah "hostilitas" mengacu pada situasi di mana konselor dapat secara tidak sadar bertindak terlalu "baik" untuk membantu klien memecahkan masalah, yang pada gilirannya menyebabkan ketegangan atau resistensi dari klien.

3. Distansi Emosional

Konselor yang dibayangi emosi pribadi akan kesulitan memahami dunia klien, karena mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan pikiran, perasaan, maupun persepsi klien. Akibatnya, kemampuan empati yang seharusnya muncul menjadi terbatas.

4. Kelekatan Emosional

Untuk tetap objektif dan efektif selama proses konseling, konselor harus mengelola emosi dan perasaan kliennya dengan baik.

5. Penderitaan (Suffering / Psychological Bleeding)

Penderitaan psikologis bisa timbul akibat adanya ketegangan atau permusuhan dalam proses konseling. Apabila konselor bersikap memaksa atau tidak menyesuaikan pendekatan dengan keinginan klien, klien yang memiliki pandangan berbeda atau tidak sejalan dapat mengalami stres maupun tekanan psikologis.

I. Metode Konseling

Berdasarkan Bakoil (2021), terdapat berbagai metode konseling KB yang telah diterapkan dalam pelayanan. Salah satunya adalah penggunaan Metode dan Alat Bantu Konseling Keluarga Berencana (KB). Beragam metode dan alat bantu ini dapat dimanfaatkan oleh bidan atau tenaga kesehatan guna memperkuat proses konseling KB.

1. Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK)

ABPK merupakan metode yang menggunakan lembar balik berisi informasi komprehensif tentang berbagai jenis alat kontrasepsi. Walaupun menyediakan data yang lengkap, metode ini kadang memberikan informasi secara berlebihan, sehingga kemampuannya untuk membantu klien menentukan kontrasepsi yang paling sesuai menjadi terbatas.

2. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Buku ini menyatukan berbagai kartu kesehatan, termasuk KMS untuk ibu hamil, KMS Balita, Kartu Keluarga Berencana (KB), serta catatan perkembangan anak. Buku KIA disimpan di rumah dan dibawa setiap kali ibu atau anak mengunjungi fasilitas kesehatan. Pada bagian khusus yang menyoroti "Ibu", terdapat informasi terkait Keluarga Berencana, mencakup tujuan, jenis metode kontrasepsi, serta ringkasan profil masing-masing pilihan secara singkat.

- a. Informasi mengenai kesehatan ibu, mencakup masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas.
- b. Informasi terkait kesehatan anak, mulai dari bayi baru lahir hingga anak berusia 6 tahun.

Buku ini menggabungkan beragam kartu kesehatan, seperti KMS untuk ibu hamil, KMS Balita, Kartu Keluarga Berencana (KB), serta catatan perkembangan anak. Buku KIA disimpan di rumah dan dibawa setiap kali ibu atau anak mengakses layanan kesehatan. Pada bagian khusus "Ibu", tersedia informasi mengenai Keluarga Berencana yang memuat tujuan, jenis kontrasepsi, serta ringkasan profil masing-masing metode.

3. Klik KB

Aplikasi digital ini dikembangkan oleh BKKBN untuk menghubungkan akseptor KB secara langsung dengan bidan, memungkinkan terjadinya konseling dan pertukaran informasi secara interaktif. Keterbatasan metode ini terletak pada kebutuhan klien untuk memiliki perangkat Android dan akses internet yang stabil.

4. Strategi Konseling Berimbang (SKB) KB

Pada tahun 1990, Population Council bekerja sama dengan kementerian kesehatan beberapa negara di Amerika Latin mengembangkan Strategi Konseling Berimbang (SKB) atau Balanced Counseling Strategy (BCS). Pendekatan ini

dirancang untuk memperkuat interaksi antara klien dan penyedia layanan, sehingga proses konseling KB menjadi lebih praktis, interaktif, dan menyenangkan. Dengan menekankan keseimbangan hak antara konselor dan klien, metode ini menempatkan keputusan sepenuhnya pada klien. Klien memilih metode kontrasepsi yang sesuai berdasarkan hasil konseling, dibantu oleh media pendukung seperti kartu informasi dan brosur metode.

J. Konseling KB

Sebelumnya, alat bantu konseling KB belum sepenuhnya berorientasi pada klien. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat bantu saat itu membuat konselor terlalu dominan, sehingga keinginan dan preferensi klien kurang mendapatkan ruang untuk diungkapkan. Klien pun sering mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan karena dibanjiri informasi yang berlebihan. Sebagai respons terhadap permasalahan ini, dikembangkan Strategi Konseling Berimbang (SKB) KB, yang dirancang untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan sekaligus menyesuaikan respons dengan tujuan reproduksi dan kebutuhan kesehatan klien.

Menurut Novembriani, Hasanah, Puriastuti, dan Suprobo (2025), konseling dengan SKB KB memiliki proses yang lebih terstruktur, menekankan keuntungan dan risiko dari metode yang dipilih, memperhatikan jarak antar kehamilan yang sehat, serta efek samping yang mungkin timbul. Metode ini menempatkan keputusan sepenuhnya pada klien, sehingga hak dan peran konselor serta klien sejajar, dan keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keinginan klien tanpa intervensi dari konselor. Selain itu, durasi konseling menjadi lebih singkat karena informasi yang disampaikan tepat sasaran dan tidak berlebihan. Dengan sifat interaktif dari alat bantu SKB KB, klien menjadi lebih proaktif dalam menyampaikan pikiran, kebutuhan, dan perasaannya.

Pada tahun 2016, JHCCP, Kemenkes, dan BKKBN meluncurkan program PilihanKu, yang menawarkan alternatif metode konseling bagi para konselor KB (tenaga kesehatan, penyuluh, dan petugas lapangan KB). Pada awalnya, program ini diujicobakan di 44 Puskesmas di wilayah program PilihanKu untuk membantu klien memilih metode kontrasepsi pasca persalinan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penggunaan KB PP sebelum dipulangkan naik rata-rata.

Menurut (Novembriani, Hasanah, Puriastuti, & Suprobo, 2025) SKB KB mempunyai tiga alat bantu dalam melakukan konseling. Beberapa alat bantu dapat digunakan oleh konselor untuk mendukung proses konseling KB, antara lain:

1. Diagram Bantu Konseling

Diagram ini mencakup pertanyaan utama, langkah-langkah, dan petunjuk pelaksanaan, dan digunakan untuk membantu konselor selama proses konseling. Selain itu, diagram ini juga menunjukkan cara yang tepat untuk menyimpan dan membuang kartu konseling.

2. Kartu Konseling

Alat ini berfungsi menyampaikan informasi secara singkat dan padat kepada klien mengenai tiap jenis metode kontrasepsi. Kartu tersebut memuat gambaran umum tentang efektivitas, efek samping, serta informasi penting lain yang membantu klien memahami setiap metode dengan lebih jelas.

3. Brosur Metode KB

Berisi informasi lebih rinci tentang setiap metode kontrasepsi, termasuk kriteria medis untuk penggunaan (eligibility), mekanisme kerja kontrasepsi, efek samping yang umum, serta cara penggunaan. Brosur ini membantu klien membuat keputusan yang tepat dan memahami konsekuensi penggunaan metode yang dipilih.

Proses konseling menggunakan SKB KB (Novembriani, Hasanah, Puriastuti, & Suprobo, 2025) terdiri dari 3 tahap sebagai berikut:

a. Tahap Penapisan Konseling Keluarga Berencana (KB)

Proses konseling KB melibatkan **tujuh langkah penapisan** untuk memastikan pilihan kontrasepsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien:

1) Menyapa Klien.

Konselor menyapa klien dengan sopan dan menjelaskan bahwa masalah kesehatan reproduksi lain akan ditangani sesuai kondisi individu. Selanjutnya, konselor menanyakan penggunaan kontrasepsi.

2) Pemeriksaan Kehamilan

Jika klien sedang hamil, konselor melakukan pemeriksaan ANC (Antenatal Care) dan menanyakan kesediaan klien untuk melanjutkan konseling KB setelah kehamilan

3) Rencana Kehamilan

Konselor menanyakan apakah klien berencana memiliki anak lagi di masa depan, untuk menyesuaikan rekomendasi metode kontrasepsi.

4) Informasi Jarak Kehamilan

Konselor menjelaskan waktu dan jarak kehamilan yang ideal, agar keputusan kontrasepsi aman bagi ibu dan anak.

5) Penggunaan Diagram Kelayakan Medis

Konselor menggunakan Diagram Lingkaran Kriteria Kelayakan Medis untuk menilai metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan klien.

6) Seleksi Metode

Saat klien merespons pertanyaan, konselor menyingkirkan kartu metode yang tidak relevan, sehingga informasi hanya difokuskan pada opsi yang sesuai dan klien siap melanjutkan pemilihan metode.

7) Indikasi Warna pada Diagram

Pada tahap ini, warna kotak di diagram bantu adalah kuning, menandakan metode yang sedang dipertimbangkan dalam penapisan.

b. Tahap Pemilihan Konseling Keluarga Berencana (KB)

Pada tahap ini, konselor memberikan penjelasan lebih mendetail mengenai metode kontrasepsi yang masih relevan setelah proses penapisan, termasuk tingkat efektivitasnya, serta membimbing klien dalam menentukan teknik reproduksi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Konselor secara bertahap menyaring kartu konseling hingga klien mampu membuat keputusan akhir dengan mengikuti panduan diagram bantu konseling SKB KB.

Apabila terdapat kondisi tertentu yang membuat suatu metode tidak disarankan (sesuai informasi pada brosur), konselor membantu klien mengevaluasi opsi alternatif. Kartu-kartu dikategorikan berdasarkan tingkat efektivitas, dan konselor menjelaskan informasi pada semua kartu yang tersisa, seperti Implan, AKDR, MAL, dan pil progestin, terutama untuk klien yang masih berniat memiliki anak di masa depan.

Penawaran metode sterilisasi (MOW/MOP) hanya dilakukan jika klien dan pasangan percaya bahwa jumlah anggota keluarga sudah mencukupi. Konselor akan membahas opsi lain, seperti suntikan progestin enam minggu setelah melahirkan, jika klien tidak ingin berkonsultasi dengan prosedur pasca persalinan sebelum meninggalkan fasilitas. Selanjutnya, klien diminta memilih salah satu metode kontrasepsi dari kartu yang tersedia, dan konselor memeriksa apakah pilihan tersebut sesuai dengan informasi yang tercantum di brosur.

c. Tahap Setelah Pemilihan

Pada tahap ini, konselor memanfaatkan brosur untuk menyampaikan informasi yang komprehensif mengenai metode kontrasepsi yang dipilih klien. Konselor memastikan bahwa klien telah mantap dengan pilihannya. Apabila klien bersedia menerima layanan KB, konselor dapat langsung memberikan pelayanan sekaligus mendokumentasikan hasil konseling dan layanan tersebut.

K. Latihan

1. Seorang perempuan usia 25 tahun nifas 6 minggu datang ke PMB ingin memeriksakan kesehatannya. Hasil anamnesis: anak ketiga, tidak ada keluhan yang dirasakan. Hasil pemeriksaan: TD 110/60 mmHg, N 78 x/menit, S 36 °C, P 24 x/menit, TFU tidak teraba, kandung kemih kosong, lochea alba. Apakah asuhan yang tepat sesuai kasus tersebut?
 - A. Perawatan bayi baru lahir
 - B. Makanan yang bergizi
 - C. Istirahat yang cukup
 - D. Memastikan involusi
 - E. Konseling KB dini
2. Seorang perempuan umur 37 tahun, P4A0, datang ke PMB untuk konsultasi. Hasil anamnesis: mengaku 12 jam yang lalu melakukan hubungan dengan suami menggunakan kondom, namun bocor, takut jika terjadi kehamilan. Hasil pemeriksaan: KU baik, TD 110/80 mmHg, N 80 x/menit, S 36 C, P 20 x/menit, konjungtiva merah muda, payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak tampak pembesaran uterus. Apakah perencanaan yang paling tepat pada kasus tersebut?
 - A. Lakukan rujukan
 - B. Sarankan ibu untuk USG
 - C. Pemberian alat kontrasepsi
 - D. Konseling kontrasepsi darurat
 - E. Konseling kemungkinan tidak hamil
3. Seorang perempuan, umur 33 tahun, P3A0, nifas hari ke-30, datang ke PMB untuk ber-KB. Hasil anamnesis: tidak mempunyai riwayat penyakit, bingung memilih alat kontrasepsi yang tepat. Hasil pemeriksaan: TD 120/80 mmHg, N 80 x/menit, S 36 C, P 24 x/menit. Apakah hak klien yang harus diberikan sesuai kasus tersebut?
 - A. Efek samping KB
 - B. Pendampingan oleh pasangan
 - C. Pelayanan pemeriksaan penunjang
 - D. Pemberian informasi mengenai jenis KB
 - E. Pengambilan keputusan pemilihan kontrasepsi
4. Seorang perempuan, umur 17 tahun, datang ke PMB untuk ber-KB. Hasil anamnesis: baru menikah 1 hari yang lalu dan belum melakukan hubungan

seksual. Hasil pemeriksaan: KU baik, TD 90/70 mmHg, N 80 x/menit, S 36 C, P 20 x/menit, konjungtiva merah muda, payudara tidak ada pembesaran, abdomen tidak ada pembesaran uterus. Apakah konseling KB yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. MKJP
- B. Hormonal
- C. Reversible
- D. Sederhana
- E. Irreversible

5. Seorang perempuan, umur 27 tahun, datang ke PMB untuk ber-KB. Hasil anamnesis: Melahirkan anak pertama 2 bulan yang lalu, selesai masa nifas, belum pernah menggunakan kontrasepsi. Bayi minum ASI eksklusif. Hasil pemeriksaan: KU baik, TD 90/70 mmHg, N 80 x/menit, S 36 C, P 20 x/menit, konjungtiva merah muda, payudara terdapat pembesaran. Apakah konseling KB yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Konseling awal
- B. Konseling khusus
- C. Konseling tindak lanjut
- D. Konseling penatalaksanaan
- E. Konseling KB

Kunci Jawaban

- 1. E
- 2. D
- 3. D
- 4. C
- 5. A

L. Rangkuman Materi

Keluarga berencana merupakan upaya untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak serta perencanaan kehamilan untuk membentuk keluarga yang sehat, sejahtera dan berkualitas. Melalui konseling keluarga berencana proses pertukaran informasi antara klien dan petugas untuk mengenali kebutuhan dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai dan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang lengkap tentang metode kontrasepsi. Konseling membantu klien untuk mengerti bagaimana cara penggunaannya, dan dapat menggunakannya dengan benar untuk perlindungan kontrasepsi yang aman dan

efektif. Pemberian konseling, khususnya bagi calon KB yang baru, hendaknya dapat diterapkan enam langkah yang sudah dikenal dengan kata kunci SATU TUJU.

Alat bantu pengambilan keputusan KB di kembangkan SKB KB. Dimana proses konseling lebih terstruktur, berfokus pada informasi tentang jarak dan waktu kehamilan yang sehat, keuntungan dan kerugian metode yang dipilih, serta efek samping dan cara mengatasinya. Metode ini berorientasi pada keputusan klien dimana hak konselor dan klien setara serta keputusan benar-benar berdasarkan keinginan klien tanpa dipengaruhi keinginan konselor.

M. Glosarium

SKB	:	Strategi Konseling Berimbang
APGA	:	<i>American Personel and Guidance Association.</i>
KB	:	<i>Keluarga Berencana</i>
Konseling	:	Pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis dan sebagainya;
Akseptor	:	Orang yang menerima serta mengikuti (pelaksanaan) program keluarga berencana
Verbal	:	Secara lisan (bukan tertulis)
Non-Verbal	:	Tidak dalam bentuk percakapan; tidak dalam bentuk bahasa
Psikologis	:	Berkenaan dengan psikologi; bersifat kejiwaan:
Konselor	:	Anggota (staf) perwakilan di luar negeri, kedudukannya di bawah duta besar dan bertindak sebagai pembantu utama (pemangku) kepala perwakilan.

N. Daftar Pustaka

-
- Aisyah, W. N., & Yuliawati, D. (2020). *Komunikasi dan Konseling*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Angsar, I. (2022). *Modul Keluarga Berencana*. Jakarta: Jhpiego.
- Bakoil, M. B. (2021). *Pelayanan Keluarga Berencana*. Malang: Wijaya Kusuma Press.
- Maryati, L. (2025). *Buku Asuhan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Bandung: Widina Media Utama.
- Novembriani, R. P., Hasanah, W. K., Puriastuti, A. C., & Suprobo, N. R. (2025). *Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan: KB dan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Pembangunan Masyarakat*. Malang: Kramantara Jaya Sentosa.
- Purwati, Japar, M., Pratama, R. A., & Nilmah, F. K. (2025). *Teknik Konseling*. Yogyakarta: K-Media.
- Septikasari, M. (2020). *Konseling Keluarga Berencana*. Cilacab: Majestika Septikasari.
- Uripni, C. L., Sujianto, U., & Indrawati, T. (2003). *Komunikasi Kebidanan*. Jakarta : EGC.
- Wahyuni, S. (2022). *Pelayanan Keluarga Berencana*. Malang: Unisma Press.

BAB 7

MEMBERIKAN PELAYANAN KONTRASEPSI DENGAN METODE SEDERHANA, ALAMI, MODERN DAN KONTRASEPSI DARURAT. PELAYANAN KONTRASEPSI PASCA ABORSI (KONDOM, PIL, SUNTIK)

Tujuan Intruksional:

1. Menjelaskan Konsep kontrasepsi Metode Sederhana
2. Menjelaskan Konsep Kontrasepsi Alami
 - Symtothermal
 - Kalender
 - MOB
 - MAL
 - Coitus interruptus
 - Mampu melakukan penapisan pada akseptor baru KB alamiah
3. Menjelaskan Konsep Kontrasepsi Modern
4. Menjelaskan Kontrasepsi Darurat
5. Menjelaskan Pelayanan Kontrasepsi Pasca Aborsi (Kondom,Pil,Suntik)
6. Memaparkan pelayanan kontrasepsi pada akseptor KB alamiah
7. Menjelaskan konseling kelenihan dan kekurangan pada pasien bermasalah dalam pada akseptor KB alamiah
8. Menjelaskan komplikasi yang mungkin terjadi pada akseptor KB Modern dan Kontrasepsi Darurat dan Kontrasepsi pasca Aborsi
9. Menjelaskan melakukan pendokumentasian, pencatatan dan pelaporan dalam pelayanan kontrasepsi alamiah

Capaian Pembelajaran:

CPL-Prodi yang dibebankan pada MK	
CPL	Mampu menerapkan Asuhan Kebidanan Pelayanan Kontrasepsi Dengan Metode Sederhana, Alami, Modern Dan Kontrasepsi Darurat. Pelayanan Kontrasepsi Pasca Aborsi (Kondom,Pil,Suntik)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK	Bila diberikan pengalaman belajar di kelas, Mahasiswa mampu mengintegrasikan (C4) pengetahuan, sikap dan keterampilan praktik dan aktifitas menerapkan Pelayanan Kontrasepsi Dengan Metode Sederhana, Alami, Modern Dan Kontrasepsi Darurat. Pelayanan Kontrasepsi Pasca Aborsi (Kondom,Pil,Suntik)
Sub CPMK	
Sub CPMK 1	Mendiskusikan Konsep teoritis secara sistematis tentang pelayanan Kontrasepsi Dengan Metode Sederhana, Alami, Modern Dan Kontrasepsi Darurat. Pelayanan Kontrasepsi Pasca Aborsi (Kondom,Pil,Suntik)
Sub CPMK 2	Mempraktikkan secara sistematis tentang pelayanan Kontrasepsi Dengan Metode Sederhana, Alami, Modern Dan Kontrasepsi Darurat. Pelayanan Kontrasepsi Pasca Aborsi (Kondom,Pil,Suntik)
Sub CPMK 3	Mempraktikkan konseling pada pasien yang bermasalah dan mampu melakukan pendokumentasian kontrasepsi
Sub CPMK 4	Menggunakan secara sistematis tentang pelayanan Kontrasepsi Dengan Metode Sederhana, Alami, Modern Dan Kontrasepsi Darurat. Pelayanan Kontrasepsi Pasca Aborsi (Kondom,Pil,Suntik)

Pendahuluan:

Kontrasepsi berasal dari kata kontra berarti mencegah dan konsepsi yang berarti pertemuan sel telur dengan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Kontrasepsi adalah menghindari terjadinya kehamilan akibat pertemuan sel telur matang dengan sel sperma. Maksud dari kontrasepsi adalah untuk menghindari atau untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat dari pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Sejak pada jaman dahulu, di Indonesia pasangan usia subur sudah menggunakan obat dan jamu yang maksudnya adalah untuk mencegah kehamilan.

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program dalam bidang kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk membantu pasangan suami istri merencanakan waktu kelahiran anak, jumlah dan jarak. Melalui program KB, keluarga dapat mengatur kehamilan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi, kesiapan fisik, mental sehingga kualitas hidup keluarga dapat meningkat. KB juga berperan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta mengurangi risiko kehamilan yang terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering, atau terlalu dekat jaraknya. Dengan perencanaan yang baik, pasangan dapat menciptakan keluarga yang lebih sehat, sejahtera, dan harmonis.

Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman dasar mengenai pelayanan kontrasepsi dengan metode sederhana, alami, modern dan kontrasepsi darurat serta pelayanan kontrasepsi pasca aborsi (kondom, pil, suntik).

Harapannya, pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang metode KB sederhana dan pasca aborsi serta mampu memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. buku ini dirancang untuk membantu pembaca belajar, melalui teks tulisan, gambar, latihan soal.

Materi dalam buku ini dirancang agar mudah dipahami oleh mahasiswa atau peserta didik yang baru mengenal konsep-konsep KB sederhana dan darurat dengan disertai contoh kasus, latihan soal, dan ringkasan pada setiap akhir bab.

A. Konsep kontrasepsi Metode Sederhana

Kontrasepsi metode sederhana adalah metode pencegahan kehamilan yang mudah digunakan untuk semua Pasangan Usia Subur (PUS), relatif murah serta tidak memerlukan prosedur medis atau peralatan khusus. Kontrasepsi ini biasanya bisa dilakukan sendiri di rumah dan cocok untuk pasangan yang mencari cara yang praktis dan non-invasif / metode yang tidak memerlukan sayatan pada tubuh dan tidak memerlukan penetrasi.

Berikut adalah beberapa contoh metode kontrasepsi sederhana:

1. Kondom

a. Pengertian

Kondom merupakan sarung karet atau selubung yang terbuat dari berbagai bahan diantaranya karet (lateks), plastik, atau bahan alami (produksi hewan) yang dipasang pada alat kelamin laki - laki saat berhubungan seksual. Kondom selain dapat mencegah kehamilan tetapi juga melindungi diri dari penularan penyakit melalui hubungan seks, seperti HIV AIDS.

Benda yang sudah digunakan di Mesir sejak tahun 1350 SM ini berfungsi untuk menampung sperma sehingga tidak dapat masuk ke dalam vagina atau rahim wanita. Mulai abad ke-18, kondom juga memiliki fungsi lain sebagai pencegah penularan Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV (*human immunodeficiency virus*). Kondom yang paling efektif dan aman biasanya terbuat dari latex atau *poliuretan*. Kondom termasuk alat kontrasepsi sekali pakai setiap kali pasangan melakukan hubungan seksual harus menggunakan kondom baru (Jitowiyono & Rouf, 2019).

Alat kontrasepsi kondom di Indonesia bebas di perjual belikan, tidak adanya batasan dalam melakukan proses transaksi jual beli alat kontrasepsi kondom. Regulasi yang mengatur tentang peredaran jual beli alat kontrasepsi sudah dilegalkan sebagaimana yang di atur dalam undang-undang, akan tetapi sering kali terjadi penyalahgunaan alat kontrasepsi jenis kondom. Hal ini menjadi peluang bagi remaja dan anak dibawah umur melalui seks bebas atau seks pranikah, sehingga dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi Masyarakat Indonesia.

b. Cara kerja:

Kondom menghalangi pertemuan sperma dan sel telur dengan cara menampung sperma di ujung selubung karet yang di pasang di penis, sehingga sperma tersebut tidak masuk ke rahim.

c. Kelebihan:

- Melindungi dari kehamilan dan penyakit menular seksual (PMS).
- Mudah didapat dan tanpa resep
- Efektif bila di gunakan dengan benar
- Murah dan dapat di beli secara umum
- Tidak mengganggu Kesehatan klien
- Tidak mengganggu produksi ASI
- Tidak mempunyai pengaruh sistemik

d. Kekurangan:

- Bisa robek jika tidak digunakan dengan benar
- Harus digunakan setiap kali berhubungan.
- Efektifitas tidak terlalu tinggi
- Agak mengganggu hubungan seksual (mengurangi sentuhan langsung)
- Beberapa klien malu saat membeli di tempat umum

2. Pantang Berkala (Metode Kalender)

a. Pengertian

Metode pantang berkala atau dikenal dengan system KB (Keluarga berencana) kalender adalah metode kontrasepsi sederhana yang dapat di kerjakan sendiri oleh pasangan suami istri, dengan tidak melakukan senggama pada masa subur (Meilani N, 2018). Berdasarkan Sebuah penelitian di Amerika Serikat yang dilakukan oleh CDC (*Centers for Disease Control and Prevention*) menyatakan bahwa angka kegagalan KB kalender cukup besar yaitu 24 persen. Itu berarti dari setiap 100 perempuan yang menggunakan metode ini secara tepat, ada sekitar 24 orang yang mengalami kegagalan dan berujung hamil. (Prasetyo ,2021).

b. Cara kerja:

Wanita yang menghindari hubungan seksual pada masa subur. Cara menghitungnya wanita dengan daur haid tidak teratur, variasi yang tidak jauh berbeda, dapat di terapkan masa subur dengan suatu perhitungan, dimana daur haid terpendek di kurangi dengan 18 hari dan daur haid terpanjang di kurangi 11 hari. Masa aman ialah sebelum daur haid pendek yang telah dikurangi untuk dapat mengurangi. Cara ini selama satu tahun penuh, wanita tersebut harus mempunyai catatan tentang lama daur haidnya selama 6 bulan atau lebih lama daur haid nya.

c. Kelebihan:

- Tidak memerlukan alat atau obat.
- Cocok untuk pasangan dengan siklus haid teratur.

d. Kekurangan:

- Risiko kehamilan lebih tinggi jika salah menghitung masa subur.
- Tidak melindungi dari PMS.

3. Senggama Terputus (Coitus Interruptus)

a. Pengertian metode KB tradisional di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum pria ejakulasi.

b. Cara kerja: Pria menarik penis keluar dari vagina sebelum ejakulasi.

c. Kelebihan:

- Tidak memerlukan alat atau biaya.
- Efektif bila digunakan dengan benar
- Tidak ada efek samping
- Dapat digunakan setiap waktu
- Dapat di gunakan sebagai pendukung metode KB lainnya

d. Kekurangan:

- Risiko gagal tinggi (karena bisa keluar cairan pra-ejakulasi yang mengandung sperma).
- Tidak melindungi dari PMS.
- Efektifitas bergantung pada kesetiaan pasangan untuk melakukan
- Memutus kenikmatan dalam berhubungan seksual

e. Metode KB ini dapat di gunakan PUS untuk :

- Pria yang ingin berpartisipasi aktif dalam KB
- Pasangan yang membutuhkan kontrasepsi dengan segera
- Pasangan yang melakukan hubungan seksual tidak teratur
- Pasangan yang memerlukan metode sementara sambil menunggu metode yang lain

f. Metode KB ini tidak dapat di gunakan PUS untuk :

- Pria dengan pengalaman ejakulasi dini
- Pria yang memiliki kelainan fisik atau kelainan psikologis
- Pria yang sulit melakukan senggama terputus
- Pasangan yang kurang dapat saling bekerja sama dan komunikasi

4. ASI Eksklusif (Metode Amenore Laktasi / MAL)

a. Pengertian:

MAL merupakan kontrasepsi yang mengandalkan pemberian Air susu ibu, efektif sampai 6 bulan. Salah satu metode kontrasepsi sederhana dan alami yang memanfaatkan menyusui eksklusif sebagai cara untuk menunda kehamilan. Metode ini bekerja dengan mengandalkan efek hormon prolaktin

yang diproduksi selama menyusui, yang dapat menekan ovulasi dan mencegah kehamilan. Metode ini paling cocok untuk ibu yang ingin menggunakan kontrasepsi alami pasca-melahirkan dan dapat menyusui secara eksklusif. Setelah bayi berusia lebih dari 6 bulan, disarankan untuk beralih ke metode KB lain.

- b. Cara kerja: Ibu menyusui eksklusif selama 6 bulan setelah melahirkan, yang secara alami menekan atau menunda ovulasi.
- c. Syarat keberhasilan:
 - Bayi usia <6 bulan.
 - Ibu menyusui secara eksklusif (tidak memberikan makanan tambahan dan tidak memberikan susu formula, atau cairan lain selain ASI), dengan frekuensi minimal 8-12 kali sehari termasuk malam hari.
 - Belum haid sejak melahirkan (*amenorea postpartum*).
- d. Kelebihan:
 - Alami dan tanpa efek samping sistemik
 - Tidak mengganggu senggama
 - Tidak perlu obat atau alat
 - Tanpa biaya
 - Tidak perlu pengawasan medis
- e. Keuntungan bagi ibu dan Bayi:
 - Bagi Ibu: mengurangi perdarahan pasca persalinan, mengurangi anemia, meningkatkan hubungan psikologik ibu dan bayi
 - Bagi Bayi: mendapatkan Asupan ASI yang merupakan sumber gizi yang sempurna untuk tumbuh kembang bayi, mendapatkan kekebalan pasif, terhindar dari keterpaparan terhadap kontaminasi susu formula
- f. Keterbatasan:
 - Tidak bisa digunakan jangka panjang.
 - Perlu persiapan sejak kehamilan dan segera menyusui dalam waktu 30 menit paska persalinan.
 - Tidak melindungi terhadap IMS termasuk virus hepatitis B dan HIV/AIDS
 - Sulit dilaksanakan karena kondisi sosial

B. Konsep Kontrasepsi Alami

1. Pengertian

Kontrasepsi alamiah adalah cara mencegah kehamilan tanpa menggunakan bahan kimia, alat, dan obat tetapi mengamati tanda-tanda alami masa subur dan tidak subur wanita. Metode ini mengandalkan kerja sama dan kesadaran pasangan usia subur atau suami istri dalam mengatur waktu hubungan seksual

agar tidak terjadi pembuahan. Kontrasepsi ini dilakukan dengan cara mengetahui kapan seorang wanita sedang subur dan tidak subur, kemudian melakukannya pada masa subur bila ingin hamil dan menghindari hubungan seksual pada masa subur bila tidak ingin hamil.

2. Macam-Macam Metode Kontrasepsi Alamiah

a Metode Simtothermal

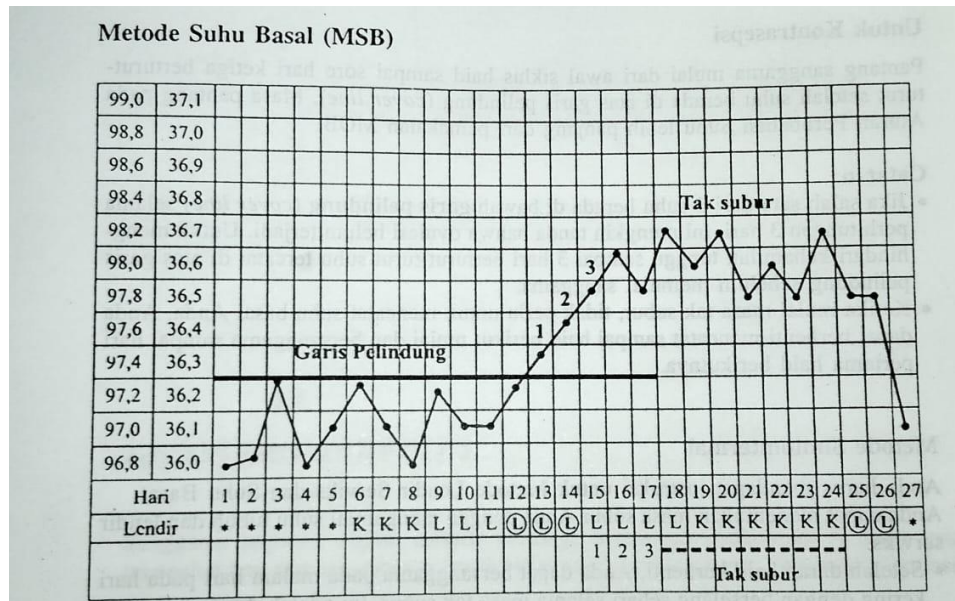
adalah metode KB alamiah yang menggabungkan beberapa indikator kesuburan untuk menentukan masa subur dan tidak subur dalam siklus menstruasi. Metode ini lebih akurat dibandingkan metode tunggal karena menggabungkan berbagai tanda tubuh.

1) Cara Kerja Metode Simtothermal

Metode ini mengandalkan tiga indikator utama:

a) Suhu Basal Tubuh (SBT)

Suhu tubuh diukur setiap pagi pada waktu yang sama setiap pagi dengan termometer basal. Cara mengukur suhu basal tubuh yaitu setiap pagi (sebelum bangkit dari tempat tidur) setelah itu catat suhu pada kartu yang disediakan oleh petugas kesehatan. Catatan suhu pada kartu tersebut untuk 10 hari pertama dari siklus haid anda untuk menentukan suhu tertinggi dari suhu normal, rendah (misalnya catatan suhu harian pada pola tertentu tanpa suatu kondisi luar biasa) abaikan bila suhu tubuh tinggi yang disebabkan oleh demam. Tarik garis pada 0,05 sampai 0,1 °C diatas suhu tertinggi dari 10 hari tersebut inilah yang dinamakan garis pelindung atau garis suhu. Masa tidak subur mulai pada sore setelah hari ketiga berturut turut suhu berada diatas garis pelindung. Setelah ovulasi, suhu tubuh meningkat sekitar **0,2–0,5°C** akibat peningkatan hormon progesteron.



Gambar 7.1: Metode Suhu Basal

Keterangan K: (Kering) menandakan perasaan kering

L: Menandakan lendir tidak subur (kental, putih keruh dan lengket

*: Menandakan perdarahan atau haid

LO: Memperlihatkan lendir subur (basah, jernih, licin dan mulur)

b) Lendir Serviks

- Sebelum ovulasi, lendir serviks bertekstur lengket dan keruh.
- Saat ovulasi, lendir menjadi lebih jernih, licin, dan elastis seperti putih telur mentah.
- Setelah ovulasi, lendir mengering atau menjadi lebih kental.

c) Perubahan Posisi Serviks

- Saat masa subur, serviks menjadi lebih lunak, terbuka, dan lebih tinggi.
- Setelah ovulasi, serviks kembali lebih keras, tertutup, dan turun lebih rendah.

2) Keunggulan Metode Simtothermal

- a) Lebih akurat dibanding metode kalender atau metode tunggal lainnya.
- b) Tidak menggunakan obat atau alat kontrasepsi hormonal.
- c) Dapat digunakan untuk merencanakan atau mencegah kehamilan.

3) Kelemahan Metode Simtothermal

- a) Tidak melindungi dari infeksi menular seksual
- b) Membutuhkan disiplin tinggi dalam pencatatan suhu dan perubahan tubuh setiap hari.

- c) Bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti stres, penyakit, atau perubahan gaya hidup.

b Metode KB MOB (Metode Ovulasi Billings)

Metode ini digunakan untuk mencegah tanpa menggunakan alat atau obat kontrasepsi dan merencanakan kehamilan. Metode Lendir Serviks atau *Metode Ovulasi Billings* (MOB) adalah salah satu metode kontrasepsi alami yang mengandalkan pengamatan lendir serviks untuk menentukan masa subur dan tidak subur dalam siklus menstruasi. Metode ini cocok untuk wanita yang ingin menggunakan KB alami dan memiliki siklus menstruasi yang cukup teratur.

1) Cara Kerja Metode MOB

a) Mengamati Lendir Serviks

- Setiap hari, wanita perlu memperhatikan perubahan kelenturan lendir serviks, tekstur dan warna.
- Setelah menstruasi: Lendir sedikit atau tidak ada (fase kering, tidak subur).
- Menjelang ovulasi: Lendir mulai muncul, kental, dan lengket (kesuburan mulai meningkat).
- Saat ovulasi: Lendir menjadi jernih, licin, elastis seperti putih telur mentah, menandakan masa paling subur.
- Setelah ovulasi: Lendir mengering atau menjadi kental kembali (fase tidak subur).

b) Menentukan Masa Subur

- Jika ingin mencegah kehamilan, pasangan harus menghindari hubungan seksual pada masa lendir subur (elastis, licin, jernih,).
- Jika ingin merencanakan kehamilan, pasangan dianjurkan berhubungan saat lendir subur muncul.

2) Metode Ovulasi Billing

Awal Siklus: 4-4-1998																													
Hari ke:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Tanggal	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1/5	2
Kode	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••

Awal Siklus: 2-5-1998																													
Hari ke:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Tanggal	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
Kode	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••

Keterangan:

- Awal siklus: Perdarahan Haid atau Saat tak terduga: Perdarahan lain
- Titik Perubahan/Perkembangan:
 - 1. Rasa licin, semakin licin
 - 2. Ada lendir: Cair, jernih, mulur
- | Hari-hari setelah Haid:
 - 1. Rasa kering
 - 2. Tidak ada lendir sama sekali
- "Puncak" (Dekat dengan Ovulasi)
 - 1. Rasa licin terakhir
 - 2. Ada lendir (biasanya): Bening, mulur, encer, terakhir
- = Hari-hari setelah Haid:
 - 1. Rasa kering
 - 2. Ada lendir: lekat, kental
- | | | Tiga hari setelah "Puncak"
 - 1. Rasa kering
 - 2. Tidak ada lendir sama sekali

Gambar 7.2: Metode Ovulasi Billing

3) Kelebihan Metode MOB

- Tidak memerlukan alat atau obat kontrasepsi.
- Tidak memiliki efek samping hormon.
- Membantu wanita memahami siklus kesuburan mereka.
- Dapat digunakan untuk merencanakan atau mencegah kehamilan.

4) Kekurangan Metode MOB

- Membutuhkan kedisiplinan tinggi dalam mengamati lendir serviks setiap hari.
- Kurang efektif jika wanita memiliki infeksi vagina atau lendir yang sulit dikenali.
- Tidak melindungi dari infeksi menular seksual.
- Efektivitas lebih rendah dibandingkan dengan kontrasepsi hormonal atau IUD (sekitar 77-88% dalam pencegahan kehamilan).

c Metode KB Coitus Interruptus (Senggama Terputus)

1) Pengertian

Coitus interruptus dikenal sebagai senggama terputus, adalah metode kontrasepsi alami di mana pria menarik penis dari vagina sebelum ejakulasi untuk mencegah sperma masuk ke dalam rahim. Metode ini bertujuan untuk menghindari pembuahan dan kehamilan. Metode ini cocok untuk pasangan

usia subur, yang tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi tetapi siap menerima risiko kehamilan lebih tinggi dibanding metode lain.

2) Cara Kerja Metode Coitus Interruptus

- a) Pria harus menarik penis keluar dari vagina sebelum ejakulasi untuk memastikan sperma tidak masuk ke dalam saluran reproduksi wanita.
- b) Harus dilakukan dengan kontrol diri yang baik, karena kesalahan kecil dapat meningkatkan risiko kehamilan.
- c) untuk meningkatkan efektivitasnya. Bisa dikombinasikan dengan metode lain, seperti metode kalender atau kondom,

3) Keunggulan Metode Coitus Interruptus

- a) Tidak memerlukan alat atau obat kontrasepsi.
- b) Tidak memiliki efek samping hormon.
- c) Dapat dilakukan kapan saja tanpa persiapan khusus.
- d) Gratis dan mudah diterapkan.

4) Kelemahan Metode Coitus Interruptus

- a) Kurang efektif dibanding metode kontrasepsi lain karena adanya kemungkinan kebocoran sperma sebelum ejakulasi (dari cairan pra-ejakulasi).
- b) Membutuhkan kontrol dan kepekaan tinggi dari pria untuk menarik penis tepat waktu.
- c) Tidak melindungi dari infeksi menular seksual (IMS).
- d) Tingkat kegagalan cukup tinggi (sekitar 22% dalam penggunaan umum), yang berarti dari 100 pasangan yang mengandalkan metode ini, sekitar 22 di antaranya bisa mengalami kehamilan dalam setahun.

d Metode KB Kalender

1) Pengertian

Metode ini dikenal sebagai metode ritme adalah salah satu metode kontrasepsi alami yang digunakan untuk merencanakan kehamilan atau mencegah kehamilan dengan mengandalkan perhitungan siklus menstruasi. Metode ini bekerja dengan memperkirakan masa subur berdasarkan riwayat siklus menstruasi sebelumnya.

2) Cara Kerja Metode Kalender

a) Mencatat Siklus Menstruasi

- Wanita perlu mencatat panjang siklus menstruasi selama setidaknya 6 bulan untuk mengetahui pola siklusnya.
- Siklus dihitung dari hari pertama haid hingga hari pertama haid berikutnya.

b) Menentukan Hari Subur

- Hari pertama masa subur: Panjang siklus terpendek dikurangi 18 hari.
 - Hari terakhir masa subur: Panjang siklus terpanjang dikurangi 11 hari.
 - Contoh:
 - Jika siklus terpendek adalah 26 hari, maka $26 - 18 =$ hari ke-8 (mulai masa subur). Jika siklus terpanjang adalah 30 hari, maka $30 - 11 =$ hari ke-19 (akhir masa subur).
 - Maka, masa subur berada di antara hari ke-8 hingga hari ke-19.
 - Menghindari Hubungan Seksual pada Masa Subur
 - Pasangan harus menghindari hubungan seksual pada hari-hari subur atau menggunakan metode tambahan seperti kondom.
 - Jika ingin merencanakan kehamilan, pasangan dianjurkan berhubungan pada masa subur.
- 3) Kelebihan Metode KB Kalender
- a) Dapat digunakan untuk merencanakan atau mencegah kehamilan.
 - b) Biaya murah atau bahkan gratis.
 - c) Tidak memerlukan alat atau obat kontrasepsi.
 - d) Tidak memiliki efek samping hormonal.
- 4) Kekurangan Metode KB Kalender
- a) Kurang efektif jika siklus menstruasi tidak teratur.
 - b) Efektivitas lebih rendah dibanding metode kontrasepsi lain (efektivitas sekitar 75-87%).
 - c) Membutuhkan pencatatan yang disiplin dan konsisten.
 - d) Tidak melindungi dari infeksi menular seksual.

C. Konsep Kontrasepsi Modern

1. Pengertian

Konsep Kontrasepsi Modern mengacu pada berbagai metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan secara efektif, aman, dan dapat dikendalikan oleh individu atau pasangan. Kontrasepsi modern bertujuan untuk memberikan kebebasan dalam merencanakan kehamilan, menjaga kesehatan reproduksi, serta mendukung pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup.

2. Karakteristik Kontrasepsi Modern

- a Efektivitas tinggi dalam mencegah kehamilan.
- b Reversibel (kebanyakan), artinya kesuburan dapat kembali setelah penggunaan dihentikan.
- c Aman digunakan dalam jangka panjang.

- d Beragam pilihan sesuai kebutuhan dan kondisi medis individu.
- e Dapat digunakan oleh pria maupun wanita.

3. Jenis-Jenis Kontrasepsi Modern

Tabel 7.1: Jenis Kontrasepsi Modern

Kategori	Jenis Metode	Keterangan Singkat
Hormonal	- Pil KB	Mengandung hormon estrogen & progesteron
	- Suntik KB (1 bulan / 3 bulan)	Mengatur ovulasi dan menstruasi
	- Implan (susuk KB)	Ditanam di bawah kulit, efektif hingga 3–5 tahun
Non-hormonal	- IUD (Alat Dalam Rahim) – tembaga	Menghambat pembuahan dan implantasi
Penghalang (Barrier)	- Kondom pria / wanita	Mencegah sperma masuk ke rahim, juga cegah IMS
Metode permanen	- Sterilisasi pria (vasektomi)	Pemotongan saluran sperma
	- Sterilisasi wanita (tubektomi)	Pemotongan saluran tuba falopi
Metode modern alami	- Kalender / ovulasi / pantang berkala	Berdasarkan siklus menstruasi
Kontrasepsi darurat	- Pil kontrasepsi darurat	Digunakan dalam 72 jam setelah hubungan seksual

4. Tujuan Penggunaan Kontrasepsi Modern

- a Menunda kehamilan pertama.
- b Menjarakkan kelahiran anak.
- c Mengakhiri kesuburan secara permanen (bagi yang sudah cukup anak).
- d Melindungi kesehatan ibu dan anak.
- e Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

5. Pertimbangan dalam Memilih Kontrasepsi

- a Usia dan kondisi kesehatan.
- b Frekuensi hubungan seksual.
- c Keinginan memiliki anak lagi.
- d Efek samping yang mungkin muncul.
- e Kemudahan penggunaan.
- f Ketersediaan dan akses layanan.

Kontrasepsi modern berbeda dari metode tradisional seperti **coitus interruptus (senggama terputus)** atau **ramuan herbal**, yang efektivitasnya jauh lebih rendah dan tidak disarankan sebagai metode utama.

D. Kontrasepsi Darurat (Emergency Contraception)

1. Pengertian

Kontrasepsi Metode darurat adalah kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan setelah terlanjur melakukan hubungan seksual tanpa pelindung atau ketika metode kontrasepsi lain gagal (misalnya kondom bocor, lupa minum pil KB, atau pemerkosaan). Metode ini sering di sebut dengan kontrasepsi pasca senggama atau *morning after pill* atau *morning after treatmen*. mengusahakan agar sel telur yang telah di buahi tidak sampai menempel kedinding rahim dan berkembang menjadi janin. Metode darurat ini menekankan juga bahwa cara KB ini lebih baik dari pada tidak sama sekali.

Kontrasepsi darurat harus dipertimbangkan untuk wanita yang dalam lima hari setelah hubungan sex tanpa kondom atau tidak terlindungi dengan baik tetapi tidak ingin hamil. Pemasangan AKDR tembaga dapat dilakukan hingga tujuh hari setelah hubungan seksual. Mekanisme Kerja Kontrasepsi Darurat Tidak terdapat mekanisme tunggal, mode mekanisme bervariasi sesuai dengan hari siklus menstruasi saat hubungan seksual terjadi, waktu dalam siklus menstruasi bahwa kontrasepsi darurat diberikan, dan jenis kontrasepsi darurat yang digunakan. rejimen khusus *levonorgestrel* (LNG) dan *Ulipristal asetat* (UPA) telah terbukti menghambat atau menunda ovulasi. LNG menunda perkembangan folikel ketika diberikan sebelum tingkat LH meningkat sedangkan UPA menghambat rupturfolikel bahkan setelah tingkat LH mulai meningkat. Tinjauan bukti menunjukkan bahwa kontrasepsi darurat tidak mungkin mencegah implantasi sel telur yang dibuahi. AKDR tembaga mencegah pembuahan dengan memengaruhi viabilitas dan fungsi sperma hal ini dapat mempengaruhi memengaruhi oosit dan endometrium.

2. Tujuan Kontrasepsi Darurat

- a Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan.
- b Memberi perlindungan dalam situasi darurat atau tidak terduga.

3. Waktu Penggunaan

- a Semakin cepat digunakan, semakin efektif.
- b Idealnya digunakan dalam waktu 24 jam setelah hubungan seksual, tetapi masih bisa digunakan hingga 72 jam (3 hari), dan dalam beberapa kasus hingga 120 jam (5 hari) tergantung jenisnya.
- c Lupa minum pil KB lebih dari 2 hari.

- d Kondom bocor, lepas, atau digunakan tidak benar.
- e Tidak menggunakan kontrasepsi sama sekali.
- f Terjadi pemerkosaan.

Tabel 7.2: Jenis Kontrasepsi Darurat

Jenis	Cara Kerja	Waktu Efektif	Efektivitas
Pil Kontrasepsi Darurat (Postinor) Dosis 2 X 1	Mengandung hormon levonorgestrel yang mencegah ovulasi dan pembuahan	Hingga 72 jam setelah hubungan, dosis ke dua 12 jam kemudian	52–94%
Pil Ulipristal Acetate (EllaOne)	Menghambat ovulasi meski telah mendekati masa subur	Hingga 120 jam (5 hari)	>85%
IUD tembaga sebagai kontrasepsi darurat (satu kali pemasangan)	Mencegah pembuahan dan implantasi jika dipasang setelah hubungan	Hingga 5 hari setelah hubungan	>99% (paling efektif)

Catatan Penting

- Bukan pengganti metode kontrasepsi rutin.
- Tidak menggugurkan kandungan. Kontrasepsi darurat tidak bekerja jika kehamilan sudah terjadi.
- Bisa menyebabkan efek samping ringan, seperti mual, pusing, perubahan siklus menstruasi.
- Tidak melindungi dari infeksi menular seksual (IMS).
- Dapat dibeli di apotek tanpa resep di banyak negara, tapi ketersediaannya tergantung kebijakan lokal.

E. Pelayanan Kontrasepsi Pasca Aborsi (Kondom,Pil,Suntik)

Pelayanan kontrasepsi pasca keguguran terdiri dari konseling tentang kontrasepsi, informasi tentang perlindungan terhadap IMS, jaminan ketersediaannya pasokan kontrasepsi. Waktu mulai kontrasepsi pasca keguguran di mulai segera karena ovulasi dapat terjadi 11 hari sesudah pasca keguguran. Klien perlu mendapatkan konseling dan informasi agar mereka mengerti bahwa klien dapat hamil segra sebelum haid berikutnya datang, ada kontrasepsi yang aman untuk menunda atau mencegah kehamilan, bagaimana klien dapat memperoleh pelayanan KB pasca keguguran.

Tabel 7.3: Metode kontrasepsi pasca keguguran

Metode Kontrasepsi	Ciri khusus	Waktu mulai penggunaan	konseling
Kondom	Metode sementara sambil menunggu metode lain	Mulai segera sewaktu waktu mulai hubungan seksual	
Pil kombinasi	Dapat segera di mulai walaupun terdapat infeksi	Segera mulai	Jika konseling belum cukup. berikan metode sementara.
Kontrasepsi progestin	Sangat efektif	Segera mulai	
Suntikan kombinasi	Langsung efektif	Segera mulai	
AKDR	Langsung efektif	Segera diberikan dalam 7 hari pertama pasca keguguran	Jika konseling belum cukup. berikan metode sementara.

Catatan penting Kontrasepsi pasca Keguguran:

Semua jenis KB dapat segera di berikan dalam 7 hari pertama pasca keguguran

F. Latihan

Latihan Soal

- Seorang perempuan datang ke PMB, umur 29 tahun memiliki 2 anak, dengan maksud ingin berkonsultasi program KB metode alami pengamatan Suhu Tubuh Dasar (SBT) . Hasil pemeriksaan KU baik, BB ; 59 kg. TB 155 cm, TD : 120/60 mmhg, N : 80 x/menit, S: 36,5 °C, P: 20 x/menit,. Anamnesa : ibu tidak pernah ada Riwayat penyakit menular ataupun menahun. Salah satu konseling yg harus di berikan diantaranya suhu tubuh Wanita biasanya akan meningkat pada saat ?
 A. Menstruasi dimulai
 B. Ovulasi terjadi
 C. Siklus menstruasi selesai
 D. Hubungan seksual
 E. Sebelum menstruasi
- Seorang perempuan datang ke Praktek Mandiri Bidan . Hasil anamnesa sudah menikah selama 5 tahun dan memiliki dua anak. Tidak ingin menambah anak dalam waktu dekat dan memutuskan untuk menggunakan metode KB alamiah Metode Simtothermal. Berikut ini adalah cara

- Kerja Metode Simtothermal yang mengandalkan tiga indikator utama, antara lain
- A. Suhu Basal Tubuh (SBT), lendir serviks dan perubahan posisi serviks
 - B. Suhu Basal Tubuh (SBT), lendir serviks dan metode Kalender
 - C. Lendir cerviks, MAL dan metode Kalender
 - D. Lendir cerviks, MAL dan metode Kalender
 - E. Mentukan masa subur, metode kalender, lendir cerviks
3. Seorang perempuan umur 24 tahun memiliki 1 anak, datang ke PMB dengan maksud ingin berkonsultasi program KB metode kontrasepsi alami senggama terputus. Hasil pemeriksaan KU baik, BB ; 57 kg. TB 152 cm, TD : 120/80 mmhg, N: 80 x/menit, S: 36,7 °C, P: 20 x/menit,. Anamnesa : ibu tidak pernah ada Riwayat penyakit menular ataupun menahun. Salah satu konseling yg harus di berikan adalah cara kerja metode Coitus interruptus antara lain:
- A. Pria harus menarik penis keluar dari vagina sebelum ejakulasi untuk memastikan sperma tidak masuk ke dalam saluran reproduksi Wanita bertujuan untuk menghindari kehamilan.
 - B. Tidak Selalu dilakukan dengan kontrol diri yang baik, karena kesalahan kecil dapat meningkatkan risiko kehamilan.
 - C. Tidak Bisa dikombinasikan dengan metode lain, seperti metode kalender atau kondom,
 - D. Tidak Bisa dikombinasikan dengan metode lain, seperti metode kalender atau kondom
 - E. Pria harus menarik penis keluar dari vagina setelah ejakulasi untuk memastikan sperma tidak masuk ke dalam saluran reproduksi Wanita
4. Seorang perempuan datang ke PMB, umur 27 tahun memiliki 1 anak, dengan maksud ingin berkonsultasi program KB metode alami pengamatan Suhu Tubuh Dasar (SBT) . Hasil pemeriksaan KU baik, BB ; 59 kg. TB 155 cm, TD : 120/60 mmhg, N : 80 x/menit, S: 36,5 °C, P: 20 x/menit,. Anamnesa : ibu tidak pernah ada Riwayat penyakit menular ataupun menahun. Berikut ini cara mengukur suhu basal yang tepat?
- A. Cara mengukur suhu basal tubuh yaitu setiap pagi (sebelum bangkit dari tempat tidur)
 - B. Cara mengukur suhu basal tubuh yaitu setiap pagi (setelah bangkit dari tempat tidur)
 - C. Cara mengukur suhu basal tubuh yaitu setiap sore (sebelum bangkit dari tempat tidur)

- D. Cara mengukur suhu basal tubuh yaitu setiap sore (setelah bangun dari tempat tidur)
 - E. Cara mengukur suhu basal tubuh yaitu setiap malam (sebelum bangun dari tempat tidur)
5. Seorang perempuan datang ke TPMB, dengan maksud ingin berkonsultasi program KB Kontrasepsi Darurat. Hasil pemeriksaan KU baik, BB ; 60 kg. TB 158 cm, TD : 120/60 mmHg, N : 80 x/menit, S: 36,5 °C, P: 20 x/menit,. Anamnesa : ibu tidak pernah ada Riwayat penyakit menular ataupun menahun. Salah satu konseling yg harus di berikan kepada ibu diantaranya?
- A. Idealnya digunakan dalam waktu 24 jam setelah hubungan seksual
 - B. Masih bisa digunakan hingga 72 jam (3 hari)
 - C. Beberapa kasus hingga 120 jam tergantung jenisnya.
 - D. 5 hari tergantung jenisnya.
 - E. Benar semua

Kunci Jawaban

- 1. B
- 2. A
- 3. A
- 4. A
- 5. E

G. Rangkuman Materi

Buku ini menjelaskan Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program dalam bidang kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk membantu pasangan suami istri merencanakan waktu kelahiran anak, jumlah dan jarak. Melalui program KB, keluarga dapat mengatur kehamilan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi, kesiapan fisik, mental sehingga kualitas hidup keluarga dapat meningkat. Materi dalam buku dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Pengertian: Kontrasepsi adalah menghindari terjadinya kehamilan akibat pertemuan sel telur matang dengan sel sperma.. KB juga berperan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta mengurangi risiko kehamilan yang terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering, atau terlalu dekat jaraknya. Dengan perencanaan yang baik, pasangan dapat menciptakan keluarga yang lebih sehat, sejahtera, dan harmonis.

2. Macam-Macam Metode Kontrasepsi

Buku menjelaskan berbagai metode kontrasepsi, antara lain:

- Metode Sederhana: kondom, pantang berkala, senggama terputus, ASI eksklusif
- Alami: Metode Simtothermal (Suhu Basal Tubuh), Lendir serviks, Perubahan Posisi Serviks, kalender, MOB, senggama terputus
- Modern: Metode Hormonal: seperti pil, suntik, dan implan. Metode Non-Hormonal: seperti IUD dan kondom, permanen (Tubektomi dan Vasektomi)
- Kontrasepsi Darurat: Pil kontrasepsi darurat
- Pelayanan Kontrasepsi Pasca Aborsi (Kondom, Pil, Suntik)

3. Pemilihan Metode KB

Pemilihan metode kontrasepsi Keluarga Berencana harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan, usia, jumlah anak, dan rencana kehamilan pasangan. Buku juga menekankan pentingnya ilmu dasar konseling tentang metode kontrasepsi antara petugas kesehatan dan akseptor sebelum memilih metode KB.

4. Kelebihan dan Kekurangan

Kontrasepsi Dengan Metode Sederhana, Alami memiliki Kekurangan yaitu Resiko kehamilan lebih tinggi jika di bandingkan Metode Modern Dan Kontrasepsi Darurat. Beberapa metode KB memiliki efek samping ringan seperti perubahan haid, berat badan, atau mual. Petugas kesehatan perlu memberi penjelasan agar akseptor tidak takut atau salah persepsi terhadap KB.

5. Peran Petugas Kesehatan dan Masyarakat.

Kontrasepsi modern bertujuan untuk memberikan kebebasan dalam merencanakan kehamilan, menjaga kesehatan reproduksi, serta mendukung pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup. Pasangan usia Subur diharapkan mendukung program KB sebagai bagian dari pembangunan nasional.

H. Glosarium

Non-Invasif: metode yang tidak memerlukan sayatan pada tubuh dan tidak memerlukan penetrasi.

Daur: peredaran, sistem yang kondisinya bisa berulang atau proses rangkaian penahanan yang di lalui makhluk hidup.

Poliuretan: plastik atau karet sintetis yang sifatnya bisa sangat lentur, elastis, atau keras, tergantung pada cara pembuatannya.

Ejakulasi: proses keluarnya cairan semen yang mengandung sperma dari penis

Ovulasi: proses pelepasan sel telur yang sudah matang dari indung telur (ovarium) ke tuba falopi, yang terjadi selama siklus menstruasi dan merupakan bagian dari masa subur wanita

Lateks: getah kental mirip susu yang di hasilkan oleh berbagai tumbuhan terutama pohon karet serta beberapa jamur yang di gunakan untuk membuat produk karet alami seperti ban, balon, dan sarung tangan

Senggama: hubungan seksual berupa masuknya penis ke dalam vagina

Sistemik: berkaitan dengan, mempengaruhi, seluruh system atau bagian besar dari sebuah sistem

Anemia: kondisi di mana tubuh mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah yang ada di dalam tubuh berada di bawah batas normal

kekebalan pasif: kekebalan tubuh yang diperoleh seseorang dari luar tubuhnya, bukan dibentuk sendiri oleh sistem kekebalan tubuhnya. Artinya, antibodi sudah jadi dan langsung diberikan kepada individu, sehingga dapat memberikan perlindungan secara cepat.

Metode: cara kerja sistematis untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan

Aborsi: suatu tindakan medis yang bertujuan mengakhiri kehamilan

I. Referensi

- Adam, Muhammad Zikri (2024). Analisis yuridis terhadap penjualan alat kontrasepsi kondom di Indonesia: Perspektif Masalah Mursalah. Etheses. universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/63791/>
- Erna Suparman. 2021. Kontrasepsi Darurat dan Permasalahannya. Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/msj/article/view/34908/33229>. Medical Scope Journal (MSJ). 2021;3(1):94-104
- Ikatan Bidan Indonesia. Materi TOT Pelatihan Midwifery Update Tahun 2021. Pengurus Daerah IBI Jawa Timur
- Jitowiyono, S., & Rouf, M. A. (2019). Keluarga berencana (KB) dalam perspektif bidan. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru
- Maryani, 2017, Pelayanan Keluarga Berencana dan cetakan I, Trans Info Media, Jakarta. Melani, N, 2017, Pelayanan Keluarga Berencana Pelayanan KB, Kontrasepsi,
- Nelly Frida Manurung 1, Epimae Halawa. 2023. Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Kb Kalender Di Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal Periode Mei-Juni Tahun 2021. Evidence Based Journal (EBJ) Volume: 4 | Edisi: 1 | Hal. 160-167 Terbitan: April 2023 e-ISSN: 2722-8355; p-ISSN: 27457702 file:///C:/Users/win10/OneDrive/Documents/160-167+TINGKAT+PENGETAHUAN+IBU+TENTANG+KB+KALENDER.pdf
- Novita Diah Ayuni Kumala Sugianto, Rafidah, Isnaniah, Megawati. 2024. Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Suami Dengan Penggunaan Kontrasepsi Kondom

Pada Pria Di Puskesmas Darul Azhar Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024.
Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)
ipssj.comippsj2024@gmail.comE-ISSN: 3064-
4011.<https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/66/68>

Pinem, S, 2017, Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi, cetakan I, Trans Info Media
Jakarta Prawiroharjo, S, 2017, Ilmu Kandungan, cetakan kelima, Yayasan Bina
Pustaka Jakarta.

Saifuddin Bari A.2016.Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi.Yayasan Bina
Pustaka Sarwono Prawirohardjo.Jakarta

PROFIL PENULIS



Bdn. Rizki Amalia, SST., M.Kes.

merupakan dosen tetap dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Kader Bangsa Palembang. Penulis adalah bidan profesional yang memiliki kepakaran di bidang kesehatan reproduksi dan pelayanan kebidanan komunitas. Lahir di Palembang pada 1 Agustus 1988, Penulis menyelesaikan pendidikan DIV Kebidanan pada tahun 2010, meraih gelar Magister Kesehatan pada tahun 2015, dan menuntaskan program profesi bidan pada tahun 2023. Dalam aktivitas akademiknya, Penulis mengampu mata kuliah Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi, Asuhan Kebidanan Komunitas, serta Asuhan Kebidanan Perempuan dan Anak dalam Kondisi Rentan. Fokus risetnya mencakup upaya preventif dan promotif kesehatan ibu dan anak, dengan penekanan pada kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan kontrasepsi. Kontak korespondensi dapat dilakukan melalui email: ramdhanilist@gmail.com.

Dhiahdwi Kusumawati, S.ST., Bdn., MPH. Lahir di Cilacap, 08 Desember 1985.



Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Kebidanan di STIKES AL-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap lulus tahun 2007. Jenjang DIV Kebidanan pada Program Studi Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Ibu Dan Anak pada Universitas Sebelas Maret dan lulus tahun pada tahun 2015. Melanjutkan Profesi Kebidanan Di Universitas Al-Irsyad Cilacap lulus pada tahun 2023 Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2008 sebagai asisten dosen di STIKES AL-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap. Saat ini penulis bekerja di Universitas Al-Irsyad Cilacap mengampu mata kuliah Kesehatan Perempuan Dan Perencanaan KB, Asuhan Kebidanan Pra Nikah Dan Pra Konsepsi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan aktif di organisasi IBI. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dhiahdwi@gmail.com

Motto: *Khoiru jaliisin fii az zamaani kitaabun. (Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku)*

PROFIL PENULIS



Indah Kusmindarti, SST., Bd., M.Kes Lahir di Jombang, 11 Juli 19XX. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Kebidanan di Universitas Kadiri tahun 2006. S2 Kesehatan di Universitas Negeri Surakarta tahun 2011 dan Profesi Bidan pada Program Studi Pendidikan Bidan Universitas Bina Sehat PPNI tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995-1996 di RSI Sakinah Mojokerto, tahun 1997- 2000 sebagai bidan PTT di Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Membuka layanan PMB mulai 2000-

sekarang di Jombang Jawa Timur. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto mulai tahun 2005- sekarang. Home base pada Prodi Pendidikan Profesi Bidan, mengampu mata kuliah KDPK, Asuhan Kebidanan Pada Persalinan, KB dan Komplementer. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: indahk903@gmail.com

Erma Puspita Sari, SST., Bdn., M.Kes.

adalah dosen tetap sekaligus Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Universitas Kader Bangsa Palembang. Ia merupakan bidan profesional yang menekuni bidang kesehatan reproduksi dan KB serta pelayanan pasca persalinan. Lahir di Sekayu pada 16 Agustus 1988, ia menyelesaikan pendidikan DIV Kebidanan pada tahun 2010, meraih gelar magister kesehatan pada tahun 2012, dan menuntaskan program profesi bidan pada

tahun 2022. Ia aktif mengajar mata kuliah KB dan Pelayanan, Asuhan Kebidanan Nifas, serta Asuhan Kebidanan pada Kehamilan. Fokus risetnya mencakup upaya meningkatkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang, dengan penekanan pada kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan kontrasepsi. Penulis dapat dihubungi melalui email: ermapuspitasari88@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Lida Khalimatus Sa'diya, SSiT.,Bd., M.Kes, lahir di Sidoarjo tahun 1980. Penulis merupakan dosen Program Studi Sarjana Kebidanan Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto. Penulis menempuh Pendidikan perguruan tinggi pada program D-III Kebidanan di Akademi Kebidanan Siti Khodijah Sepanjang Sidoarjo (2001), D-IV Bidan Pendidik di Universitas Gadjra Mada Yogyakarta (2005) dan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Sebelas Maret Surakarta (2012).

Penulis merupakan anggota IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Cabang Kabupaten Mojokerto. Penulis memiliki concern terhadap issue – issue terkini mengenai kesehatan bayi, balita dan anak serta Keluarga Berencana. Penulis juga sebagai bidan praktek mandiri yang mengembangkan layanan holistik. Penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dimana hasil penelitian telah banyak dipublikasikan ke dalam jurnal penelitian maupun prosiding penelitian yang bereputasi baik berskala nasional maupun internasional. Email: lidarafi2@gmail.com



Nur Saidah,S.SiT.,Bdn.,M.Kes, Lahir di Pasuruan Jawa Timur, 02 Mei 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Program Studi Diploma IV Kebidanan STIKES Ngudi Waluyo Ungaran Semarang Lulus Tahun 2004, selanjutnya melanjutkan S2 Universitas Sebelas Maret Lulus Tahun 2010, Kemudian melanjutkan Profesi Kebidanan STIKES Ngudia Husada Madura lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun Poltekkes Majapahit Mojokerto tahun 2002 – 2014. Akademi kebidanan Ar Rahma Gempol Pasuruan tahun 2015 -2018. STIKES Ngudia Husada Madura Bangkalan saat ini menjadi Universitas Noor Huda Mustofa Bangkalan tahun 2019 –

sekarang. Dalam bidang Organisasi sebagai Pengurus Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 – 2023 dan Masa Bakti 2023 - 2028. Saat ini penulis bekerja di mengampu mata kuliah Pelayanan KB, Berfikir Kritis Dalam Kebidanan, Etika, Hukum dan Perundang-undangan Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi pengabdian masyarakat. Saat ini penulis sebagai Tim Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan. *Training Of Tranier* Pelatihan *Midwifery Update* Pengurus Cabang IBI. Tim pendamping penanganan persalinan dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal Kabupaten Sidoarjo. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nursaidah686@yahoo.com

Motto: "Keep Moving Forward, Never Give Up"

SINOPSIS

Buku Ajar Keluarga Berencana dan Pelayanan menghadirkan kerangka komprehensif yang memadukan landasan konseptual, etika, dan praktik kebidanan dengan kebutuhan layanan keluarga berencana yang berkeadilan. Bab 1 menempatkan keluarga berencana dalam perspektif kebidanan melalui pembahasan konsep, tujuan dan manfaat, landasan filosofis, etik, dan hukum, peran bidan, serta isu hak reproduksi dan gender berikut tantangan dan peluang implementasinya. Bab 2 memperkuat kemampuan pembaca dalam praktik berbasis bukti melalui pemahaman sumber bukti ilmiah, integrasi bukti ke keputusan klinik, keuntungan penerapan, serta hambatan yang perlu diantisipasi agar layanan tetap aman dan efektif.

Bab 3 mengulas jenis dan mekanisme kerja kontrasepsi hormonal dan non hormonal beserta konsep dasar efek samping dan penyulit yang perlu diwaspadai, sehingga bidan dan tenaga kesehatan mampu melakukan deteksi dini serta penatalaksanaan yang tepat. Bab 4 menuntun pembaca menganalisis kriteria kelayakan penggunaan metode kontrasepsi, menyusun perencanaan keluarga yang rasional, memahami perubahan paradigma pelayanan, memanfaatkan rekomendasi kriteria layanan medis, serta melakukan penapisan klien menggunakan KLOP KB untuk menjamin keputusan yang berbasis kebutuhan dan kondisi klien.

Bab 5 memaparkan metode kontrasepsi sederhana tanpa alat, dengan alat barrier, hormonal steroid, mekanik, kimia, hingga pembedahan lengkap dengan cara kerja, indikasi, manfaat, dan risiko, sehingga pembaca dapat membandingkan pilihan secara kritis. Bab 6 berfokus pada keterampilan konseling, mulai dari definisi, tujuan, bentuk dan tahapan komunikasi, langkah konseling, hingga faktor pendukung dan penghambat, termasuk pendekatan metode konseling yang tepat untuk keluarga berencana. Bab 7 mengarahkan implementasi pelayanan kontrasepsi pada metode sederhana, alami, modern, kontrasepsi darurat, serta pelayanan pasca aborsi untuk kondom, pil, dan suntik. Setiap bab dilengkapi latihan atau soal, rangkuman materi, glosarium, dan daftar pustaka untuk memfasilitasi pembelajaran aktif, sementara profil penulis di bagian akhir memberi konteks kompetensi tim penyusun. Buku ini dirancang sebagai rujukan praktis bagi pendidik, mahasiswa, bidan praktik, dan pengelola program untuk mewujudkan layanan keluarga berencana yang aman, bermutu, berpusat pada klien, dan berbasis bukti.

Buku Ajar Keluarga Berencana dan Pelayanan menghadirkan kerangka komprehensif yang memadukan landasan konseptual, etika, dan praktik kebidanan dengan kebutuhan layanan keluarga berencana yang berkeadilan. Bab 1 menempatkan keluarga berencana dalam perspektif kebidanan melalui pembahasan konsep, tujuan dan manfaat, landasan filosofis, etik, dan hukum, peran bidan, serta isu hak reproduksi dan gender berikut tantangan dan peluang implementasinya. Bab 2 memperkuat kemampuan pembaca dalam praktik berbasis bukti melalui pemahaman sumber bukti ilmiah, integrasi bukti ke keputusan klinik, keuntungan penerapan, serta hambatan yang perlu diantisipasi agar layanan tetap aman dan efektif.

Bab 3 mengulas jenis dan mekanisme kerja kontrasepsi hormonal dan non hormonal beserta konsep dasar efek samping dan penyulit yang perlu diwaspadai, sehingga bidan dan tenaga kesehatan mampu melakukan deteksi dini serta penatalaksanaan yang tepat. Bab 4 menuntun pembaca menganalisis kriteria kelayakan

penggunaan metode kontrasepsi, menyusun perencanaan keluarga yang rasional, memahami perubahan paradigma pelayanan, memanfaatkan rekomendasi kriteria layanan medis, serta melakukan penapisan klien menggunakan KLOP KB untuk menjamin keputusan yang berbasis kebutuhan dan kondisi klien.

Bab 5 memaparkan metode kontrasepsi sederhana tanpa alat, dengan alat barrier, hormonal steroid, mekanik, kimia, hingga pembedahan lengkap dengan cara kerja, indikasi, manfaat, dan risiko, sehingga pembaca dapat membandingkan pilihan secara kritis. Bab 6 berfokus pada keterampilan konseling, mulai dari

definisi, tujuan, bentuk dan tahapan komunikasi, langkah konseling, hingga faktor pendukung dan penghambat, termasuk pendekatan metode konseling yang tepat untuk keluarga berencana. Bab 7

mengarahkan implementasi pelayanan kontrasepsi pada metode sederhana, alami, modern, kontrasepsi darurat, serta pelayanan pasca aborsi untuk kondom, pil, dan suntik. Setiap bab dilengkapi latihan atau soal, rangkuman materi, glosarium, dan daftar pustaka untuk memfasilitasi pembelajaran aktif, sementara profil penulis di bagian akhir memberi konteks kompetensi tim penyusun. Buku ini dirancang sebagai rujukan praktis bagi pendidik, mahasiswa, bidan praktik, dan pengelola program untuk mewujudkan layanan keluarga berencana yang aman, bermutu, berpusat pada klien, dan berbasis bukti.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7426-24-6

